LIVE LIFE

国家预防自杀实施指南



北京回龙观医院
北京心理危机研究与干预中心

LIVE LIFE：国家预防自杀实施指南



英文版原著：世界卫生组织
中文版翻译：北京回龙观医院 北京心理危机研究与干预中心

英文题：LIVE LIFE：An implementation guide for suicide prevention in countries

© World Health Organization 2021

中文题：LIVE LIFE：国家预防自杀实施指南

© Beijing Suicide Research and Prevention Center 2022

中文版翻译：安静，杨萌，吴涧蓝
中文版一校：安静，杨萌，吴涧蓝
中文版订正：童若扬
中文版定稿：童永胜
中文版排版：王月华，童永胜

本翻译并非由世界卫生组织完成。世界卫生组织不对翻译的内容以及翻译的准确性负责。原版英文版应为装订正版。

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆许可协议进行许可。

目录

专栏索引.....II
序言.....V
致谢.....VI
内容概要.....IX
引言.....1

A 部分：“LIVE LIFE” 的核心支柱.....8

情况分析.....9
多部门合作.....15
提高意识和宣传.....28
能力建设.....37
财政支持.....45
监测.....52
监控和评估.....62

B 部分：“LIVE LIFE”有效预防自杀的关键干预措施.....67

限制自杀的手段.....68
与媒体互动促其负责任地报道自杀事件.....76
培养青少年的社会情感生活技能.....83
早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人.....89

附录 1. 自杀预防相关部门和利益攸关方.....95
附录 2. 其他国家的更多例子.....97
附录 3. “LIVE LIFE”指标框架.....121
附录 4. 资源.....127
参考文献.....142

专栏索引

专栏 1. 组建指导委员会和工作组 4
专栏 2. 在紧急情况下的自杀预防 6
专栏 3. 捷克：自杀预防的情况分析 12
专栏 4. 纳米比亚：国家自杀研究 13
专栏 5. 爱尔兰：使自杀行为非罪化 15
专栏 6. 苏里南：环境对多部门自杀预防努力的影响 16
专栏 7. 黎巴嫩：将自杀预防纳入精神卫生和药物使用政策 17
专栏 8. 改编以适合地方实施和优先人群 19
专栏 9. 不丹：政府如何促进多部门合作 20
专栏 10. 美国：建立公私伙伴关系 20
专栏 11. 澳大利亚：最高层的影响力 21
专栏 12. 包括有自杀相关经历的人 21
专栏 13. 印度：社区领导，拯救生命 24
专栏 14. 斯里兰卡：总统预防自杀特别工作组 25
专栏 15. 肯尼亚：提高意识创造了对服务的需求 29
专栏 16. 日本：全国自杀意识月 30
专栏 17. 苏格兰：看见我——解决自杀耻感问题 31
专栏 18. 美国：有个坚定而忠诚的旗手 32
专栏 19. 伊拉克：把悲伤变成了对自杀的行动 33
专栏 20. 马来西亚：扩大多部门守门人培训 38
专栏 21. 加纳：法官的能力建设 39
专栏22. 圭亚那：加强卫生人力资源以预防自杀 41
专栏23. 澳大利亚：预防职场自杀的能力建设 42
专栏24. 清单：向国家和地方预算申请资金 48
专栏25. 加纳：慈善家 49
专栏 26. 澳大利亚：国家自杀预防试验 49
专栏27. 斯里兰卡：监测 55
专栏28. 俄罗斯联邦：自伤监测 55
专栏29. 伊朗伊斯兰共和国：自伤和自杀登记系统 58

专栏30. 美国：在白山阿帕奇部落监测.....59
专栏31. 爱尔兰：监控和评估国家自杀预防策略.....65
专栏32. 斯里兰卡：禁止使用高危农药.....70
专栏33. 韩国：一个成功的故事.....74
专栏34. 立陶宛：媒体监测.....76
专栏35. 奥地利：帕帕基诺媒体奖.....77
专栏36. 马来西亚：与媒体合作的成功与挑战.....80
专栏 37. 特立尼达和多巴哥：媒体指南.....80
专栏38. 世界卫生组织《帮助青少年茁壮成长》(HAT).....84
专栏 39. 澳大利亚：针对青少年原住民和托雷斯海峡岛民的循证应用.....85
专栏 40. 瑞典：青年心理健康意识促进(YAM)，从研究到实施.....87
专栏 41. 韩国：针对自杀未遂者的病例管理.....89
专栏 42. 澳大利亚：原住民特有的出院后照护.....92
专栏 43. 伊朗伊斯兰共和国：扩大心理健康服务和自杀预防规模.....93
专栏 44. 澳大利亚：数据分析和探索系统.....97
专栏 45. 伊拉克：全国自杀研究.....98
专栏 46. 阿拉伯叙利亚共和国：情况分析.....98
专栏 47. 巴西：自下而上的多部门合作示例.....100
专栏 48. 加拿大：多部门合作.....101
专栏 49. 俄罗斯联邦：酒精政策和立法.....102
专栏 50. 苏格兰：亲历自杀行为者参与的意义.....102
专栏 51. 澳大利亚：海洋玫瑰——一个为亲历过自杀行为者设立的组织.....104
专栏 52. 美国：整合全国、全政府的方法.....105
专栏 53. 包括东部耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土：自杀预防和管理.....106
专栏 54. 加拿大：提高认识和宣传.....108
专栏 55. 世界精神卫生日和世界自杀预防日.....108
专栏 56. 澳大利亚：适合 LGBTIQ 团体循证的守门人培训.....109
专栏 57. 加拿大：社区守门人培训项目.....110
专栏 58. 伊朗伊斯兰共和国：能力建设.....110
专栏 59. 伊拉克：IOM 心理健康和社会心理支持计划：自杀预防和应对.....111
专栏 60. 荷兰：评估守门人培训.....112

专栏 61. 土耳其：自杀预防.....112
专栏 62. 澳大利亚：昆士兰自杀登记系统.....113
专栏 63. 巴西：故意伤害监测.....113
专栏 64. 中美洲和多米尼加共和国：自杀行为观察站.....114
专栏 65. 巴基斯坦：阿迦汗大学医院自伤监测系统(AKUH-SHMS).....114
专栏 66. 孟加拉国：农药禁令.....116
专栏 67. 加拿大：社区限制自杀手段的可及性.....116
专栏 68. 斐济：限制杀虫剂的获取.....116
专栏 69. 马来西亚：禁用百草枯.....117
专栏 70. 斯洛文尼亚：改编和实施负责任的媒体自杀报道指南.....118
专栏 71. 加拿大：自杀丧亲团体支持促进者网络.....119
专栏 72. 伊朗伊斯兰共和国：对自杀未遂者的随访.....119
专栏 73. 波兰：作为新兴职业的康复助理.....119

序言

任何自杀所致死亡都是非常悲伤的事情。自杀者的亲密家人和朋友无法理解自杀的原因，已经给他们造成极大的痛苦。但是当他们反思自己本可以做些什么来预防这些可以避免的死亡时，他们的悲伤会必然会成倍增加。

全世界每年有 70 多万人死于自杀。每一个自杀都是一场悲剧，对家庭、朋友和社区都会产生深远的影响。这些过早的死亡都是可以避免的，这也是本指南之所以重要的原因。

我们不能，也必须不能，忽视自杀。尽管一些国家已经将预防自杀列入其重要议程，但仍有太多的国家没有就此达成承诺。除非我们改变努力的方式，实施预防自杀的有效行动，否则将无法实现联合国可持续发展目标和世界卫生组织的精神卫生行动计划中关于降低全球自杀死亡率的目标。

“LIVE LIFE”是世界卫生组织预防自杀的路径，详细说明了四个预防自杀的循证实践措施，以及六个作为实施基础的整合支柱。在本指南中，“LIVE LIFE”干预和支柱都相应地配有来自世界各国的案例研究。这些案例研究提供了许多在不同的背景下有效的活动。一些国家和社会在预防自杀方面取得了成功，我们希望决策者能够考虑这些经验。

“LIVE LIFE”认识到政府和社区在实施自杀预防行动方面所发挥的作用。目前，已知有 38 个国家有国家自杀预防策略。虽然有财政支持的国家自杀预防策略--包括“LIVE LIFE”干预和支柱--仍然是政府领导的应对自杀的最高目标，但即使缺乏这种国家策略，也不应阻碍“LIVE LIFE”计划的实施。通过实施“LIVE LIFE”，各国能够建立一个全面的国家自杀预防应对措施。

本指南是政府采取循证行动的催化剂。它使各国能够拯救那些发现自己陷入严重困境并面临自杀危险者的生命。

但预防自杀并不仅仅是政府的责任，我们每个人都有自己的角色--照顾我们的朋友、家人和同事，并在认为他们可能需要的时候向他们提供支持。这会使一切变得不同。

谭德塞　博士

世界卫生组织 总干事

致谢

构思和指导

Dévora Kestel（世界卫生组织）、Mark van Ommeren（世界卫生组织）

项目协调和编辑

Alexandra Fleischmann（世界卫生组织）、Aiysha Malik（世界卫生组织）、Amrita Parekh（印度）、Hannah Wilson（英国）

技术贡献和/或审议[1]

国际贡献者和审稿人

Sabah Abdulrahman（伊拉克）, Esra Alatas（土耳其）, Louis Appleby（英国）, Ella Arensman（爱尔兰）, Anna Baran（波兰）， Sandra Barnes（美国）, José Bertolote（巴西）, Daria Biechowska （波兰）, Karline Brathwaite（特立尼达和多巴哥）, Felicity Brown（约旦）, Vladimir Carli（瑞典）, Lai Fong Chan（马来西亚）, Mary Cwik（美国）, Jayamal De Silva（斯里兰卡）, Michael Eddleston（英国）， Bronwen Edwards（澳大利亚）， Rabih El Chammay（黎巴嫩）, Gerdien Franx（荷兰）, Tobi Graafsma（苏里南）, Alexander Grabenhofer-Eggerth（奥地利）， Jorgen Gullestrup （澳大利亚）, David Gunnell（英国）, Ahmad Hajebi（伊朗伊斯兰共和国）， Lyndal Halliday（澳大利亚）, Gregor Henderson（英国）, Andrea Horvath（美国）, Gerard Hutchinson（特立尼达和多巴哥）, Linda Jaber （巴勒斯坦占被领土，包括东耶路撒冷）, Samah Jabr （巴勒斯坦占被领土，包括东耶路撒冷）, James Jopling（英国）, Manfriedine Kandjii （纳米比亚）, Alexandr Kasal（捷克）, Tim Kendall（英国）, Murad Khan（巴基斯坦）, Myung Ki（韩国）, Nour Kik（黎巴嫩）, Kairi Kõlves（澳大利亚）, Johanna Lechner（约旦）, Kirsty Licence（英国）, Kazem Malakouti（伊朗伊斯兰共和国）, Gamini Manuweera（瑞士）, Hatem Alaa Marzouk（埃及）, Janey McGoldrick（澳大利亚）, Richard McKeon（美国）, John Mitchell（英国）， Yutaka Motohashi（日本）, Merab Mulindi（肯尼亚）, Jay Nairn（英国）, Ashley Nemiro（丹麦）， Thomas Niederkrotenthaler（奥地利）, Merete Nordentoft（丹麦）, Kevin O'Neill（英国）, Joseph Osafo（加纳）, Jong-Woo Paik（韩国）, Elise Paul（英国）, Jane Pearson（美国）, Jane Pirkis（澳大利亚）, Steven Platt （英国）, Gwendolyn Portzky （比利时）, Vita Postuvan（斯洛文尼亚）, György Purebl （匈牙利）, Jerry Reed（美国）, Dan Reidenberg（美国）， Mohsen Rezaeian（伊朗伊斯兰共和国）, Util Richmond-Thomas（圭亚那）, Joanna Rogalska（波兰）, Ignas Rubikas（立陶宛）， Shekhar Saxena （美国）, Fiona Shand （澳大利亚）， Jaelea Skehan（澳大利亚）, Eve Stamate （澳大利亚）, Clare Stevens（美国）, Deborah Stone（美国）, Elly Stout（美国）, Karla Thorpe （加拿大）, Barbara Van Dahlen（美国）, Lakshmi Vijayakumar（印度）, Yeshi Wangdi（不丹）， Danuta Wasserman（瑞

[1] "LIVE LIFE"实施指南的制定过程中，访谈和咨询了来自世界卫生组织所有区域和国家的技术人才、专家、预防自杀实践者和有丰富经验的人，并通过两轮国际专家咨询会议而成。

典), Claire Whitney (美国), Shirley Windsor (英国), Petr Winkler (捷克), Brianna Woodward (澳大利亚), Joana Zasimavičienė (立陶宛)。

参加制定和最终确定该指南的会议的人员

Helal Uddin Ahmed (孟加拉国), Ella Arensman (爱尔兰), Phanindra Prasad Baral (尼泊尔), Karline Brathwaite (特立尼达和多巴哥), Vladimir Carli (瑞典), Lai Fong Chan (马来西亚), Jayamal De Silva (斯里兰卡), Mindu Dorji (尼泊尔), Ahmad Hajebi (伊朗伊斯兰共和国), Manfriedine Kandjii (纳米比亚), Basu Dev Karki (尼泊尔), Alexandr Kasal (捷克), Elena Kazantseva (蒙古), Myung Ki (韩国), Masashi Kizuki (日本), Käthlin Mikiver (爱沙尼亚), Yutaka Motohashi (日本), Jane Pirkis (澳大利亚), Steven Platt (英国), Juan Manuel Quijada Gaytán (墨西哥), Thilini Rajapakshe (斯里兰卡), Rohan Ratnayake (斯里兰卡), Util Richmond-Thomas (圭亚那), Ignas Rubikas (立陶宛), Diana Tejadilla (墨西哥), 童永胜 (中国), Bayarmaa Vanchindorj (蒙古), Esther Walter (瑞士), Yeshi Wangdi (不丹), Claire Whitney (美国), Anna Williams (英国), Petr Winkler (捷克).

世界卫生组织总部

Richard Brown, Kenneth Carswell, Batool Fatima, Michelle Funk, Brandon Gray, Fahmy Hanna, Brian Ogallo, Alison Schafer, Chiara Servili, Inka Weissbecker.

世界卫生组织区域办事处

Florence Baingana，世界卫生组织非洲区域办事处；Renato Oliveira e Souza, Claudina Cayetano and Carmen Martinez Viciana，世界卫生组织美洲区域办事处；Nazneen Anwar, 世界卫生组织东南亚区域办事处；Dan Chisholm, Elena Shevkun ，Meredith Fendt-Newlin，世界卫生组织欧洲区域办事处； Khalid Saeed，世界卫生组织东地中海区域办事处；Martin Vandendyck，世界卫生组织西太平洋区域办事处。

世界卫生组织国家办事处

Catarina Dahl，世界卫生组织巴西国家办事处；Jennifer Hall，世界卫生组织斐济国家办事处；Edwina Zoghbi，世界卫生组织黎巴嫩国家办事处；Bolormaa Sukhbaatar，世界卫生组织蒙古国家办事处；Kedar Marahatta，世界卫生组织尼泊尔办事处；Olga Manukhina，世界卫生组织俄罗斯联邦办事处；Thirupathy Suveendran，世界卫生组织斯里兰卡国家办事处； Wendy Emanuelson-Telgt，世界卫生组织苏里南国家办事处；Taraleen Malcolm，特立尼达和多巴哥国家办事处；Manuel De Lara and Akfer Karaoğlan Kahiloğullari，世界卫生组织土耳其国家办事处；Rajiah Abu Sway，世界卫生组织约旦河西岸和加沙地带国家办事处。

行政支持

Ophel Riano (世界卫生组织)、Evelyn Finger (世界卫生组织)、Zahiri Malik (世界卫生组织)

制作团队

编辑：David Bramley，瑞士

世界卫生组织要感谢下列国家的财政捐助：

- 日本政府；
- 韩国自杀预防中心；
- 全民健康覆盖伙伴关系(UHC 伙伴关系)，从以下机构获得资金和支持：
  - » 比利时
  - » 欧盟
  - » 卢森堡-援助与发展
  - » 爱尔兰-爱尔兰援助
  - » 法国-欧洲和临时事务部
  - » 日本-厚生劳动省
  - » 英国-国际发展部
  - » 世界卫生组织

内容概要

引言

每年有超过 70 万人自杀死亡。联合国可持续发展目标(SDGs)和世界卫生组织 2013-2030 年综合精神卫生行动计划的目标之一是，到 2030 年，将全球自杀率降低三分之一，这也是唯一的心理健康目标。世界卫生组织 2019-2023 年第 13 次工作总规划也包括类似的指标，即到 2023 年将自杀率降低 15%。

世界并没有朝着 2030 年自杀率降低这一目标前行。理想状况下，世界卫生组织倡导各国，通过一项全面的国家自杀预防策略并采取行动预防自杀。各国政府和社区可以通过实施“LIVE LIFE”这一世界卫生组织预防自杀路径来践行自杀预防工作。各国能够在此路径基础上进一步制定全面的国家自杀预防策略。本指南适用于所有国家，无论目前有没有国家自杀预防策略。

A 部分：“LIVE LIFE” 的核心支柱

“ LIVE LIFE”的核心支柱如下：

- 情况分析
- 多部门合作
- 提高意识和宣传
- 能力建设
- 财政支持
- 监测、监控和评估。

A 部分通过问“是什么？”、“为什么”、“在哪里”、“什么时候”、“谁来做”和“怎么做”来描述每一个核心支柱。每个支柱都有一个表格，显示了应该包含哪些元素。专栏中提供了来自世界各地的例子，每个小节都包含“实施过程的提示”。

情况分析描述了自杀和自杀预防的背景和现状，更重要的是明确了自杀预防活动的规划和实施。该分析可在国家、地区或地方进行，并应在自杀预防工作开始时，由一个由专家、利益攸关方和有自杀经历的人组成的专门工作组进行。工作组收集数据（如自杀和自伤率、使用的方法、诱发或保护因素、立法、服务和资源），进行情况分析，编写报告，并与决策者、政策制定者和资助者分享，以影响资源调动和/或行动授权。最需要注意的问题是保密，保护人们的隐私，避免鼓励自杀。

多部门合作是必要的，因为自杀的危险因素与许多领域有关。一种全政府或全社会的方法适用于跨政府机构或部门--包括非政府团体和社区团体合作。在政府的领导下，这种方法促进知识分享、方法学交流、吸取教训、并共享自杀相关的数据和研究。多部门合作还增加了透明性，并有利于问责制。这种合作必须尽早开始，且政府和合作伙伴都要确保已做好准备。多部门办法依赖于合作愿景和协商式的常规评估。如果非卫生部门认为自杀仅仅是一个健康问题，就可能会出现问题。必须明确每一个利益攸关方的角色并商定好行动意见，以防他们发现自己难以履行其职责。

提高意识和宣传取决于一个针对公开受众的有组织的沟通过程。提高意识能让人们注意到一些事实，比如自杀是一个严重的公共卫生问题。宣传的目的是引起一些变革，如实现自杀的合法化或国家自杀预防策略。提高对自杀预防的意识和宣传可以从单一社区的活动到全国性的公共宣传活动，可以是持续的、定期的或每年一次的活动（如世界自杀预防日），由“旗手”领导公共活动。重要的是确定传达的信息要适应目标受众，选择恰当的沟通方式，并事先测试信息的可接受性和潜在影响。方案应该有明确的重点和行动倡议，例如将人们与支持服务联系起来，而不是笼统地讨论自杀问题。

能力建设可以在国家层面进行协调，也可以在社区内进行。可以通过对卫生工作者任职前的自杀预防培训或入职后的继续教育来进行能力建设，但遇到高自杀风险或病耻感等问题时，也可以随时开展能力培训。

它可针对卫生工作者、应急服务人员、教师和青年工作者，以及经常与其客户互动的其他人，如理发师或调酒师。对于非专业的卫生工作者和社区卫生工作者，可以使用世界卫生组织精神卫生 mhGAP 干预指南中的自伤/自杀模块和相关的培训材料。建议采用培训讲师的模式，因为这能够增加提供培训的人力资源。对于来源多样的学员队伍，培训必须适应社会文化背景，并要强化受培训者掌握自杀及预防的知识。

财政支持受到一系列因素的影响，诸如经济条件差、尚未将自杀放在需要优先处理的严重问题上，以及没有认识到自杀是可以预防的。目前自杀预防得到的财政支持往往很少。申请资金时应聚焦于包括政策、战略和计划的制定和执行，而不仅仅是开展服务。本指南就如何为预防自杀筹款提供了建议，并指出这应该是一个持续的过程。本文描述了确定预算的步骤，以及研究和确定潜在的资助者，制定方案和保持与资助者的关系，无论他们的决定如何。我们鼓励有关团体分享故事，讲述资金充足的自杀预防干预措施的作用。

监测可以提供关于自杀和自伤的数据，以指导“LIVE LIFE”的干预。尽管在很大程度上监测依赖于以前进行过多少自杀和自伤监测，本报告仍强调民事登记和死亡统计、健康和违警记录、口头尸检和基于人口的调查等数据资源的重要性。应优先考虑从几个具有代表性的地点获得高质量的数据，而不是从整个国家获得质量较差的数据。关键的发现，包括自杀和自伤的发生率和趋势，可以帮助指导预防活动。因此，定期发布报告并为开展各种活动提供信息是很重要的。

监控和评价应考虑一项干预措施是否有效，它是否按预期进行，以及从它是否物有所值。监测自杀率的变化具有挑战性，但评估“LIVE LIFE”是否达到了减少自杀和自伤的预期依然是必要的。监测和评估可能需要一个专门的小组（例如，包括流行病学家、统计学家和数据收集者），这可能有助于与学术机构合作。结果和指标的确定需要与降低自杀和自伤率这一主要目标相一致。本指南强调，如果没有明确的目标和指标，就很难展现出取得了什么样的进展，因此更难证明获得资助的合理性。

B 部分：“LIVE LIFE”有效预防自杀的关键干预措施

本指南中所述的干预措施包括：

- 限制自杀的手段
- 与媒体互动促其负责任地报道自杀事件
- 培养青少年的社会情感生活技能
- 早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人。

作为 A 部分的核心支柱，问题“是什么？”、“为什么”、“在哪里”、“什么时候”、“谁来做”和“怎么做”在 B 部分中的每项干预措施中都会被提及。

限制自杀手段的获取是一种循证的通用自杀预防干预措施。根据每个国家的不同情况而采取不同的方式，如禁止高致命性的杀虫剂，限制枪支，在“跳楼点”设置障碍，限制绳索的获得，或采取其他措施使其难以获得自杀手段。大多数有自杀行为的人都经历过对生或死的矛盾心理，而许多自杀都是对急性压力源的一种反应。让一个处于痛苦状态的人在采取致命行动之前不容易获得致命的自杀手段，使其有充分的时间度过危机时刻。本节重点讨论杀虫剂，据估计，全球五分之一的自杀服用了农药。由于大量的农村居民从事农业生产，农药自杀是一个特别的问题。

限制杀虫剂获取需要所有利益攸关方，包括卫生部、农业部、监管机构和登记机构以及社区领导人在内的多部门合作。这种多部门合作的原则同样也适用于限制其他自杀手段（例如设置障碍需要运输部门参与）。在个人层面，如果有家庭成员处于自杀风险中，其他家庭成员需要将住所里的自杀工具（如杀虫剂、枪支、刀、药物）清除掉。

重要的是，有证据表明，限制一种自杀方式并不会导致使用其他方式的自杀增加。

与媒体互动促其负责任地报道自杀非常重要。因为媒体对自杀的某些报道——尤其是对名人自杀的报道或描述自杀方法，会增加模仿自杀而导致自杀行为的上升。国家层面的目标是与国家媒体（和社交媒体）机构合作，在地方层面与当地报纸或广播电台等地方媒体机构合作。本指南建议监测自杀事件的报道，并建议提供一些知名人士从其自身的心理问题或自杀想法中成功康复的例子。指南还建议与社交媒体公司合作，提高他们的意识并改进报道方案，以助于识别和删除有害内容。

培养青少年的社会情感生活技能是世界卫生组织帮助青少年茁壮成长(HAT)指南的重点。青春期（10-19 岁）是获得社会情感技能的关键时期，也是出现心理问题的危险时期。HAT 指南没有明确关注自杀，而是建议采取积极的心理健康方法。其他建议包括培训教育工作者、确保学校环境安全的倡议（如反欺凌方案）、与支持服务机构的联系、明确的政策和方案以合理处置识别出的自杀风险个体，以及提高父母对心理健康和风险因素的意识。应该提醒教师或照顾者，与年轻人谈论自杀不会增加自杀风险，反而会让年轻人在有需要时能向他们寻求支持。还应确保工作人员的心理健康状况良好。

早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人。这一建议旨在确保有自杀高危的人，或已自杀未遂的人，能得到他们所需要的支持和照顾。该措施适用于卫生工作者和其他可能会接触到自杀高危者的人员，例如家庭成员。该建议也适用于卫生系统，他们需要将自杀预防作为工作中一个核心组成部分，以便在发现人们有自杀风险时尽早进行干预。此外，还应向那些自杀未遂者和那些自杀者亲友提供支持。由于自杀预防往往不是公共卫生的优先事项，本指南建议与决策者一起倡导自杀预防，提高社区对自杀的认识，并提供自杀预防的有效性和成本效益的证据。

指南列出了四个附录：1)与预防自杀有关的部门和利益攸关方清单；2)30 个描述国家预防自杀活动的专栏（除了指南正文中的 43 个描述性专栏外）；3)“LIVE LIFE”指标框架列出的“LIVE LIFE”的目标、结局和指标；和 4)世界卫生组织和非世界卫生组织的自杀预防资源清单，其标题分别是：情况分析，多部门合作，提高意识和宣传，能力建设，财政

支持，监测，监控和评估，限制自杀手段，与媒体互动促其负责任地报道自杀，培养青少年社会情感生活技能，和早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人。

引言

背景

每年有超过 70 万人自杀死亡。所有社会经济背景的人都会受到影响。自杀是 15-29 岁的人的第四大死因，也是 15-19 岁女孩的第三大死因。大多数自杀死亡（77%）发生在中低收入国家[2]。

每一个自杀都是一场悲剧，对家庭、朋友和社区都有着深远的影响。减少世界各地的自杀死亡人数是全球的当务之急，全球目标也已经确定，如联合国可持续发展目标（UN SDGs）[3]之一是到 2030 年将全球自杀率降低三分之一，这是唯一的心理健康目标。世界卫生组织 2013-2030 年精神健康综合行动计划中也有这个目标。世界卫生组织 2019-2023 年第 13 届工作总计划(GPW13)的目标[4]包括：到 2023 年将自杀率减少 15%。

自 2010 年以来，全球的年龄标化自杀率略有下降，但全球趋势掩盖了区域和国家层面的差异。并不是所有国家都致力于预防自杀，一些国家的自杀率有所上升。世界发展趋势并不支持 2030 年全球目标的实现，这意味着除非有更多且持续的努力来预防自杀，否则全球目标将无法实现，将会有更多的人不必要地失去生命。

我们还需要做更多的工作来减少自杀死亡的人数。因此，世界卫生组织制定了这一指南，以支持各国以世界卫生组织“LIVE LIFE”方法为起点，实施关键的有效的循证干预措施。

世界卫生组织倡导各国采取行动预防自杀，最好是通过一项全面的国家自杀预防策略来实现。政府领导的全面的国家策略是一个强大的工具，有助于确保政府和其他利益攸关方致力于在全国范围内预防自杀，协调和监控他们的努力，将自杀预防放在政治议程中，合理分配资源，实施必要的行动。尽管取得了一些进展，一些国家在自杀预防方面非常积极，但到 2018 年只有 38 个国家已经制定了专门的国家自杀预防战略(世界卫生组织，2018a)。此外，各国政府往往低估了在制定国家策略后进行协调执行的重要性。在非传染性疾病（NCDS）领域，国家行动计划的实施差距归因于资金不足、能力有限、各部门不

[2] WHO Global health estimates: leading causes of death. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-globalhealth-estimates/ghe-leading-causes-of-death, accessed 28 January 2021).
[3] Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf, accessed 28 January, 2021).
[4] Thirteenth General Programme of Work. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/ about/what-we-do/thirteenth-general-programme-ofwork-2019---2023, accessed 28 January 2021).

作为以及缺乏标准化监测和评估(Tuangratananon 等，2019)。事实上，对国家自杀预防策略的评估非常缺乏。

即使没有全面的国家自杀预防策略，各国也不能因此不开展自杀预防活动。在许多没有自杀预防策略的国家，广泛的利益攸关方参与了自杀预防活动——从组织幸存者支持小组到提高意识和保护高危人群。社区利益攸关方（见附录 1 的部门和利益攸关方清单）将受益于“LIVE LIFE”路径中任何部分的实施；“LIVE LIFE”的实施可以在一个国家形成自杀预防的开端，有可能逐步发展成为国家自杀预防的应对措施。因此，政府和社区分别通过自上而下和自下而上的过程对自杀预防做出贡献。

“LIVE LIFE”是世界卫生组织启动自杀预防实施的方法，并强调将四项关键的循证的自杀预防干预措施扩大到国家层面，即：

- 限制使用自杀手段（例如，禁止高致命性的杀虫剂）；
- 与媒体互动，促使其负责任地对自杀事件报道；
- 培养青少年的社会情感生活技能；
- 早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人。

要成功实施和扩大这些关键的干预措施，作为先决条件，需要六个整合的核心基本支柱，即：

- 情况分析；
- 多部门合作；
- 提高意识和宣传；
- 能力建设；
- 财政支持；
- 监测、监控和评估。

“LIVE LIFE”各个成分除了能独立减少自杀之外，综合实施“LIVE LIFE”的所有支柱和干预措施将产生协同效应，不同成分的相互作用产生额外的效益(Harris 等，2016；Yip & Tang，2021)。例如，提高意识活动可以增加对能力建设相关知识的掌握，进而增强对自杀行为的早期识别。

有必要努力在所有国家和文化背景下充分实施“LIVE LIFE”。“LIVE LIFE”是各国进一步建立循证的自杀预防干预措施，以制定全面的国家自杀预防策略的起点。“LIVE LIFE”指南中描述的所有支柱和干预措施都是国家应对措施的组成部分，通常是国家自杀预防策

略的一部分。有自杀预防国家策略，或将自杀预防纳入现有的如精神健康、酒精或非传染性疾病相关行动计划的国家，如果能够确保其战略或行动计划得到执行，优先执行这些组成部分，则会从中获益。

这个指南是给谁看的？

本指南适用于：

- 所有国家，无论是否有国家自杀预防策略；
- 自杀预防、心理健康、酒精或非传染性疾病的国家或地方合作中心；
- 具有既得利益的社区利益相关方或可能已经参与实施自杀预防活动的社区利益攸关方。

包括什么？

该指南解释了如何建立核心的基础支柱和实施“LIVE LIFE”有效的循证的关键干预措施（图 1）。

指南包括：

- 每个 “LIVE LIFE”的核心支柱和干预都是什么；
- 为什么它对预防自杀很重要；
- 在哪里实施；
- 何时实施；
- 谁将负责实施；
- 如何实施。

图 1. “LIVE LIFE”的基本支柱和有效的循证的关键干预

什么是“LIVE LIFE”？

“LIVE” 基本支柱	关键的循证有效干预措施			
情况分析 多部门合作 提高意识 能力建设 财政支持 监测、监控和评估	L 限制自杀手段的使用	I 与媒体互动，促进负责任的报道	F 培养年轻人的生活技能	E 早期识别并支持所有受自杀影响的人

本指南还包含：

- 全文中专栏例子和附录 2 中各个国家的例子；
- 措施实施的提示。

此外：

- 附录 1 提供了可参与“LIVE LIFE”的部门和利益攸关方的清单；
- 附录 2 提供了来自多个国家和社区的详细例子；
- 附录 3 提供了一个可用于监测“LIVE LIFE”的实施情况的指标框架；
- 附录 4 提供了更多信息的来源。

没有包括什么？

本指南不包括：

- 在政府层面制定全面的国家自杀预防策略，或预防策略实例如世界卫生组织其他出版物(世界卫生组织，2012；世界卫生组织，2014；世界卫生组织，2018a)；
- 循序渐进的社区自杀预防方法，这可在世界卫生组织出版物(世界卫生组织，2018d)及其相应的社区参与自杀预防的电子学习课程中获得[5]；
- 一种自杀预防或危险和保护因素的公共卫生模式——涵盖系统、社会、社区、关系和个人问题，并反映生态模式——参见世界卫生组织另一份出版物（世界卫生组织，2014）。

专栏 1. 组建指导委员会和工作组

需要一个指导委员会（或监督委员会，或特别工作组）来领导和协调工作，以及制定规划、提供资源、实施、监测和评估“LIVE LIFE”。

成立若干工作组（指导委员会的分支机构）来执行各支柱和干预措施。由一名固定的指导委员会成员进行协调。

这两个机构应包括代表当局、行政和技术专长的人员。理想情况下，公共、私人和社区团体或个人之间应进行合作（部门和利益攸关方的清单见附录 1）。应包括以下成员：

- 在有关部门（例如卫生保健、教育、就业、社会发展）担任领导职务的人；
- 具有自杀预防专业知识的人（例如，学术专家、卫生部门、非政府组织）；

[5] Engaging communities in preventing suicide; e-learning course. Geneva: World Health Organization (https://accesswho.campusvirtualsp.org/engagingcommunities- preventing-suicide, accessed 28 January 2021).

- 具备有关支柱或干预所需特定技能和经验的人，例如情况分析工作组应包括有数据收集和分析技能的人员，而与媒体互动工作组应包括媒体监管机构的人员或有参与媒体工作经验的非政府组织的人员；
- 有自杀相关经历的人（他们经历过自杀的想法，有过自杀未遂，照顾过有自杀危机的亲人，或自杀者亲友）。

不要低估指导委员会和工作组所肩负的领导责任的重要意义。同样，必须明确界定小组成员的角色和责任，以确保谁来负责所要开展的活动。没有必要成立 10 个独立的“LIVE LIFE”支柱和干预措施工作小组，因为一个工作组可以根据资源和时间设定依次处理几个支柱或干预措施的工作。最终，在指导委员会协调下，各工作组领导“LIVE LIFE”的规划和实施。工作组负责监测“LIVE LIFE”支柱和干预措施实施情况，例如制定需要完成行动的时间表，并定期召开会议审查进展情况，以便尽早解决困难。工作组应随时准备向指导委员会报告对已实施计划的评价。

如何使用该指南？

- 各国应实施所有“LIVE LIFE”的核心支柱和关键干预措施。
- 虽然预防自杀需要所有核心支柱和关键干预措施，但每个国家都可以根据可用的资源和社会文化背景调整其实施情况。
- “LIVE LIFE”的核心支柱和关键干预措施并非要按编排的顺序实施。尽管理想情况下应该从情况分析开始，并逐步持续的监测和监控，但还没有明确的特定顺序。
- 因此，虽然本指南的各个章节是相互关联的，但每个章节都可以被视为一个独立的模块，各国可以从与它们最相关的模块开始。可以将情况分析作为第一步，来指导决策。
- 在全国实施所有“LIVE LIFE”的支柱和干预措施将有利于制定国家自杀预防策略或将“LIVE LIFE”作为国家策略的一部分。
- 在人力和财政资源有限的情况下，可能有必要长期实施或扩大“LIVE LIFE”的规模，并采取行动使其成为国家的优先事项。

该指南的使用方式将根据自杀预防的背景和现状而有所不同。如果基本支柱已经建立并运行，就可以直接解决关键干预措施的实施问题。在其他情况下，可能需要开始为预防自杀做好准备，或者仅是小规模筹备。无论如何，应设立一个指导委员会和工作组（见专栏 1）。对于突发公共卫生事件或其他紧急情况，已编制了一些考虑事项，但并非详尽无遗（见专栏 2）。

专栏 2. 在紧急情况下的自杀预防

人道主义危机和紧急情况（如自然灾害、武装冲突、突发公共卫生事件）对自杀预防构成了一些障碍，如领导层和制度的结构性变化、优先事项的变化、安全问题和资源限制问题。然而，自杀的风险因素——如经济困难、失业和社会孤立在紧急情况下可能会增加，因此集中精力预防自杀至关重要。在这种情况下，可能需要关注自杀预防的即时可行的优先事项(Gunnell 等，2020)。虽然对危机情况下自杀的全面讨论超出了本指南的范围，但需要考虑一些因素，包括：

- 各国政府应考虑紧急情况对自杀危险因素的影响，并应通过多部门合作实施缓解措施，例如与劳工和福利部门、卫生部门和人道主义行为者合作，支持陷入经济困境的个人；限制自杀方法的获得（如零售商或营地经理的条例或准则）；促进获得心理健康支持和其他情感或危机支持服务的途径。
- 政府在收容受紧急情况影响的群体（包括难民和移民）时应考虑将这些人的具体的风险因素和需求作为自杀预防工作的一部分。
- 识别在紧急情况下可能受到特定影响的高危人群，并提供有效的干预措施，例如可能失去或脱离家庭支持的年轻人或老年人。
- 让媒体尽量减少对紧急情况下发生在受影响社区内自杀事件的耸人听闻报道。
- 促进现有的卫生和社区工作人员建立早期识别、评估、管理和随访自杀风险的能力。社区守门人和非专业卫生工作者应有信心识别、支持和转诊有自杀风险的个人，包括实施用于不利环境的心理干预措施(世界卫生组织，2016b)。可以优先考虑对处于风险的个体提供服务，例如初级保健服务和重点解决庇护问题（包括对儿童和性暴力受害者的庇护）。
- 在面对面的心理健康支持有限的情况下，建立远程支持系统(世界卫生组织，2018c)。确保员工使用远程沟通方法接受培训，并对此感到舒适，特别是在风险管理时[6]。
- 确保有足够的覆盖范围以满足需求，防止在自杀预防和心理健康方面工作的关键人员被调动到非自杀预防职能上。
- 向受影响人群提供有关心理健康自我保健和现有心理健康服务的信息。
- 与人道主义行动者（例如在保健、保护、教育、营养、营地管理方面）合作，促进可能需要心理健康支持的受影响人口的转诊。

[6] Guidance on Operational considerations for Multisectoral Mental Health and Psychosocial Support Programmes during the COVID-19 Pandemic. Geneva:Inter-Agency Standing Committee (https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergencysettings/iasc-guidance, accessed 28 January 2021)

- 确保让急救人员获得心理健康支持。

更多详细信息，请参阅以下资源：

- 世界卫生组织 mhGAP 人道主义干预指南（世界卫生组织，2015）。
- 更好地重建：紧急情况后的可持续心理卫生保健（世界卫生组织，2013）。
- 机构间常设委员会(IASC)关于紧急情况下的心理健康和心理社会支持的准则。

日内瓦：机构间常设委员会[7]。

[7] Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings. Geneva: Inter-Agency Standing Committee (https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf, accessed 28 January 2021).

A 部分

“LIVE LIFE”核心支柱

下面几部分描述了自杀预防的核心支柱。这些构成了成功实施关键的循证干预措施的基础，共同助力自杀预防。这些措施包括：情况分析，多部门合作，提高意识和宣传，能力建设，财政支持，监测、监控和评价。

这些支柱在其他公共卫生领域中很常见。下面将在预防自杀的背景下描述这些支柱的实施情况。

情况分析

是什么？

情况分析利用各种信息描述一个国家的自杀和自杀预防的背景和目前的概况。

为什么？

情况分析的重要性在于其可为自杀预防活动的规划和实施提供信息。情况分析可以确定哪里最需要，哪里有差距或哪里的利益最大（例如，去关注哪些手段或人群）。情况分析可以防止重复执行工作，并确定在哪可以立即采取行动。

在哪里？

情况分析可以在全国范围内进行，也可以在地区或当地的背景下进行，如区县或其他特定环境（如难民营或学校）。在全国情况分析中，应注意从不同的社会人口群体和地区收集信息，以确定具体需要调整哪些“LIVE LIFE”干预措施。例如，服用杀虫剂主要发生在中低收入国家的农业地区；因此限制使用这种自杀手段可及性在城市地区可能不太适用。

什么时候？

应在任何自杀预防工作开始之时就进行情况分析，以便为规划和实施提供信息。

谁来做？

应由一个专门的工作组牵头进行情况分析。应建立确保透明度和问责制的机制。该小组应包括具有一系列技能的人员，包括：

- 情况分析的领导和协调（例如卫生部），或针对具体情况分析，来自有关部门（例如分析学校生活技能方案的教育部门）的领导；
- 有进行情况分析的经验（例如学术界）；
- 有进行数据收集和分析的经验(例如统计局)；
- 能够提供相关数据的利益攸关方（例如卫生信息系统工作人员、验尸官、医疗法律官员、紧急服务人员或医院工作人员）；
- 具有特定背景知识和经验的社区利益攸关方（例如有相关经历的人、守门人、某个亚人群利益的代表）；
- 自杀预防专家（例如来自卫生部门或学术界）。

怎么做？

1.召集一个工作组来计划和实施分析（见专栏 1）

- 建立工作组(见上面的“谁来做”部分）

工作组还负责申请获得任何必要的数据或信息，这些数据或信息将为情况分析提供信息。

2.决定应该收集什么信息

- 关于收集哪些信息的决定（表 1）将受到涵盖地域范围（国家或地方分析）、可用资源和时间框架的影响。
- 由人口和资源相似的且以前实施过情况分析的国家提供指导。

表 1. 情况分析中要包含的信息示例

信息示例	注意事项
自杀数和自杀率	• 根据以下获取数据：a）情境（国家、地区、地区、住院服务、难民营等)；和 b)人群（整个人群，按性别、年龄组、种族、宗教群体、移民情况、城市、农村、社会经济地位划分)。 • 除自杀数外，还需要计算死亡率（每 10 万人的死亡或病例），以识别高自杀率的亚人群。 • 回顾多年来的数据，以确定发展趋势。
自伤数和自伤率	
自杀和自伤方法	
自杀的原因或诱发因素和保护性因素	
有关自杀或与自杀有关的现有立法或政策	• 自杀和自杀未遂的法律地位是什么？对个人的法律后果是什么（例如司法判决）？ • 如涉及，自杀、自杀未遂和自伤行为的合法化的范围是什么？ • 是否有与预防自杀有关的现有立法或政策（比如，心理健康、酒精使用、就业、保险、社会福利)？
自杀的确定	• 自杀是如何确定的，以及由谁来确定？ • 要顾及确定自杀的方法对自杀的报告和现有数据的质量有怎样的影响。
自杀和自伤的个案登记	• 自杀和自伤是如何登记和报告的？谁来做？ • 数据是由哪些变量来分解的？

信息示例（续）	注意事项（续）
目前对“LIVE LIFE”支柱和关键干预措施的实施和覆盖范围	• 启动或改进这些措施的范围是什么？ •对它们进行评估了吗？ •考虑到可接受性、可行性和（成本）有效性，需要适应哪些国家状况？ •考虑一下以前的任何自杀预防措施（以及为什么他们不再活跃）。
当前服务	• 卫生部门、社区和其他相关部门的现有服务（公共和私营的）——考虑现有服务的可用性、接受情况和质量； • 在服务方面的差距是什么？
当前的资源	• 分配用于自杀预防的财政资源。 • 可以获得的潜在财政资源。 • 要实施“LIVE LIFE”需要哪些人力资源和能力建设？
部门和利益攸关方	• 需要哪些部门参加多部门合作？[8] • 合作需要哪些非政府组织的利益攸关方？ • 在领导力、人员或合作者方面的差距。
对自杀、自杀预防、心理健康和求助的知识或态度	• 人们（包括亚群体）在寻求帮助时所面临的障碍。 • 卫生工作者和相关职业人员在提供早期识别、评估、管理和随访以及报告自伤方面所面临的障碍。

3.决定如何收集这些信息

• 了解已有哪些信息，以及需要从哪些来源获得信息（请参见监测部分）。信息应在相应的条件下尽可 能是最新的、高质量的和具体的。

• 如果无法获得高质量的信息（例如在没有正式卫生信息系统的国家），非正式信息（例如专家意见、关键线人访谈、焦点小组讨论）比根本没有任何信息更可取。

• 如果缺少重要信息，请考虑可以收集到哪些可靠的新信息（或计划在未来的情况分析中解决这个问题）。

• 想想谁能为获取信息做出贡献。这将有助于决定在情况分析期间哪些部门和利益攸关方应该参与进来（见部门和利益攸关方清单附录 1）。确保要包括有相关经历的人，并确保他们受过良好的培训和支持，以将他们的经验带入这些讨论中。

[8] 本文中的“多部门”是指多个政府部门，而“利益攸关方”是指其他能在自杀预防中扮演重要角色的非政府小组或个人。

• 可能必须从多个来源收集数据，以获得完整的资料（例如死亡证明、急诊科数据、卫生设施、警察数据）。

• 查阅书面材料，以确定有关服务和方案的报告、政策文件、立法和信息[9] 。检索该国研究的期刊出版物。

4.达成行动计划，并进行情况分析

• 概述进行情况分析所采取的步骤。

• 对于预算，请考虑所需要的资源，如物质（例如技术、工作地点）和人力资源。

• 就利益攸关方和其负责执行的步骤达成一致（例如一些利益攸关方可能聚焦于查阅书面材料，或从不同来源的收集数据）。

5.生成一份报告，并与主要利益攸关方分享，为实施规划提供信息

• 编制一份关于调查结果的书面报告，其中需要包括对所获得的信息进行分析，突出显示缺失或质量较低的信息，并确定改进的方法。

• 根据调查结果提出建议，并提出具体的短期、中期和长期目标以及实现这些目标所需的资源。确保有相关经历的人参与到决策过程中。

• 确保书面报告得到所有相关的利益攸关方的同意。

• 与主要决策者、政策制定者和资助者分享该报告，以影响资源调动和/或行动授权（见监控和评价）。

专栏 3. 捷克：自杀预防的情况分析

根据世界卫生组织的建议（世界卫生组织，2014 年），对国家自杀预防行动计划进行了情况分析(Kasal 等，2019)。这项工作分为四项同时开展的活动，并由国家精神卫生研究所(NIMH)进行协调。情况分析是制定自杀预防政策的关键活动。在遵循这些步骤的同时，它使 NIMH 能够：1)充分了解现有情况；2)确定系统的问题和需求，以及现有的能力和可能性；并通过与主要利益攸关方（如卫生部、教育、青年和体育部、全科医生代表、精神卫生部门代表、有相关经历的人）合作，为未来实施“LIVE LIFE”建立关键的伙伴关系。我们的情况分析包括绘制情况的地图（步骤 1 和 2），以及确定和挑选合适的干预措施（步骤 3 和 4）。

[9] Joint Action on Mental Health and Wellbeing. European Union; 2015 (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_depression_ suicide_ehealth_en.pdf, accessed 28 January 2021).

在捷克进行情况分析的四个阶段

活动	**现有数据源的识别和分析**	**收集新的数据，并建立一个利益攸关方平台**	**确定适合当地情况的候选干预措施**	**通过利益攸关方共识挑选候选干预措施**
目的	使用现有的数据及识别知识差距	用定性数据来补充知识差距	在以前发表的有效的自杀预防干预的研究基础上制定	确定在预选的干预措施中的优先事项
行动	识别现有的数据源，获取和分析数据；聘请相关机构，并确保可以定期利用现有的数据，不断地告知和评估下一	绘制、联系、访谈和接触相关的利益攸关方。分析和解释所获得的数据	搜索相关的系统回顾和 meta 分析，提取有关有效干预措施的信息	组织面对面或在线会议，促进利益攸关方之间的合作，收集所有相关意见，达成共识
结果	初步分析，解释现有数据，识别知识差距	SWOT 分析和专家平台也可以参与未来自杀预防计划的实施	预选的循证干预措施清单	就适合利益攸关方目标背景的入围干预措施和未来自杀预防的行动的优先事项达成明确共识

专栏 4. 纳米比亚：国家自杀研究

由于高自杀率和缺乏关于自杀的循证信息，纳米比亚卫生和社会服务部(MoHSS)于 2018 年进行全国情况分析，以指导预防和治疗战略。

该研究关注了一些结果，包括：

- 自杀和自杀未遂的发生率；
- 自杀意念（想法）的发生率；
- 自杀的原因；
- 对自杀和自杀预防和治疗工作的知识和态度；
- 自杀预防工作的可用性和有效性。

由纳米比亚卫生和社会服务部、纳米比亚统计局和非洲可持续发展组织（纳米比亚社会经济研究公司）的代表组成了一个工作组，举行了一次初步会议，就研究的目标和方法

达成一致。来自 MoHSS 的社会工作者接受了数据收集官员的培训，并在开始全面分析之前进行了试点测试。

该分析是在全国范围内进行的，涉及定性和定量的研究方法，包括：

- 审查国家和国际上的研究、政策和方案；
- 审查纳米比亚警察的自杀记录；
- 对在不同地区随机抽取的个体进行定量调查；
- 对国家、区域和地方各级的主要信息提供者（如政府工作人员、警察、保健和社会护理人员、教育和精神领袖）、自杀未遂者进行定性访谈；并与随机挑选的成年人和青年进行焦点小组讨论。

研究产生了许多建议，用于为纳米比亚自杀预防的五年国家战略计划和政策框架的发展提供信息，指导自杀预防、治疗、管理和协调（纳米比亚卫生和社会服务部，2018）。

实施过程的提示

表 2.情况分析的实施提示

问题	提示
有限的数据	• 情况分析开始可以使用现有的数据，并可以提出建议，以在未来的情况分析中改进数据。 • 如果有需要，可以使用国际报告来补充缺失的国家信息。 • 相关社区利益攸关方可以帮助收集数据。
有限的资源	• 重点关注现有的数据和优先信息，以适应时间和资源限制。使用一个简洁的模型，如优势、劣势、机会和威胁分析(SWOT)。 • 考虑向国内和国际专家咨询关键文件和现有数据。 • 在没有人力资源的地方(例如分析数据的专业人员)，考虑与个人、组织或在或曾在其他环境中做过情况分析工作的学术界人员合作。
数据的安全和保密	• 使用自杀数据的主要道德问题是保护个人的隐私。这意味着任何个人资料都不能以可识别的形式披露。 • 在传播有关自杀的手段或共同地点的信息方面存在着已知的风险。在情况分析中能够获得敏感数据的利益攸关方必须同意对数据进行保密，并遵守达成一致的信息传播计划。

多部门合作

是什么？

卫生部门不能单独解决自杀预防的问题，因为与自杀及其预防有关的危险因素涉及许多领域。要有效预防自杀，多部门合作的方式至关重要。根据本指南的目的，多部门合作指的是包括多部门和多利益攸关方的方法：

- 多部门办法有时被描述为“全政府”、“跨部门”——即任何倡议都是由包括一个以上政府部门制定的，如卫生、教育、劳动、运输、农业、司法、法律、国防、社会发展。
- 多个利益攸关方参与的方法有时被描述为“全社会”的方法。与多部门方法不同，它们包括与非政府组织(NGO)或社区利益攸关方以及政府部门的合作。

“LIVE LIFE”的实施需要这样的协作。例如，在限制自杀手段的获得途径方面，需要与和自杀手段有关的部门（例如与高毒农药有关的农业部）和利益攸关方（例如登记员、零售商、农民）之间进行合作。另一个例子是以学校为基础的干预措施，其中的合作将包括教育部和利益攸关方，如学校负责人、教师、学生、家长/照顾者和青年协会。

有必要跨多个政府部门一起开展工作，制定对自杀产生影响的政策、立法或方案。例如负责卫生、心理健康、酒精使用[10]、提供服务、预防暴力立法或社会福利或财政政策[11]的部门需要与自杀预防的工作思路相一致。立法对自杀有直接影响，例如将自杀或自杀未遂定为犯罪将会有系统性的严重后果，严重阻碍了“LIVE LIFE”的支柱和干预措施的实施。

专栏 5. 爱尔兰：使自杀行为非罪化

1993 年，爱尔兰宣布自杀行为无罪，这个法案促成了爱尔兰的自杀预防活动。在爱尔兰自杀非罪化之前的几年里，关于自杀和自杀预防的公众辩论越来越多，这得到了由少数精神病学家领导的新兴研究的支持。一个爱尔兰议会议员(Dail Eireann)得到了两名精神病医生的支持并向政府提出多项动议，允许就自杀非罪化进行辩论；此前，自杀一直是爱尔兰社会的“沉默禁忌”。1993 年 7 月 1 日，玛丽·罗宾逊总统签署了一项法案，将自杀和自杀未遂非罪化。自杀的非罪化是爱尔兰社会认识到自杀和精神卫生问题是严重的公共卫生问题的第一步的一部分。这是消除对自杀、自伤和精神健康状况的污名化的漫长道路的开始——这一过程仍在进行中。自杀的非罪化和对自杀预防的讨论，促进了非政府组织的

[10] About one fifth of suicides are causally attributed to alcohol (WHO, 2018e).
[11] Government investment in active labour market programmes between 1970 and 2007 ameliorated the impact of unemployment on suicide mortality in the European Union countries (Stuckler et al., 2009).

形成，以提高对精神卫生和自杀复杂性的理解。1995 年，国家自杀研究基金会成立。1996 年，爱尔兰自杀行为学协会成立，旨在向所有参与预防和遏制自杀和自伤所造成的伤害的人提供关于自杀和自伤的准确信息和建议。自杀的非罪化促进了爱尔兰于 2018 年建立了第一个国家自杀问题特别工作组，这是对自杀的第一个协调应对应。随后是由卫生部支持的 2005-2014 年第一个国家自杀预防策略。2015 年，第二项策略，即爱尔兰减少自杀的国家策略——生命的联结（2015-2020 年）——正式启动，并达成一致延长四年，至 2024 年。

社区利益攸关方的参与对多部门协作至关重要（各部门和利益攸关方的清单见附录 1）。它有助于在当地需求和国家政策之间建立桥梁以及确保倡议的活动适应当地情况。社区参与也可以培养自杀预防的参与意识和集体主人翁意识。如果没有明确的治理和领导来推动这一进程，所有形式的多部门合作将不会蓬勃发展。斯里兰卡的一个成功的例子记录了从政府层面到当地利益攸关方参与的行动年表(Pearson 等，2010；Pearson 等，2015)。

专栏 6. 苏里南：环境对多部门自杀预防努力的影响

为成立应对国家高自杀率成立了一个工作组。工作组由地区专员（政府的最高代表）所领导，工作组要向地区专员汇报工作，并由医学心理学系的领导主持工作，公共卫生专家实际协调。卫生部、教育部和农业部的地方部门以及基层组织、医生和当地妇女组织也参与其中。他们组织了许多社会和教育活动。该小组的任务是根据已经制定的《2014-2020 年国家精神卫生行动计划》制定第一个国家自杀预防策略。于 2016 年 6 月，由部长理事会支持的国家自杀预防策略发表。关注精神卫生是其中的重要内容。这一关注点的优势在于，可以就自杀预防问题方面进行长期的及固定的多方合作。然而，在策略发布后不久，该国陷入了严重的经济衰退，作为有助于维持政府继续关注预防自杀方面的精神卫生问题无法继续发挥作用，也没有被替换。经济衰退还影响了自杀预防的基础设施，其中大部分已经关闭。特别工作组的前成员失去了热情，也失去了执行该策略最重要方面的行政权力。该组织便被正式解散。然而，一段时间后，前主席向新任命的卫生部长表达了对该战略的关注。令人高兴的是，2018 年苏里南提出了一个新的精神卫生关注点，并且正继续努力实施自杀预防策略。

为什么？

由于自杀是一个复杂的问题，所以预防工作需要多个部门和利益攸关方之间的协调，通过良好的治理来促进战略规划。多部门合作通过分享与自杀相关的数据和研究(Kolves

等，2021）以及协调关于自杀的信息，使得知识共享、交流方法和从以往工作中获得经验教训成为可能。多部门合作为将自杀预防行为纳入其他方案（如心理健康、酒精、非传染性疾病、基于性别的暴力和儿童保护）提供了机会。对于资源有限的国家，对于现有可用的资源来说，合作可能能够提供一个起点。加强从事自杀预防和相关领域工作的不同小组之间的协调，将使工作更加精简，从而减少工作的重复和资源的合理使用。

多部门合作促进透明度，加强参与伙伴的问责制，同时社区实质性地参与，以确保预防活动满足所有人的需要。多部门合作不需要大量的资金，但需要沟通共同目标和协调努力，这样能加速进展和提高自杀预防的质量。

专栏 7. 黎巴嫩：将自杀预防纳入精神卫生和药物使用政策

在世界卫生组织的支持下，黎巴嫩公共卫生部的国家精神卫生方案启动了第一个《精神卫生和药物使用预防、促进和治疗国家策略》（2015-2020）[12]。

作为黎巴嫩的第一个此类策略，自杀预防被纳入其中。推动国家行动的部分原因在于人道主义危机，这为精神卫生促进来说是一个好机会。策略的成功制定源于所有主要利益攸关方的强有力的参与，包括当地非政府组织、国际非政府组织、联合国机构、学术机构和专业协会。对策略的外部中期评价表明，所有利益攸关方的合作促使策略能有效实施和进展。

有几个目标有助于自杀预防与“LIVE LIFE”保持一致，即：

• 为了加强媒体负责任的报道，为从事媒体行业人员制定了关于精神卫生、药物使用以及自杀的报道指南[13]。能力建设将得以开展，将本指南纳入大学课程的可能性也会被列入议事日程。此外，作为促进与媒体在精神卫生和自杀预防上的更进一步合作，还要与媒体专业人员就媒体在预防自杀方面的作用进行圆桌讨论[14]。

[12] Mental Health and Substance Use Strategy. Beirut: Ministry of Public Health, Lebanon; 2015 (https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-English.pdf, accessed 28 January 2021).
[13] Ministry of Mental Health, Lebanon (2019). Practical Guide for Media Professionals on the Coverage of Mental Health and Substance Use. (https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Practical%20Guide%20for%20Media%20Professionals%20on%20the%20Coverage%20of%20Mental%20Health%20and%20Substance%20Use.pdf, accessed 28 January 2021).
[14] Video from the National Mental Health Programme, Lebanon (https://www.facebook.com/watch/?v=720642161857689, accessed 28 January 2021).

• 为了提高意识和宣传，每年举行关于精神卫生的国家宣传活动，包括关于自杀预防的活动，以提高认识和减少污名化。发行宣传简报以鼓励全社会预防[15]。

• 根据世界卫生组织的框架，制定了一个自杀预防和监测的国家框架。

• 当地的一个非政府组织“拥抱”和公共卫生部国家精神卫生项目联合启动了一个提供情感支持和自杀预防的国家求助热线。

• 多个国家部委制定了一个物质使用应对策略，以处理包括酒精在内的所有物质使用问题。

• 我们正在努力扩大以循证为基础的预防干预措施，以帮助年轻人发展应对生活压力的技能。根据黎巴嫩的情况，与教育部合作实施针对校内和校外精神卫生和预防有害物质使用的生活技能教育方案。将开展对将这些内容纳入课程的可行性研究。

• 心理健康服务正在纳入初级保健中，社区心理健康精神卫生中心正在发展，以增加高质量精神卫生服务的可获得性、可及性和可负担性，以便于早期识别和管理自伤/自杀和优先的精神问题。这一发展包括利用世界卫生组织的精神卫生差距行动干预指南(世界卫生组织，2019b)发展初级卫生保健工作者的能力。

• 在不同部门的人力资源方面，有关于精神卫生（包括自杀）的能力建设，包括：

»全国精神卫生培训课程，包括针对社会工作者和从事儿童保护和性别暴力的一线工作者的有关识别和管理自杀的能力建设的培训；

»情绪危机管理方案和培训，包括针对任何行动部门的一线工作者的关于识别和管理自杀的能力建设的培训。

• 精神卫生已纳入应对性暴力和基于性别的暴力的方案中。在这方面，与识别精神障碍和自杀风险有关的问题被纳入到由社会事务部制定的应对性暴力和基于性别的暴力的国家标准操作程序的评估工具中。我们制定了一个明确的自杀风险管理方案。这也有助于早期识别和管理。

在哪里？

“LIVE LIFE”的核心支柱和关键干预措施都需要多部门合作。领导工作应由政府（通常是卫生部）负责，并必须辅以各级部门和利益攸关方的参与，如国家和地方当局、行政人员和社区中的个人/组织。例如，在伊朗 伊斯兰共和国，每个地区的省长组织定期举行部门间会议，由主要部门（卫生、农业、福利、警察、法律医学、慈善、教育）担任代表，讨论成就和挑战。

[15] Preventing suicide in Lebanon (infographic). Beirut: Ministry of Public Health, Lebanon (https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Worls%20Suicide%20 Prevention%20Day%202020-Advocacy%20brief-Eng.pdf, accessed 28 January 2021).

专栏 8. 改编以适合地方实施和优先人群

在地方政府当局的有效领导下，地方行动计划是将国家自杀预防策略在地方和优先人群中落地而量身定制和协调实施的一条途径。地方计划应根据当地社区的需要和可用资源进行调整，这些资源可能与国家层面确定的资源不同。

日本就是一个例子，根据《国家自杀预防行动计划》，法律要求地方市和县制定实施自杀预防措施的地方计划。这是加快日本自杀预防实施的理想方法，因为地方当局离社区的居民更近。所提供的指导意见明确说明了当局（包括多个市区）在支持地方市政部门工作上所起的作用。政府和日本自杀对策支持中心(JSSC)在财政上和技术上都支持地方政府的规划。

英国公共卫生支持所有基层政府制定多机构自杀预防计划，所有基层政府将在 2019 年 4 月之前制定计划。《国家卫生服务(NHS)2019/20-2023/24 年精神卫生服务实施计划》的实施包括定向资金，以支持实施多机构自杀预防计划。这些计划纳入所有主要的地方法定机构和志愿部门，持续不断努力进行自杀预防。当地策略和计划描述了将在各个机构采取的旨在减少英国各个地区的自杀具体行动（基于英国国家策略、英国国民保健服务体系和英国国民保健服务改善和公共卫生指南以及国家和地方数据）。这种方法的成功归功于必须在获得支持资金之前提交详细的计划；将地方计划与国家指南保持一致；并安排学习交流日——让获得资金的不同地点可以相互学习并分享经验。国家和地方自杀预防的努力仍然是政府的高度优先事项，目前正在开发一个由英国公共卫生部门领导的国家实时自杀监测系统。英国国民保健服务计划和国民保健服务改善计划将启动精神健康安全改善方案，重点支持精神健康信托基金，以减少去精神健康服务机构就诊者的自杀率。

什么时候？

在实施“LIVE LIFE”时应尽早考虑多部门合作。虽然一些合作可能是临时的，以满足特定的需要，但持续的多部门合作应成为所有自杀预防活动的一部分，其益处已在前面述及。在启动潜在的合作时，考虑政府和潜在合作伙伴是否做好准备情况是有益的[16]。

[16] 这包括一个部门所做出的有关改正的承诺，并且相信他们有能力做到(Weiner, 2020)。

专栏 9. 不丹：政府如何促进多部门合作

2015 年，不丹向总理主持的内阁成员和议员提交了一份关于不丹自杀情况分析的报告，由此不丹有了对自杀预防的政治支持。考虑到这个问题的规模和严重性，政府指示建立一个专门的自杀预防的方案/单位。在此之后进行了一项全国性的自杀案例报告研究，以此作为并成为国家战略行动计划的基础。该计划在 2016 年制定并投入实施。卫生部设立了一项国家自杀预防项目，以协调全国各地的自杀预防应对措施，并使利益攸关方继续参与提供自杀预防服务。由于自杀预防是多方面的，涉及各种主要利益攸关方，因此成立了一个国家指导委员会，为多部门应对提供推动力，并让政府了解自杀应对的挑战、问题和进展。来自各部门的负责任的合作机构被呼吁作为利益攸关方。由这些利益攸关方来实施自杀预防行动计划，并创建一个平台来讨论进展、挑战和问题以及前进的道路。利益攸关方包括：卫生部；教育部（青年和体育部）；内政和文化事务部（地方政府部）；不丹皇家警察；不丹麻醉品管制局(BNCA)；国家妇女和儿童委员会(NCWC)；RENEW（非政府组织）——尊重、教育、养育和授权妇女；媒体（电视、国家报纸、广播）；农业部；KGUMSB（不丹 KheserGyalpo 医科大学）；不丹信息通信和媒体管理局(BICMA)；以及德拉特尚（修道院事务委员会）。

谁来做?

在“LIVE LIFE”等国家活动中，领导应来自政府，特别是卫生部，以识别可能没有参与合作的利益攸关方，并将他们团结在一起（部门和利益相关方清单见附录 1）。当然，地方当局也可以领导协调地方利益攸关方。例如，在澳大利亚，Lifespan 是一种综合的自杀预防方法，初级卫生网络领导多部门的合作，以确保活动由社区主导[17]。主要的合作伙伴包括有自杀相关经历的人。一个独特例子是由公私合作伙伴和高层政府的承诺来推动一些变革。

专栏 10. 美国：建立公私伙伴关系

美国自杀预防行动联盟是一个公私合作伙伴同盟，包括 250 多个合作伙伴，并全面协调国家的自杀应对策略。2012 年，行动联盟汇集了不同的公私利益攸关方，包括政府代表、国家非营利组织和公共部门团体、自杀预防专家、卫生保健提供者和有相关经历的人。全国联盟的工作包括推进国家策略，优先考虑加强自杀者照护的三个工作领域，加强基于社

[17] Integrated Suicide Prevention, Lifespan (https://www.health.act.gov.au/about-our-health- system/office-mental-health-and-wellbeing/lifespan, accessed 28 January 2021).

区的自杀预防，以及改变对自杀的看法的全国对话。几个关键因素促成了行动联盟的工作。首先，联邦政府内部的一位领导认识到，一个强有力的公私合作伙伴同盟可以为减少全国自杀率做出重大贡献，并愿意成为这一行为的捍卫者。其次，多个联邦机构和部门愿意参与，并希望允许他们成为该活动中的平等伙伴。第三，愿意使用联邦资金美元进行初始投如，一直能获得私人资金融资。行动联盟于 2010 年 9 月 10 日成立后，卫生和人力服务部长和国防部长联合工作，陆军部长愿意担任公共部门联合主席，一位前美国参议员（儿子因自杀死亡）愿意担任私营部门联合主席，这些都生动地体现了高水平的协作。联邦政府的这种高层参与也增加了来自多个部门的私营部门领导人参与支持的可能性。

一直以来，政府中高级别的支持对自杀预防的多部门合作都具有重大影响，对实施“LIVE LIFE”的措施也有着巨大影响。由政府来推动则表明，自杀预防需要不同的政府部门共同努力，而自杀预防并不仅仅由卫生部门负责。斯里兰卡的自杀预防总统特别工作组、日本政府，还有英国首次任命自杀预防部长来主管自杀预防、心理健康和患者安全，都体现出了这种影响。

专栏 11. 澳大利亚：最高层的影响力

自 1997 年以来，澳大利亚采取了主要通过卫生部门（国家和州一级）来推动全国预防自杀的方法。在认识到需要整个政府参与实施措施时，政府于 2019 年任命了第一位国家自杀预防顾问，并直接向总理报告。为了支持总理的国家自杀预防顾问的工作，国家自杀预防工作组于 2019 年 8 月成立，与卫生部和总理和内阁，以及和来自诸多联邦政府机构的副职联合管理。成立了一个行政联邦自杀预防部门间高级委员会，以促进在整个政府范围内对自杀预防行动的投入和建议。任命了一个专家咨询小组，以确保顾问能够通过有相关经历的人员、自杀预防研究专家、土著和托雷斯海峡岛民自杀预防专家以及与自杀预防有关的社会和社区政策专家来获得专业人士的持续建议。

专栏 12. 包括有自杀相关经历的人

有自杀相关经历的人应该被纳入到“LIVE LIFE”的各个方面。他们的见解至关重要，将有助于确保活动能够满足那些有自杀风险者的需要。让有相关经历的人参与进来，将确保需要支持的人的实际需求得到满足。他们的专业知识对于告知、影响和加强自杀预防的所有方面至关重要。此外，他们的参与可以帮助为那些正在经历或受到自杀行为影响的人或自杀者亲友提供有希望的例子。每个支柱和干预措施的工作组都应纳入有相关经历的人

积极参与活动规划、完善、实施和评估。所有工作组都应遵循一种参与性进程，也要考虑到有相关经历的人的声音。

这种参与并不是象征性的，而是通过将有相关经历的人的反馈纳入到活动方案设计、政策改革、服务增强甚至重新设计方案，要听取和重视他们的观点。在规划“LIVE LIFE”时，应分配足够的时间和资源，以便与有相关经历的人一起开展工作。对于有相关经历的人来说，参与工作可能会促发一些情绪，有时还具有挑战性，因此在讨论某些方面（例如自杀方法的细节）时应该谨慎。应该制定相关规定以确保他们在参与期间得到充分的支持[18]，并应考虑保持匿名的措施。

在自杀预防领域，“有相关经历的人”一词指的是曾参与自杀行为的人，包括有自杀想法的人，以及因自杀而失去亲人的人，如家人、朋友和同事（也称为幸存者或自杀者亲友）。终身经历框架（LifeSpan Lived Experience Framework）[19]是一个将有相关经历的人整合入一个组织的工作框架。海洋玫瑰（Roses in the Ocean）项目[20]是为有相关经历的人有效和安全地进行这种整合的一个最佳实践。附录 2 提供了苏格兰有相关经历者参与工作的例子。

怎么做?

1. 组成一个指导小组，制定协作愿景（见引言专栏 1）

- 确定将在建立和监督合作中发挥关键作用的个人。决定能够召集合作者和协调活动的领导力。关键是让相关的预算持有人和国家/地方政府领导人参与进来。
- 考虑协作的目标和范围，了解您希望通过协作实现什么，并确定成功将是什么样子的（另见附录 3 和**监控和评估**）。
- 制定合作的资金计划，例如考虑到时间、运输和活动。

2. 确定合作者，并决定参与的方法

- 进行给协作者画像时（例如，在情况分析期间）要考虑到潜在协作者的以下信息：
  - » “LIVE LIFE”中的角色；
  - » 目前对自杀预防的参与和态度；

[18] Storytelling for suicide prevention checklist. National Suicide Prevention Lifeline (USA) (https://suicidepreventionlifeline.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeline-Storytelling-Checklist.pdf, accessed 28 January 2021).
[19] LifeSpan lived experience framework. Black Dog Institute (Australia) (https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/bdi_lived-experiencesummit-2018_final.pdf, accessed 28 January 2021).
[20] Roses in the Ocean (Australia) (https://rosesintheocean.com.au/, accessed 28 January 2021).

» 不愿/讨厌从事自杀预防工作的潜在原因；

» 文化或宗教信仰，社会和经济环境和通常的沟通渠道；

» 与其他部门/利益攸关方之间的关系；

» 权力/影响力，以确保来自所有合作伙伴的参与和建议的改变能够付诸行动；

» 他们能对协作工作做出的贡献（例如，资源、技能）；

» 参与对他们的好处（这可以在他们试图参与时强调）；

» 与他们的参与相关的任何问题（可能的冲突、障碍、限制）。

- 明确吸引合作者的技巧，例如：

» 谅解备忘录或合作备忘录（例如，政府部门之间）；

» 公开会议；

» 讨论组

» 专题讨论会

» 个人会议/访谈；

» 提高意识的事件；

» 互联网（调查问卷、咨询、电子邮件）。

3. 合作者参与

- 在与合作者接触时，请讨论以下几点：

» 自杀预防工作的重要性；

» 合作者在自杀预防中的作用；

» 他们的参与对自己和“LIVE LIFE”的实施的潜在好处；

» 使用适当的语言；

» 尊重不同的观点；

» 他们可能对参与其中而产生的任何担忧。

4. 召开首次合作会议

- 同意合作的共同目标。
- 考虑每个合作伙伴可以给协作带来什么（资源、技能、关系/影响领域），以及合作者是否有任何需要协商的需求/约束条件。
- 定义每个合作者的角色和职责。
- 为合作制定明确的指导方针/规则，并确定不满足这些时应遵循的程序。

• 制定一个行动计划：确定一组最初可以优先考虑的短期和中期行动计划，并附有一个长期完成的时间表。包括 SMART 目标[21]，并考虑如何为行动提供资金。

• 建立问责机制以加强透明度：应明确界定行动计划和利益攸关方的承诺，并公开。

5. 开始合作，监测和评估进度（参见监控和评估）

• 为与合作者的定期会议创建一个日历，以检视行动计划的进展，并作出调整或制定新的行动。商定应完成行动的时间表。

• 讨论任何挑战和经验教训。

• 定期对合作者参与进行正式评估；如果可能，应由独立方进行评估。

专栏 13. 印度：社区领导，拯救生命

在印度南部的金奈，一座位于狭窄的绿树成荫小巷里的不起眼建筑里，有一个拯救了无数生命的组织。这个非政府组织 SNEHA 的志愿者们自己也不知道他们从自杀的悬崖上挽救回多少人。作为精神病学专业的学生，对其他事情我们能做的很少，但对于像自杀这样可以预防的事情，却没有人做任何事情，这促使了 SNEHA 的开始。

在 1986 年 SNEHA 工作开始初期，自杀是被社会污名化的。由于志愿服务、情感支持和自杀预防的概念很模糊，最初的情况很艰难——以至于很难租到一个地方来做这项工作。SNEHA 的工作逐渐缓慢而稳定地得到了公众、媒体和心理健康专业人员的认可。在过去的几十年里，SNEHA 拓展了其旨在提升社区意识的自杀热线工作，开始参与解决政策问题，发展创新的社区干预措施来减少自杀。在 21 世纪初，SNEHA 的志愿者们开始注意到，在每年的 6 月，来电者的数量显著增加。志愿者们 24 小时轮班，以处理在此期间因考试失败而自杀的学生的求救需求。大多数自杀死亡的学生不过是一两个科目不及格而已。然而，仅仅带着同情心去倾听是不够的——如果要拯救年轻一代的生命，需要改变政策。我们与泰米尔纳德邦政府大力游说，要求引入补考，使学生可以在两个月内重新参加考试，而不会失去一个学年的机会。这项工作得到了媒体的广泛支持。

2002 年底，泰米尔纳德邦政府宣布为在三门课中不及格的学生开设特别补考。尽管新政策直到 2004 年底才公布，但这项政策在 2003 年就实施了。自从该邦开始呼吁补考机会，学生自杀的人数就减少了近 50%。他们有第二次机会考试似乎使结果发生了巨大改变。希望感似乎创造了奇迹，其他几个邦也纷纷效仿。

[21] SMART goals are actions that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm, accessed 28 January 2021).

居住在泰米尔纳德邦的斯里兰卡难民自杀的人数不断增加，这促使另一个非政府组织通过 SNEHA 来解决这个问题。设计了一个名为接触和安全计划(CASP)的低成本伙伴干预措施。在第一年结束时，被干预难民营的自杀行为显著减少(Vijayakumar 等，2017)。SNEHA 的社区干预策略一直是低成本、非劳动密集型，并基于同伴支持。实际上，这些策略可以在世界各地成功地复制。

2017 年，经过 SNEHA 与印度政府就将自杀行为合法化进行长达数十年沟通后，殖民时代的法律最终因《心理健康法》的通过而被废除。SNEHA 还不断提倡在包括卫生部在内的最高级政府中制定国家自杀预防策略，通过这些努力成立了一个委员会，并起草了一项国家行动计划。SNEHA 的故事同时也是一个如何不忽视年轻人自杀，并立即采取紧急行动拯救生命的故事。它显示了社区行动可以达到的程度。

专栏 14. 斯里兰卡：总统预防自杀特别工作组

1995 年，斯里兰卡是世界上自杀率最高的国家。因此，当时的总统在 1997 年任命了一个总统特遣小组，在斯里兰卡应对自杀事件。工作队取得成功的一个关键因素是总统任命它的权力，使所有部门能最大程度的合作。

多部门工作队由来自卫生、教育、农业、社会发展、社会服务、大学和提供社区服务的非政府组织的代表组成。这种多部门合作取得成功的主要原因是工作队的组成、主席的热情和当局的任命。此外，还考虑到当局行政(如农药登记官、Samurdhi（发展财政）管理局主任和卫生教育局主任)以及技术专家（如公共卫生官员、社会学家和精神病学家）的平衡。工作队根据证据和协商一致的意见提出了其建议。

工作队不仅建议采取自杀预防的干预措施，而且还在此后的几年里继续在基层监测这些建议的执行情况。在社区层面成功执行的关键因素包括工作队和社区之间的合作办法、一个解决农村自杀的决定因素的专门方案，以及监测和评价。

在斯里兰卡，重要的是要在适当的时机利用政治权力的资源来完成相关工作。对于类似于斯里兰卡的其他国家，公共卫生专业人员应准备在最高级别的权威支持下，根据各自文化背景的最佳现有证据采取行动。

实施过程的提示

表 3. 实施多部门协作的技巧

问题	提示
预防自杀并不是其他部门/利益攸关方和/或国家领导层的优先事项。他们认为，自杀预防只属于卫生部门。	• 利用宣传手段呼吁：自杀预防不仅是卫生部门的工作，需要合作。 • 认识到自杀预防本身就是一个问题，需要考虑所有潜在的危险因素，而不仅仅是心理健康状况。 • 定期与其他部门和利益攸关方举行会议，强调预防自杀的道德、政治和经济价值，并促使他们提高认识。 • 增加其他部门自杀预防的预算，使他们能够参与到工作中。将具体预算分配给特定的“LIVE LIFE”支柱和干预措施，以便这些预算得到充分的资源，而不是被视为有关部门的日常活动。 • 定期向利益攸关方反馈成功的预防活动，以保持其参与度和参与势头。 • 考虑将自杀预防行为纳入其他优先考虑的公共卫生政策和方案中（如心理健康、酒精、预防暴力）。 • 在有对自杀歧视的地方，让伴侣参与提高意识的讨论，提供信息，消除关于自杀的误解。 • 找到拥护者(即那些非常关心自杀预防并愿意扮演领导角色的人)，他们可以帮助吸引同行。最好有一个以上的拥护者，因为人们的角色会在实施过程中发生变化。
利益冲突(包括在行动和提供资金上的)	• 定义共同的目标和要努力实现的目标。 • 确定合作者的角色，并制定透明度和问责机制，以确保他们的贡献与角色一致。这应包括对预算分配透明管理。 • 定期评估协作情况，并解决出现的任何问题。 • 确保合作者的努力在内部和外部的沟通中完全得到承认。 • 确定共享资金或资源的分配机会，以确保利益攸关方不会争夺相同的资源。

问题（续）	提示（续）
缺乏团队合作精神和协调能力	• 清楚地确定每个利益攸关方的角色。 • 组织定期会议，以维护关系和检视行动 • 为不同利益攸关方建立会议沟通渠道，及时分享信息，减少重复。 • 确定共同的目标，可以帮助团结个人以达到共同成就。 • 建立管理和问责体制；公开计划；并就利益攸关方难以履行其责任时采取一致行动。
领导力不足或无效	• 学习如何与一系列的利益攸关方进行沟通和工作。 • 了解有效和无效领导力的特点，从而帮助避免陷阱，加强领导力[22]。 • 在领导层更替率高的地方，考虑将有助于保持连续性的机制——例如，在过渡时期能够履行角色的人，或联合领导。 • 确保规划和行动包括来自所有级别的合作者的参与，而不是依赖于自上而下的方法。 • 努力在几年内获得资金，为制定和评估倡议提供时间。

[22] Leadership and legacy wheel. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/grantees/core-competencies/leadership; https://www.sprc.org/resources-programs/legacy-wheel, accessed 28 January 2021).

提高意识和宣传

是什么？

提高意识和宣传工作是解决自杀预防等经常被忽视的公共卫生问题的重要活动。提高公共卫生认识是一个有组织的沟通过程，目标是增加公众的知识，并改变其对一个重要的公共卫生主题的态度、信念或行为。宣传可以与提高认识相结合，提倡必要的改变以解决问题。

通过提高认识，在国家和社区层面都可以看到，对服务和支持需求的增加。这意味着，负责提高意识工作的人应该为这种增加做好准备（见**早期识别、评估、管理和随访**，以及**能力建设**部分）。

提高意识会引起人们对自杀预防相关信息的注意，例如：

- 自杀是一个严重的公共卫生问题。
- 受影响的人可以寻求帮助。
- 如何识别和支持一个有自杀风险的人。
- 如何展开一场关于自杀的对话，如果有人想自杀，该如何做出适当的回应。

倡导者试图带来改变，通常是在政策层面上，通过倡导：

- 将有更多的资金用于自杀预防的措施；
- 立法上的变化，如非罪化；
- 将自杀预防纳入学校、工作场所、卫生系统；
- 国家自杀预防策略；
- 改进的自杀和自伤监测系统；
- 对高危人群的资源和支持。

值得注意的是，在提高意识的宣传中使用的语言不要正常化或污名化自杀（关于语言使用的建议见参考资料）。虽然可以承认，自杀的想法可能会在个体整个生命过程中出现，但需要强调提供和寻求支持的重要性。不仅要考虑你所交流的内容，还要考虑你如何交流。确保信息传递能够解决对自杀的神秘化和误解，并使用既不耸人听闻也不具有煽动性的语言。

为什么？

提高意识和宣传是通过影响决策者和公众的意见、态度和行为进而致力于全面预防自杀工作的战略行动。

对于决策者，宣传：

- 有助于增加政治承诺和增加对自杀预防措施的资源分配；
- 用于影响非卫生领域的利益攸关方，了解其在自杀预防方面的作用，包括但不限于农业、运输、司法、社区以及私营和劳工部门。

对于公众来说，提高公众意识可以：

- 告知自杀是一个严重的公共卫生问题，值得关注；
- 通过消除神秘化或误解，处理关于心理健康和自杀的态度或信念的问题，包括对自杀未遂者和自杀者亲友的态度，来减少自杀的耻感；
- 提高对在支持风险人群中的个人角色的认识；
- 通过提供帮助和求助行为来鼓励他人；
- 提供关于在哪里寻求帮助的知识。

专栏 15. 肯尼亚：提高意识创造了对服务的需求

在没有国家自杀预防策略的情况下，肯尼亚益友会在预防自杀方面有着既得利益。通过为遭受高度痛苦的人提供倾听服务、协调世界预防自杀日的活动、与媒体合作以及进行守门人培训，肯尼亚益友会发现对提高意识相关课程和培训的需求有所增加。这些需求表明，肯尼亚益友会提高自杀和自杀预防意识的努力使人们对此产生了兴趣。作为回应，肯尼亚益友会提供培训，例如为社区层面的守门人提供培训，使特定的社区团体具备必要的知识和技能，这有助于减少自杀的污名化和促进寻求帮助的行为，从而有助于自杀预防。肯尼亚益友会开展的提高意识活动也为该国预防自杀的宣传工作提供了一个平台。

在哪里？

提高意识和宣传自杀预防的范围可以从在单一社区地点（如村庄或工作场所）进行的活动扩展到全国性的公共传播活动。可以将对变革的倡导纳入到提高意识中（例如与政府和非政府组织举行的联席会议活动）。可以通过一个广泛可得性和常用的社区渠道（如无线电广播，或在一个社区或信仰会议）传播信息，或通过多渠道传达给不同的受众并扩大

地理覆盖面（如社交媒体、印刷媒体、电视、广播、新闻发布会、会议或研讨会、印刷广告或广告牌）。

什么时候？

提高意识可以通过静态交流的方式不断实施，如在社区内的广告牌定期印刷新闻、广告或海报，这样寻求帮助的人或者可能有自杀风险的人就可以看到它们（例如在学校、警察局、公共交通、卫生服务部门）。重要的是要评估这些行为的影响并发给决策者，以证明持续提供资源活动的好处。地方或国家的自杀预防焦点中心可以在相关议程中继续提倡自杀预防。

专栏 16. 日本：全国自杀预防意识提高月

为了集中力量和资源，各国可以选择一段特定的时间来提升自杀预防的意识。例如，2010 年，日本将 3 月份作为其国家自杀预防意识月。之所以将这个月赋予特殊意义，是因为人们发现日本 3 月份的自杀率显著增加[23]。最近，日本在交通系统上张贴了海报，以提高人们的意识。

各国和社区可以利用全球公共卫生日的机会，通过开展活动，进一步努力提高自杀预防意识。这种活动可以针对全人口和/或针对选定的群体。

每年值得注意的与自杀预防有关的日期有：

- 9 月 10 日：世界预防自杀日(WSPD)。
- 10 月 10 日：世界精神卫生日。
- 11 月（每年日期会变化）：国际自杀者亲友日。

利用全球日的好处是，既往大规模努力开发的资源可被许多其他人共享和利用。世界自杀预防日是由国际自杀预防协会(IASP)组织的。IASP 通过收集、分享和提供资源材料和活动来支持各国家的活动。自 2003 年成立至今，已经在 70 多个国家开展了数百项活动。这些活动包括教育和纪念活动、新闻发布会、会议和广泛的社交媒体报道[24]。后续活动（例如在这些全球日期后的两周）是加强活动日效果可持续性的有效方式。

---

[23] Japan turning a corner in suicide prevention (https://www.who.int/mental_health /suicide-prevention/japan_story/en/, accessed 28 January 2021).
[24] Suggested activities by the International Association for Suicide Prevention (IASP) (https://www.iasp.info/wspd2019/suggested-activities/, accessed 28 January 2021).

谁来做?

提高意识和宣传需要多个利益攸关方的合作。在国家层面，领导力可以来自卫生部和媒体之间的合作。媒体是提高公众意识的重要合作伙伴。与媒体的伙伴关系应被视为持续提高意识和宣传工作的一个关键组成部分(见**与媒体互动促其负责任地报告自杀**部分)。

在社区层面，领导力可能来自于对自杀预防有既得利益的个人或组织。利益攸关方可能包括有相关经历的人、目标受众的代表或非政府组织。应包括有提高意识的经验的人（例如在其他公共卫生领域)。

专栏 17. 苏格兰：看见我——解决自杀耻感问题

苏格兰政府的自杀预防行动计划的关键战略目标之一是确保自杀不再受到污名化。为了这一目标，努力开展了全面降低关于心理健康的污名和歧视。另外两个战略目标，即有自杀风险的人感到能够寻求帮助，以及受自杀影响的人并不孤单，也被涵盖其中。消除因精神问题或痛苦而寻求帮助的耻感，对于确保人们在想要自杀前就说出自己的感受是至关重要的。看见我——苏格兰结束精神问题耻辱和歧视的方案——的工作重点是在三个核心领域减少不平等，并将精神问题纳入其中。在教育方面，年轻人和成年人在生活中有共同的语言去谈论心理健康问题，这样年轻人就不会害怕说出来。在工作场所，雇主与“看见我”一起改进可能导致歧视的政策和做法，并改变企业文化，让员工感到能够说出自己目前内心的挣扎，工作场所也可以进行合理的调整来支持他们。在卫生保健方面，“看见我”致力于促进有痛苦经历的人参与对卫生保健工作人员的培训，使后者意识到给予非同情和轻视的反应所造成的负面影响。这项工作是由当地合作伙伴，跨部门的合作伙伴和那些关注高危人群的人支持完成的，再加上苏格兰不断增多的社会运动，这一切都在改变苏格兰关于精神问题的文化，这样一来，人们不再感到孤独，可以在痛苦时寻求帮助。

自杀预防旗手可以加速意识唤醒和加强宣传。该旗手可以是有影响力或被公众所熟知的社区成员（如信仰领袖，或当地政治家）或那些已经承诺和表达了关注精神问题和自杀预防感的国家或全球名人——如由大不列颠和北爱尔兰联合王国皇家基金会领导的剑桥公爵和公爵夫人。

有相关经历的自杀预防工作旗手可以帮助吸引人们的注意，也可以推动增加大规模的自杀预防措施，比如美国的《加勒特·李·史密斯纪念法案》[25]。该法案随后向美国所有州提供了青少年自杀预防拨款，包括学术机构和 50 多个原住民部落。研究证据显示，接受政府资助的地区的青少年自杀率有所下降(GodoyGarraza 等，2019)。

提高意识和宣传的旗手还包括对自杀预防有兴趣的人或组织，如非政府组织、卫生、社会保健和科学领导人、或自杀预防倡导者，也包括其家庭成员。

专栏 18. 美国：有个坚定而忠诚的旗手

1996 年，联合国发布了一份题为《预防自杀：制定和执行国家策略指南》的文件。该文件呼吁各国政府制定一项预防自杀的国家策略，并建立一个负责自杀预防行动的协调机构。来自佐治亚州玛丽埃塔的杰里和埃尔西·韦拉奇响应了这个行动的号召，他们 34 岁的做医生的女儿特里自杀身亡。他们领导了自杀者亲友的行动，并创建了一个名为美国自杀预防倡导网络(SPAN-USA)的非营利组织，该组织改变了美国对自杀的应对方式。这对来自佐治亚的夫妇和其他无数加入他们的人对美国第一个国家自杀预防战略的发展起到了重要作用。这些幸存者的声音引起国家立法者的注意，悲伤变成了行动，痛苦变成了承诺，伤害变成了希望。1997 年，美国参议员哈里·里德分享自己父亲多年前自杀的故事，韦拉奇夫妇联系到他的办公室并请求他支持提出一项议案(S.Res.84)——呼吁将自杀视为一个国家问题、国家需要应对这个问题并且要建立国家自杀预防策略。这项决议案在提出当天获得一致通过，并得到了所有 100 名美国参议员的批准，另外还发起了全国运动，强调自杀是一个主要的死因。1998 年，在内华达州的里诺举行了一次全国会议，召集了自杀者亲友、学者、决策者、临床医生和其他人，为美国第一个自杀预防国家策略奠定了基础。在 1999 年提出了最初的行动呼吁后，2001 年发布了第一个策略，2012 年进行修订，于 2010 年成立协调机构。正如玛格丽特·米德曾经说过的那样，“永远不要怀疑一小群有思想、忠诚的公民能够改变世界；事实上，这是唯一拥有的东西。”正是像参议员哈里·里德、杰里和埃尔西·韦劳奇夫妇、参议员戈登·史密斯夫人这样的旗手，揭开了自杀的神秘面纱，并促使一个国家采取关键措施，致力于应对这一公共卫生挑战。正因为他们孜孜不倦的努力和无私的服务，才有了现在的国家自杀预防策略、监督其实施的协调机构、国家自杀预防资源中心、国家生命热线，解决全国自杀问题的基础设施和帮助社区解决当地自杀的拨

[25] 一件不幸的事情促使自杀预防发生变革。加勒特·李·史密斯，参议员戈登和沙龙·史密斯的儿子，在 2003 年自杀死亡, 这件事情促使加勒特·李·史密斯纪念法案得以通过。

款。这些人将永远被人们铭记，他们因失去亲人而做出的努力，帮助国家应对自杀给健康带来的挑战。

专栏 19. 伊拉克：把悲伤变成了对自杀的行动

有些人说，时间可以治愈所有的伤口。我们相信，只有时间和行动才能帮助我们在失去亲人后愈合伤口。在我们的小儿子塔巴自杀后我们处于悲伤中，于是我们开始接触其他自杀者亲友——那些亲人自杀后遭受痛苦的人。我们努力为他们提供一切有限的支持，以引导他们度过悲伤，努力不断摆脱对自杀的社会耻感，同时提醒他们，他们并不孤单。

塔巴的死完全改变了我们。我们意识到，通过分享我们自己的经验，我们可以帮助那些经历过类似丧失事件的人，让他们感受到他们不孤独或被抛弃。我们通过研究和反思很快认识到，与当地的论调相反，自杀实际上是可以预防的。在缺乏专门的政府帮助，和专注于系统性预防自杀和支持幸存者的非政府组织的情况下，我们决定通过成立 Azhee，自己采取行动。

2019 年正式注册 Azhee 为非营利非政府组织的几个月后，在国际移民组织(IOM)的支持下，我们组织了一个全国会议，恰逢世界自杀预防日，大约 100 名自杀未遂者、学者、国家和国际非政府组织、外交官、政府代表和联合国机构参加了相关的自杀预防日活动。会议成功地实现了让媒体和学术界更加关注自杀问题以及采取急迫措施预防自杀的目标。在这次活动期间，我们重申了敲定一项急需但已被搁置的国家自杀预防策略草案的重要性。

为了纪念今年的世界自杀预防日，我们举办了一个远程研讨会，以启动旨在最终确定政府批准的战略草案的审查程序。基于 Azhee 努力的基础上，伊拉克部长理事会秘书处和国际移民组织于 2019 年 11 月在巴格达举行了为期两天的会议，共同主办了 Azhee 和高级部长代表的会议，以巩固我们最终确定自杀预防战略的努力。虽然我们自成立以来取得了很大进展，但我们继续面临诸如个人和社区层面的对自杀的耻感，以及组织层面缺乏资金等挑战。我们仍然致力于在未来的几年里克服这些问题。

我们儿子的故事结束了，但我们的故事却没有结束。我们创立了 Azhee（德语单词，意思是他/他的生活），因为我们可以在这里纪念我们因自杀而失去生命的亲人，并怀念他们和我们一起度过的时光。我们希望别人能欣赏和珍惜他们的生活，幸福地生活，并利用他们在这个世界上的时间来造福自己和他人。作为 Azhee[26]的创始人，以我们对塔巴和无数其他人的爱的名义，我们倡导加强社会对心理健康重要性的理解和认识。

[26] 参见：www.azhee.org, accessed 28 January 2021.

怎么做?

1. 召集一个工作组（见引言专栏 1）

- 建立工作组（参见上面的“谁来做？”部分）
- 确保利益攸关方（见附录 1 的部门和利益攸关方清单）参与到整个规划和实施过程，因为他们及其合作伙伴对信息传播至关重要。

2. 确定目标

- 考虑如下目标，以及它们是否支持其他“LIVE LIFE”的干预和支柱。例如，可以提请人们意识到自杀应被视为一个严重的公共卫生问题，提高对现有支持服务的认识，或提倡为具体的自杀预防干预措施提供资源。
- 确定目标受众。为了提高意识，利用现有的情况分析或相关的信息来源确定优先的目标群体（即那些高自杀率或寻求帮助率过低的群体）。关于宣传，请考虑适当的决策者或资助者，以满足宣传的目的。当它们针对特定的受众（例如决策者、青少年）时，沟通最有效。如果社区对自杀问题有非常强烈的看法，那么就必须在采取行动之前与关键利益攸关方进行讨论，以保持合作伙伴关系。
- 决定实施的时间。选择可完成一个持续的活动和行动的日期、指定的国家意识月、指定的全球提高意识日或其他重要的日期（例如，压力比较大的时间，如学校或大学考试）。确保目标能够在规定时间内实现。
- 考虑是否可以利用可用的资源来实现目标。考虑是否可以将活动和资源纳入到其他相关公共卫生问题的提高意识行动中。
- 决定如何评估这些影响并进行交流。应事先规划一个制度来监测和评价提高意识或宣传的效果（见下文第 5 点以及监控和评价部分）。

3. 确定活动或交流的传递方式和信息传播

- 评估哪种传递方式将会：

1）达到目标；

2）适合于目标受众；

3）确保所投入的努力有足够的影响和覆盖面。

- 确保信息内容是循证的[27]。

[27] 参见一个例子，即 WHO 事实清单：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide, accessed 28 January 2021).

• 根据目标人群来调整这些方法和信息。考虑年龄组（例如青少年可能更喜欢与其他年龄组不同交流的方式）、性别（调整语言或图片）、社区的社会人口构成（例如主要语种；代表社区的图片和语言，例如种族、是否是移民、宗教）；人群的读写能力（例如基于口头或图片的信息）；背景（例如，当没有互联网接入时，广播或社区活动可能更可取）。

• 计划采用多种信息传递方式，特别是针对具有不同社会文化背景的人群。

4. 检查信息和信息传递方式的可接受性、可理解性和可行性

• 让相关利益攸关方在目标受众的小样本中测试活动的可接受性和潜在影响。

• 这还可以包括确定决策者的宣传是否可以接受，并将产生预期的影响。

• 对信息进行必要的修改，并为信息传播阶段找到合适的利益攸关方。

5. 实施该活动并评估其有效性（另请参见监控和评估）

• 回顾一下目标，思考如何评估是否已经成功地提高了大家的意识。如果可行，在进行提高意识活动之前进行基线调查，以确定目标受众的知识、态度和行为。

• 在吸取的经验教训基础上，为修订下一个行动提供信息。

• 评价该活动的报告应被分发给所有有关的利益攸关方和决策者。这种报告可以通过宣传的形式强调提高意识的作用。

实施过程的提示

表 4. 实施技巧，“LIVE LIFE”的意识提高和宣传

问题	提示
没有时间做计划	• 减少活动和消息的数量以合理地安排时间。考虑安排另一个宣传日期。 • 确定发布信息的优先目标人群和时间。 • 使用 SMART 目标[28]安排计划。

[28] SMART 目标是具体(specific)、可测量(measurable)、可实现(achievable)、相关(relevant)及有时限(time-bound)的目标.

问题（续）	提示（续）
在耻感和/或缺乏支持服务的情况下，如何讨论自杀问题有顾虑	• 提高意识活动应该讨论耻感。应为有需要的人提供支持。 • 让公众参与能够提高公众意识的活动。例如，创建一个在线/本地的挑战任务，让公众分享他们如何关爱自己的心理健康[29]。
资金和/或资源有限，影响活动举办和覆盖范围	• 如果不可能获得更多的资金，那就在现有的预算范围内开展工作。 • 降低活动的地域覆盖范围和数量。 • 确定一个优先目标人群，减少对多种传播方法和改编多种版本的开发需求）。 • 优先考虑哪种传递方法最具成本效益且有助于实现目标。 • 考虑是否可以与利益攸关方一起汇集资源，或者考虑是否可以将提高对自杀预防的认识合并到其他相关(例如心理健康)的活动。 • 考虑利用其他举措，或与当地利益攸关方合作，在他们的活动和仪式中增加自杀预防信息。 • 与可能捐赠发布空间的媒体接触。 • 向潜在资助者展现对某一活动的评估结果，可能有助于获得未来的经费支持。
缺乏明确的结果	• 活动应该有明确的重点和行动呼吁，例如人们去寻找支持服务，而不是泛泛地提高对自杀的意识。

[29] 参见改变导向运动：https://www.changedirection.org/a-week-to-change-direction/, accessed 28 January 2021.

能力建设

是什么？

预防自杀的能力建设是针对任何实施“LIVE LIFE”支柱或干预措施的人开展的（见表5）。这意味着要进行培训，以提高卫生部门内外的人员的知识和技能。

表 5. “LIVE LIFE”干预和支柱的能力建设的例子

“LIVE LIFE”干预和支柱	能力建设的例子
情况分析	被确定从事这项任务的人(书面材料核查、访谈、定量和定性分析的解释)
多部门合作	利益攸关方（建立合作伙伴关系、领导力）
提高意识和宣传	入选从事这些任务的人员（具有沟通技巧）
财政支持	入选人员（书写提案或财政预算）
监测、监控、评估	数据收集者，数据管理人员，医疗-法律工作人员，验尸官。以增加和优化在低收入和中等收入国家进行研究的能力建设(Chibanda 等，2020)
限制自杀的手段	农药登记员和监管人员；枪支控制领域的立法者、法官、建筑师
与媒体互动，进行负责任的报道	媒体专业人士(如记者、电影制作人、那些在舞台和荧幕上工作的人)；媒体专业的学生
培养青少年的社会情绪技能	卫生工作者、教育提供者或促进者（在学校提供社会情感技能方案）
早期识别、评估、管理和随访	卫生工作者（同时也负责急性农药中毒的临床处置）；社区守门人。

为什么？

能力建设很重要，可以促使人们能够获得、提高和保留胜任工作所需的技能和知识。卫生服务往往是为陷入痛苦的人群提供处置和后续照护的切入点。全民健康保障意味着所有人都可以在任何时候和地方获得他们需要的卫生服务，且不带来经济负担[30]。鉴于许多

[30] 全民健康保障. 日内瓦：世界卫生组织 (https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1, accessed 17 February 2021

人无法获得足够的医疗保健服务（世界卫生组织，2018b），当地守门人的能力建设就显得很重要，他们对社区的了解和接触使他们能够识别高危人群并动员支持资源。

专栏 20. 马来西亚：扩大多部门守门人培训

在过去十年中，政府领导、公私地方和国际合作伙伴以及非政府组织和患者倡导组织的志愿者为马来西亚区域和国家各级一线卫生工作者、教育工作者和普通公众预防自杀的守门人培训做出了贡献。在短期内提高自杀预防意识的循证基础正在逐渐扩大(Siauetal 等，2018)。未来的工作需要建立和评估可持续的守门人培训模式，以促进社区特定人群的长期能力建设。

在哪里？

能力建设可以在国家层面进行协调（例如国家卫生、教育、警察队伍的培训），或在社区内进行（例如由地方机构协调并针对特定社区利益攸关方的培训）。培训可以面对面或数字化方式进行，例如，泛美卫生组织(PAHO)[31, 32]的虚拟校园中的自杀预防电子学习课程，或世界卫生组织的 e-mhGAP[33]系统中针对非专业卫生工作者的自伤/自杀评估和管理课程。

什么时候？

这项工作应该在整个“LIVE LIFE”的实施过程中持续进行。在提供能力建设上可能有战略上的时机，例如包括在服务前进行预防自杀的培训或在其就业期间定期持续进行培训。当出现问题时，例如特定职业部门（如建筑）的自杀率高，或者司法部门的耻感，也可以启动能力建设。

在开始行动之前，必须建立一个持续的自杀风险管理和随访的照护途径（见**早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人**）。能力建设应该是可持续的，而不是进行一

[31] Preventing self-harm/suicide: empowering primary health care providers. Washington (DC): Pan American Health Organization (https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers, accessed 28 January 2021).
[32] Engaging communities in preventing suicide. Washington (DC): Pan American Health Organization (https://www.campusvirtualsp.org/en/course/virtualcourse-engaging-communities-preventing-suicide-2020?language=es, accessed 28 January 2021).
[33] 参见：mhGAP-IG 2.0 App (e-mhGAP) (https://apps.apple.com/gb/app/mhgap-ig-2-0-app-e-mhgap/id1291414206, accessed 28 January 2021.

次性培训，那样的话培训效果可能会下降。促进可持续性的模式可用于培训师资，对卫生工作者提供督导，或规划在社区内定期开展再培训。

专栏21. 加纳：法官的能力建设

在加纳，如果媒体大肆强调法院在惩罚自杀未遂者时，就需要开始对法官进行培训了。此外，自杀与暴力研究中心组织了一场利益攸关方的会议，讨论是否有必要提高司法机构人员及相关安全服务机构人员对于自杀的意识唤醒和知识储备。为了鼓励司法机构参与，自杀与暴力研究中心与加纳精神卫生局合作制定了培训计划。个人交情促进了与司法服务部门的接触及合作，并使其加入到预计的商讨之中。培训的后勤也是协调安排的。培训内容包括自杀相关教育、警示信号、自杀污名化，以及自杀的无罪化。

谁来做？

能力建设的利益攸关方应从以下各方面加以考虑：1）开发和（或）执行能力建设培训的人员；2）培训对象。

例如，针对早期识别、评价、管理及随访工作的能力建设可以针对：

- 卫生工作者，包括精神卫生工作者及非精神卫生专业人员（如急诊医护人员、普通内科医生、护士、社区卫生工作者和社会工作者）；
- 应急服务人员（如警察、消防员、急救车或危机热线人员）；
- 与下述人员接触的工作人员：
  - 青少年（如教师、青年工作者）；
  - 老年人（如养老院护理人员、养老服务人员）；
  - 司法系统（如监狱狱警、法官）；
  - 社会福利救济受助者
  - 其他工作者（如接触高自杀率人群的职业群体）；
- 其他社区守门人（有可能与高危人群接触，或对社区有一定影响的人（行业及利益攸关方清单见附录1），其中独特的例子包括：
  - 有相当大社区影响力的加纳部落首领们；

» 在跳桥（河）点附近能识别出高危个体的英国公共交通工作者[34]；

» 有可能路过跳桥（河）点的爱尔兰出租车司机；

» 通常首先接触到患者的苏格兰卫生管理人员；

» 有机会与顾客谈话——尤其是男性顾客——的英国理发师；

» 有机会接触自杀高危人群的美国酒保[35]；

» 有机会接触有财政问题个体的荷兰财政人员及收债员。

怎么做？

1. 召集一个工作组（见引言专栏 1）

• 建立工作组（参见上面的“谁来做？”部分，以及附录 1 的行业及利益攸关方清单）。能力建设可能会涉及卫生部门、地方政府和社区利益攸关方之间的合作。

• 决定能力建设的目标以及需求。要考虑到在资源有限的情况下，自杀干预培训在哪里可以发挥最大效果。与利益攸关方合作确定能力建设的需求。形势分析可以揭示能力与培训需求之间的差异。

• 确定谁来制定和提供培训。他们应是具备自杀干预专业知识及熟练的培训技巧的人。

• 确定如何开展培训。培训可以是面对面或者虚拟培训，也可以通过数字化方式进行，如视频会议。

• 确保培训计划的连贯性和持续性。对于卫生工作者，持续性督导尤其重要。对于可能并不需要持续临床督导的利益攸关方，需要计划再培训和进修课程。考虑是否可以使用培训讲师的模式。

• 考虑将自杀预防能力建设纳入专业教育课程体系。

2. 制定、选择及改编培训包

• 对于非专科卫生工作者和社区卫生工作者，可以使用世界卫生组织的 mhGAP 干预指南中的自伤/自杀模块及相关培训资料[36]。

---

[34] Suicide prevention on the railway. London: NetworkRail (https://www.networkrail.co.uk/ communities/safety-in-the-community/suicide-prevention-on-therailway/, accessed 28 January 2021).

[35] Bartenders as gatekeepers. Ventura County (CA): NotAlone (https://www.notalonevc.org/bartenders-as-gatekeepers/, accessed 28 January 2021).

[36] mhGAP 培训手册. 日内瓦：世界卫生组织 (https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/, accessed 28 January 2021).

• 对于社区守门人，培训应是循证的，且需根据守门人需求做出调整。应将提高意识和去污名化纳入所有自杀预防能力建设。培训应该确保守门人知晓一旦出现危机应当如何处理（如：转介）。

• 培训应该为受训者提供实践所学技能的机会（如：角色扮演）。培训之后应建立持续性的督导和再培训制度，从而促进继续学习并提供机会讨论发现的问题。

• 在新背景下进行培训时，内容需要做出文化适应性调整。制定培训者可以提出建议，如何在不影响效率的情况下做出最佳调整。

3. 全员培训并提供持续的督导或再培训计划

• 督导必须作为培训的重要一环，并确保不断更新，尤其是对于健康工作者而言。

• 督导会议应该定期举行，以加强知识到实践的转化，并使受训者有机会可以解决其所面临的问题。

• 为守门人或卫生部门以外的其他人员提供进修课程。

4. 培训的评估

• 事先规划培训课程的监测和评估方案（见：**监控与评估**）。

• 在能力建设培训方面，评估考核受训者的能力——如，应用所学知识与技能的能力。对于非专业的社会心理干预者，可以使用常见治疗要素加强评估（ENACT）工具。在世界卫生组织 EQUIP（保证心理支持的质量）平台，已有数字版（多种语言）ENACT 可供使用[37]。

• 评估受训者和培训师的信心和定性体验。仅仅上报受训人数是不够的，因为这无法证明受训者是否习得了知识技能，或在行为上做出改变。

• 评估培训对于受训者日常工作的影响，评估指标可包括接触高危人群数量，以及转介数量。

• 监测已受训并满足能力要求的卫生工作者的占比和分布情况，旨在增加培训覆盖率。

专栏 22. 圭亚那：加强卫生人力资源以预防自杀

作为世界上自杀率最高的国家之一，圭亚那政府将自杀预防列为优先级任务。在泛美卫生组织/世界卫生组织的技术支持下，圭亚那于 2014 年制定并发布了《国家精神卫生行动计划 2015-2020》和《国家自杀预防计划 2015-2020》。2016 年 5 月，公共卫生部成立了

[37] EQUIP: Ensuring Quality In Psychological Support. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/emergencies/equip/en/, accessed 28 January 2020).

精神卫生部门，领导这两项计划的实施，并组织提供精神卫生服务。计划的 4 个战略领域之一是为了讨论卫生系统如何应对自杀问题。

世界卫生组织为中低收入国家开展的 mhGAP 旨在提升对精神、神经和物质滥用障碍人群的服务。mhGAP 关于自伤自杀的模块旨在培训普通卫生工作者——如基层医疗人员——识别及处置自杀风险，并提供后续照护。2015 年，泛美卫生组织/世界卫生组织的精神卫生部门基于世界卫生组织的 mhGAP 干预指南，利用泛美卫生组织的公共卫生虚拟校园平台，实现了“精神卫生纳入基础医疗”的线上课程。圭亚那已有 7 名内科医生完成了第一个线上课程。一名 mhGAP 受训者报告称“除了通过药物治疗外，还可以运用心理教育更好地处置抑郁症”。这其中也包括识别并理解她的病人们所承受的压力，探索他们的社会支持系统。自那之后，300 多名医护人员接受培训，以便评估、处置并随访常见精神问题及自伤自杀行为。其中 100 多位是基层医生。另外，有 70 人接受了物质滥用培训，因为在圭亚那，酒精和物质滥用是自杀的主要危险因素。此外，教师也会接受培训，以识别儿童青少年的精神健康问题并进行恰当的转介。圭亚那预计接下来的守门人培训包括由非医护人员参与自杀预防项目。

专栏 23. 澳大利亚：预防职场自杀的能力建设

2007 年澳大利亚昆士兰州开展了建筑业 MATES（指导辅导教育计划，Mentoring and Tutoring Education Scheme）。该项目由建筑业员工失业信托基金(BERT，一项由建筑业雇主协会和雇员工会共同经营的员工权益基金)提供启动资金。行业自杀预防计划的创立，是基于布里斯班的世界卫生组织合作中心——即澳大利亚自杀研究和预防研究所——的一份报告。该报告显示，昆士兰建筑行业工人的自杀率明显较高（Heller，Hawgood & De Leo，2007）。

MATES 作为一个独立的行业慈善机构而创立，旨在降低建筑业工人的自杀率。MATES 是一项多模式计划（Gullestrup，Lequertier & Martin，2011），基于以下四项原则：

- 提高工人(预防自杀)意识；
- 建立灵活的工作场所；
- 对工人提供帮助和支持；
- 与研究人员合作，向行业提供最优方法。

MATES 以持续改进的社区发展模式为基础，不提供临床服务，只在恰当的时间为工人提供恰当的资源。MATES 与能力建设相关的现场方案基本组成部分包括：

• 全员意识培训（GAT）——旨在鼓励工人参与自杀干预的一小时培训项目，面向所有现场的工人。工人们将会得到一张白色的安全帽贴纸。

• 联结者——四小时培训项目，培训工人如何联系同事以获得支持。该项目面向现场的志愿者。联系人通过绿色的安全帽贴纸辨认。

• 实用自杀干预技能培训（ASIST）工作者——16 小时培训项目，对工人进行同事有自杀风险时如何干预的现场培训。核心工人将被培训为 ASIST 人员，通过蓝色安全帽贴纸辨认。

• 现场认证——符合最低培训要求的工作场所即可获得现场认证。

另外，基本的组成部分还包括：1）在参加活动场所发放宣传材料（如，世界自杀预防日）；2）支持志愿者网络的驻场人员；3）向工地管理人员通报精神卫生与自杀风险情况的驻场志愿者；4）个案管理；5）7*24 小时的援助热线；6）国家政策倡导，如《澳大利亚建筑建造业改善心理健康和预防自杀蓝图》，这是澳大利亚所有主要建筑工会及雇主协会认可的一项改善精神健康的框架。

MATES 已涉及澳大利亚超过 220000 个工人，在澳大利亚 1000 多个工作现场中拥有超过 18000 个联系人和 2500 个 ASIST 人员。该项目近 30%的资金来自于政府，其余 70%由工业产业行业提供，对建造行业的雇主和工人均免费开放。该项目提升了帮助及求助的技能，减少耻辱感，在建造行业有很高的社会效度。一项卫生经济学评估表明，对于政府的投资而言，每澳元的投资回报率为 4.60 澳元（Doran 等，2016）。

实施过程的提示

表6 能力建设的实施建议

问题	建议
资金	• 使用现有的循证且免费开放的培训包，如世界卫生组织的 mhGAP 项目（WHO, 2019b）。 • 向决策者强调在资源有限的情况下进行能力建设是有益的，因为可以提高现有员工的能力。

	• 将自杀干预纳入其他现有培训项目（如，性别相关暴力的个案管理，或对健康工作者的岗前和在职培训）。
有限的人力资源和/或广大的地域范围	• 使用培训讲师模式，增加可供培训的人力资源。 • 可以战略性地选择潜在的培训师，例如那些在高风险地理范围内工作的人，或那些有能力为乡村或偏远地区提供能力建设的人员。
健康工作者没做好准备，或是没有能力识别并处置自杀行为。另外，健康工作者所提供的医疗护理也可能并不充足，且质量时好时坏。	• 对专业和非专业的健康工作者进行关于自杀行为和精神、神经、物质使用障碍的评估、管理及随访培训，并确保这些工作者达到能力要求。 • 让健康工作者参与到培训当中，使培训更适应当地情况，可提高培训的积极性和有效性。 • 了解干扰自杀行为处置的特定背景因素，从而改善培训以便工作人员能够准备好应对此类挑战。
自杀的耻辱感或法律地位可能会使受训者不愿参加培训	• 能力建设应伴以提高认识（见**提高意识和宣传**）。当计划培训项目时，重要的是给社区赋能并让其参与关于自杀预防的讨论。
社区守门人的培训内容并不总是与守门人的专业水平和准备改变程度相匹配。	• 确保培训适合受训人，延长培训的介绍部分以加强对自杀及预防的认识。 • 确保培训符合社会文化背景。 • 引入交互活动，以做好准备改变或扭转对于自杀的信念。 • 引入实践练习，如角色扮演，以确保受训者有信心应对不同状况。 • 培训之后要确保受训者可以得到足够的督导支持。

财政支持

是什么？

资金可以使“LIVE LIFE”支柱和干预措施通过资源分配转为实际行动。

资金可以是来自各种公共或私人资源，如政府资助或是来自个人、基金会、社区组织或企业的慈善捐助。

为什么？

遗憾的是，专用于自杀预防的资金很少。贫困的经济环境、没有将自杀作为一个严重的公共卫生问题予以优先重视、对自杀的可预防性认识不足等因素，导致人们相信其他领域的资金对社会来说更重要（参见**提高意识和宣传**）。我们不应为此感到沮丧，而是应当采取聚焦于问题的方法，根据资金的实际情况制订自杀预防行动。这可能意味着可以采用综合方法（联合心理健康或其他行业）来取得多行业资助，并增加获得资助的可能性。这可能还意味着将工作重点集中在最大效益的预防措施上，例如国家严禁使用剧毒性杀虫剂（Lee 等，2021）。此外，财政支持的概念还应聚焦于制定和实施政策、战略及计划，而不是仅仅关注开展服务。这一点至关重要，因为“LIVE LIFE”包括有助于国家政策和监管的基本支柱和干预措施（如手段限制），以及开展服务（如早期识别、评估、管理和随访）。

在哪里？

开展自杀预防的资金可由以下方式提供：

- 地域层面：国家资金（如全国性活动）或地方资金（如在特定地区提供精神卫生服务）；
- 利益攸关方层面：以特定高危人群、特定行业或服务人员为目标的募资（如学校、农业、社区守门人）；
- 系统层面：以构建整个行业知识、能力和基础架构的大型活动为目标的募资（如研究、技术和能力建设）；

赞助者途径也可能综合了以上所有层面，如资助校园自杀预防的国家级研究。最终，“LIVE LIFE”实施者应了解各种可得资金的来源，并向资助者进行宣传，使实施者和资助者的共同价值观保持一致。

什么时候？

应在自杀预防支柱和干预措施实施阶段之前就明确资金需求和预算。理想情况下，实施者首先建立高级战略计划（明确行动的目标及优先顺序），随后是详细的实施计划（明确要开展的干预措施、成本及资金获得的过程），资金的筹集或分配，然后是实施。缺少明确的计划可能会使人认为该工作缺乏战略性，最终导致无论从政府还是其他渠道获取资金的成功率都很低。

同时，筹款也是一项持续性的活动，许多资助者都有固定的资助周期——一段供他们挑选受赠者及提支付资金的时间。对于那些会将收益的一部分捐给社会活动的企业机构而言，财政年度结束时通常是他们考虑资助哪些项目的时候。对于基金会，资助周期可能不固定，应通过他们的网站来明确。同样地，每个政府也都有他们各自的预算周期。筹集资金不应是一次性的或是静态的努力。一旦获得启动资金，实施者就可以利用这一势头从更多资助者那里获取更多资金。没有获取资金的单一方法——所有资助者都有他们各自的流程、结构和指导方针，必须单独探寻和理解。

谁来做？

“LIVE LIFE”支柱和干预措施的资金可能来自于各种公共和私人捐赠者。国家政府以及州政府或地方政府，通常会将预算的一部分分配给精神卫生项目，自杀干预也可能是其中一部分。基金会通常更愿意资助创新项目，愿意提供灵活且长期的资金。许多专注于资助自杀预防的家庭基金会或个人慈善家是由其个人经历驱使。初始的私人基金可以被用于证明创新性预防措施的有效性，随后可以利用此资源让政府采纳该措施并扩大影响力。

怎么做？

1. 明确预算，明确资金需求

- 国家指导委员会或同等机构将作为责任机构（见引言专栏 1）。
- 制订一项工作计划或实施计划，重点强调预防措施的实施细节、项目时间线和关键节点、人力资源和开展工作所需资金（见附录 3）。
- 确定已有资金来源是否满足需求，如不满足，还需筹集多少资金以及需要多长时间。

在明确预算时，用清晰实际的费用数字明确地展示出人力费用（工资）和项目费用（差旅、设备等）。另外，不仅要列出项目直接费用，要列出相关的间接费用（水电费、房租等）。

2. 研究资助者的情况

• 政府部门或当地和国际资助者支持的自杀预防研究。了解支持相关工作的资助者（如精神卫生护理、青少年、农药相关项目）；这其中很多资助者可能并不会明确地表示自己是自杀预防工作的支持者，但他们可能会有兴趣资助此类项目。

• 联系可以帮你介绍自杀预防或相关工作资助人情况的慈善顾问或中介机构。

• 了解政府基金如何运作。政府关于自杀预防的预算是取决于国家还是地方政府？由哪个部门负责？

• 与非营利性机构或其他实施者探讨，了解他们如何成功获得的资助。

• 根据研究结果，建立一个潜在资助者的数据库。

3. 明确政府资助或合适的资助者

• 确认政府部门和预算负责人，或是根据干预的性质，确定最适合的资助人类型。

• 找到与你的构想、目标和优先级最一致的资助者。例如，如果你在为青少年自杀预防寻求资助，就寻找那些优先考虑青少年福利、有资助类似项目历史的资助人，或是相关部门或政府教育部门的预算负责人。

• 通过网站和交谈核实资助者（的目标）是否一致。确保要识别出潜在的利益冲突。

• 了解资助人准备提供的大概金额。这一点可以通过研究资助人过往资助史或与资助人初步对话判断。

• 确定资助人，应优先考虑那些可能已经同你建立了牢固关系或专业联系的资助人。

• 通过多元化的努力，接触更多不同类型的资助人。

4. 制定方案

• 根据资助人的要求，在提交方案时可能要使用他们提供的模板，或是灵活创建自己的申请版式。

• 方案应包含以下内容：

1）个人及组织或政府部门的信息；

2）“为什么”（即，你所阐述的问题背景以及问题重要性的原因）；

3）“是什么”（即，方案目标、干预措施及相关活动）；

4）“怎么做”（即，项目预算，时间线和关键节点）；

5）“谁来做”（即，领导并执行工作的团队及合伙人）；

6）有明确且可测的短期、中期和长期结果指标的干预预期结果；

7）资金请求（即，资金数额，用于哪些方面及持续时间）。

• 根据资助人的优先级，尽可能地调整方案的语言和定位。

• 如果已经获得了一些资金，与资助人透明地分享这些信息。资助人在投资项目和干预措施时，通常注重是否拥有可以带来其他资源的价值。

• 最好将方案发送给负责决策的代表，而不是发到通用的邮件地址。

5. 提交给资助人

• 确保在与资助人的会议上，有可以有效且详细讨论实施工作的团队成员出席。

• 规划好关键信息，使你的报告简洁、具体、令人振奋，并配有图像和数据。决策人通常时间有限，并且有一些优先项目极具竞争力，所以一个精心准备的、引人入胜且简洁的报告非常重要。

• 不要仅仅专注于项目或干预措施的细节，还要强调为什么你认为支持这项工作对于资助人来说是一个重要的、目标一致的机会。还要强调你在自杀预防方面的成功经验。

• 保持报告的对话性，听取资助人的想法，并在报告过程中与他们建立联系。

6. 不论资助决定如何，都要维持与资助人的关系

• 即使成功获得了资金，也不要认为辛苦的工作结束了。事实上，这才刚刚开始。为了最大限度地提升资助人在将来可能会提供更多资金的机会，并且提高在其他潜在资助人中的信誉，通过定期、透明、周到的沟通，逐步提升资助人的信任和信心。这可以通过会议、电话、报告或进度更新来实现，以评估实施情况，显示资金带来的影响。

• 如果获取资金失败，与资助人讨论方案未来可以改进的地方。通过定期更新工作内容与资助人保持联系，以继续寻求新的机会。这次募资失败，并不意味着将来也不会得到资助。

专栏 24. 清单：向国家和地方预算申请资金

• 确定负责决策的关键决策人

• 确定负责执行方针决策的官员或系统。

• 预约一个合适的时间和地点。

• 沟通时保持聚焦和准确，用清晰、简洁、背景详细的与预防直接相关的信息进行传达（不要只讨论自杀问题）。强调与其他问题（例如，道路伤害）相比，自杀的负担可能要大得多，这有助于提醒人们关注到自杀预防需要更多的资金需求。

- 决策人通常时间有限，并且有一些有竞争的优先级项目。要引起他们的注意，不要给他们一份全是数据的长篇提案。提交一份强调具体结果的易懂、简短的说明(最多两页)。
- 证明你在自杀干预方面的经验和专业性。
- 坚持不懈，并保持定期联系。
- 明确所需成本，并强调所拯救的生命和代价。
- 信息应该包含科学数据和有亲身经历的人的故事。
- 信息中应强调预防自杀的跨部门相关性，并强调它与身心健康、教育、经济和其他领域之间的联系。

专栏 25. 加纳：慈善家

在加纳，自杀仍是一种犯罪，是耻辱的。因此，加纳自杀与暴力研究中心（CSVR）很难从官方渠道获取资金来支持提供自杀预防教育活动。CSVR 一名核心员工一直有较高的媒体曝光率，以此加强预防自杀的意识唤醒及宣传活动，并留意到一个慈善机构一直在跟进他的工作。CSVR 秉持着坚持和决心，多次向该机构提交预算，希望得到资助。尽管他们并非总能成功，但他们的坚持得到了回报，慈善机构看到了 CSVR 关于能力建设工作的重要性。最关键的是，为了维持关系，CSVR 一直持续向慈善机构提供关于他们的资金对于国家自杀预防能力建设的影响的反馈。

专栏 26. 澳大利亚：国家自杀预防试验

国家自杀预防试验是澳大利亚政府卫生部的一项动议。从 2016-2017 到 2020-2021，这五年中已为澳大利亚 12 个确定的国家自杀预防试验点提供了共 6 千万澳元的资金。这笔资金通过作为合作组织的相关初级卫生网络（PHNs）提供，每个试点总额 5 百万澳元。

PHNs 成立于 2015 年 7 月，旨在提高医疗服务的效率和效果，尤其是对于有不良健康状况风险的患者，以及改善护理的协作性，确保患者在恰当的时间地点得到恰当的治疗。区域规划和试运行机构选择 PHNs 来领导试验活动，以确保可以响应当地需求。

目的

澳大利亚政府资助国家自杀预防试验以收集澳大利亚当地区域预防自杀的证据，并提高对地方层级和高危人群预防自杀的最有效策略的理解。更具体地说，它的目标是提供如

何在澳大利亚实施预防自杀的最佳系统方法的循证依据，并明确高危人群自杀预防的新知识。

国家自杀预防试验的目的是支持试验点的灵活性。每个试点都要求至少在当地选择一个以上重点人群，试验一个循证为基础的系统方法，并进行评估。

重点人群

12 个试点中有 7 个是集中将原住民和托雷斯海峡岛民作为目标人口。6 个专注于男性，2 个针对年轻人，2 个针对 LGBTI（男女同性恋、双性恋、跨性别和换性别者）群体，前 ADF 成员和老年人各 1 个。有些试点专注于所选重点人群的子目标人群（例如渔民、农民和旷工、年轻 LGBTI 群体、年轻的原住民和托雷斯海峡岛民）。

系统方法

自杀预防的系统方法可以针对系统中不同元素实施一系列干预策略措施，以减少自杀和自杀行为。试点利用一系列证据和框架来决定预防自杀的方式。12 个试点中，有 8 个选择实施 LifeSpan 模式，2 个试点选择了欧洲抗抑郁联盟（EAAD）模式。为了适应当地试点的需求，必要时也做出了一部分调整。2 个专注于原住民和托雷斯海峡岛民的试点采用了以原住民和托雷斯海峡岛民自杀预防评估计划（ATSISPEP）中规定的原则为指导的方式。原住民和托雷斯海峡岛民自杀预防评估计划（ATSISPEP）概述了一系列以社会和情绪健康为基础的自杀预防原则或成功因素。

典型活动

试点实施了大范围的个人服务和社区活动。其中包括：

- 为自杀未遂或处于自杀危机中的人提供后续照护服务；
- 通过媒体、社交媒体活动以及社区活动，提高对自杀和心理健康的认识；
- 原住民和托雷斯海峡岛民的文化促进活动；
- 对社区成员进行能力建设培训，为全科医生和其他服务人员提供自杀预防及人文安全支持相关的培训资源；
- 年轻人的校园活动，包括针对年轻原住民和托雷斯海峡岛民以及年轻 LGBTI 群体的特定方案；
- 对当地社区活动的小额补助；
- 参与一些定向研讨会、集训营和活动项目；
- 制定自伤自杀预防和事后响应方案；
- 同辈工作和辅导计划；

• 支持修订性研究（例如，对原住民和托雷斯海峡岛民的结果测量、对年轻 LGBTI 群体的同辈支持、以及有关退伍军人创伤性脑损伤的研究）。

后续行动

对国家自杀预防试点的资助于 2021 年 6 月 30 日终止。现已完成对国家自杀预防试验的评估，澳大利亚政府正在审议之中。澳大利亚政府还资助了一个项目，用以分析 NSPT 评估的成果以及全国范围其他自杀预防试点的评估成果——即 LifeSpan 试验和维多利亚地方型自杀预防试点。这些项目的成果将共同助力在澳大利亚建立起以系统为基础的自杀预防方法的循证基础。

实施过程的提示

表7 实现融资的建议

问题	建议
资源有限	• 尝试找到可以与政府已有的机构合作的方法，在缺少资金设立新的机构或部门来开展工作的情况下，这一点尤为重要。
资助人对于自杀的可预防性及自杀预防的优先级认识不足。	• 开展提高意识和宣传活动，展示表明问题重要性的数据，并说明如果投资得当，自杀是可以预防的。 • 分享故事证明资金充足的自杀预防干预措施的影响，其中涉及到专业人士、有相关经历的人和倡导者，以使你的信息更有说服力。 • 从更多资助人那里争取更多小额资金，转向集资或合资模式。 • 考虑从相关项目中调用资金（例如，心理健康、教育等）。

监测

是什么？

从已建成的自杀自伤监测系统获取最新数据能够为“LIVE LIFE”支柱和干预提供至关重要的信息。关于自杀人数及自伤案例的数据至少应按性别、年龄和自杀方式分类(WHO, 2011; WHO, 2016a)。

可以通过许多不同渠道获取这些数据，例如：

• 民事登记和人口统计（CRVS）系统[38]：许多国家都有 CRVS 系统，正式记录死亡（出生）情况和特征。虽然其中关于死亡经过的细节较少，但可以提供连续的可比数据。

• 卫生和警方记录：包括收集医院和太平间的记录，和/或警察、验尸官和司法记录中的数据。在某些情况下，这些需要人工完成（例如，查看医疗笔记）。虽然这种方法需要时间和财力，但它能提供准确的数据。在可以使用定期收集的数据的地方，这个系统相对来说比较便宜，并能提供连续且详细的资料。但是医院的数据只能包含发生在医院的自伤和死亡案例，而且可能无法确定自杀方式（例如，所使用的毒药类型）。自伤的数据也可以从门诊、基层卫生服务和社区服务处获取。

• 口头尸检[39]：这些数据可以通过社区的报告系统收集，医护人员凭借该系统向家人朋友询问有关死亡前后经过和有关问题。这对于人口登记系统或是正规医疗服务资源不足的地方这尤其有用；也可以用于验证从其他渠道收集到的数据，或提供更多详细信息。社区监测包括一个供社区成员报告自杀行为的系统，该系统也可以被用于收集特定地域的信息或对特定干预措施效果的评价。然而，该系统需要充分标准化，同时也有存在一定偏差的风险。

• 基于人群的调查：可以进行有全国代表性的针对自杀行为调查，也可以在更大的全国或国际调查中纳入这些内容[40]。调查(包括针对特定区域或社区的调查)的时候也会捕捉到在医院以外发生的自杀未遂和自伤行为（例如，因为未寻求医疗救助），这些案例可能因无反应偏差及因害怕被污名化的影响而不愿报告，也无法提供连续的数据。

---

[38] 参见: Civil registration and vital statistics. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/data/data-collection-tools/civil-registration-and-vitalstatistics-(crvs), accessed 28 January 2021).

[39] Verbal autopsy standards: ascertaining and attributing causes of death. Geneva; World Health Organization. (https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/ verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool, accessed 28 January 2021).

[40] STEPwise approach to surveillance (STEPS) mental health/suicide module. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/riskfactor /STEPS_Mental_Health_Suicide_module.pdf, accessed 28 January 2021).

综合监测可将从一系列来源收集的数据结合起来。在资源缺乏的情况下，最可行的做法通常是从现有常规数据收集的领域开始(如 CRVS、医院记录)。事实上，在印度乡村，已经开发了一套自杀与自杀未遂的综合监测系统，该系统利用了从社区监测系统、医院和警方记录收集来的数据（Vijayakumar 等，2020）。

监管如何实施还将取决于国家自杀预防当前所处阶段：

表 8. 根据国家情况开展监测

问题	建议
在目前没有或几乎没有监测的国家	在开始阶段通过在有代表性地点或试点进行数据收集(例如，一个区域或地区)，优先处理核心信息(例如，自杀死亡率数据、年龄、性别、自杀方式)，进行基本分析(例如，自杀率)，然后努力扩大至全国范围并建立CRVS系统，这都是有益处。
已有部分监测的国家	监测系统可以扩大至国家级别（如全国医院自伤登记[41,42]）来监测自伤或自杀（通过CRVS），还可以包括更详细的信息和更宏观的分析（例如，危险因素变化、重复性自伤信息），优先级方面应以监控自杀死亡率为优先，其次再纳入自伤监测。对于设立中毒救治中心的国家，鼓励各个中心向一个中央数据收集点分享蓄意服毒案例的数据，这或许可以提供有用信息：1）特定自杀方式；2）掌握变动趋势以及新自杀方式信息，有助于修订限制自杀手段这个预防自杀措施。可以用情况分析评估目前的监测质量和有待改善之处［参见情况分析］。
已建立综合监测系统和CRVS的国家	为了提高质量，监控监测系统的某些关键属性如数据质量、覆盖范围、即时性和成本非常重要。在有稳固的监测基础条件的情况下，可以引入实时监测，在记录到自杀或自伤案例后立即对数据进行分析。

[41] National Self-harm Registry Ireland. Dublin: National Suicide Research Foundation (https://www.nsrf.ie / our-research/our-systems/national-self-harm-registryireland/, accessed 28 January 2021).

[42] Multi-Centre Study of Self-harm in England. Oxford: University of Oxford (https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/ahoj, accessed 28 January 2021).

为什么？

监测系统有助于为“LIVE LIFE”的执行提供信息。例如通过突出自杀行为趋势、高危亚人群、病例聚集或出现需要立即采取行动的新自杀方式或传播方式 (Thomas, Chang & Gunnell, 2011) 。自杀和自伤数据还为服务供应、资源部署和自杀行为管理准则提供信息，例如确保在某些地点培训医疗小组成员如何处置某些自杀手段（如农药）的后果，或在自杀事件多发地区雇用专业护士。数据用于监测干预进展情况(如降低自杀率的指标)，且有助于评价和研究正在进行的预防策略和干预措施，例如英国牛津的医院救治的自伤病例的长期队列研究[43]。

在哪里？

理想情况下，各国应致力于在全国范围内收集数据，以全面了解国民自杀行为。但实际上，更应该优先从几个代表性地点获得高质量数据，而不是覆盖全国但质量低的数据。监测可以从建立具有全国人口代表性的较小数据库开始(例如，在少数几家重点医院)，之后利用所吸取的经验教训扩大规模。这在较大国家，或是数据可在联邦或地区级进行协作的地方可能特别有用。数据收集可以在专门的自伤登记处进行，也可以是更大的全国死亡或伤害数据系统的一部分。在全国性收集数据的点，重要的是力求在收集什么数据和如何报告数据方面保持区域与地方间的一致。

什么时候？

在“LIVE LIFE”实施之前或开始实施时应进行持续监测，且将其作为优先项，因为这可以让各个国家评估所实施干预措施的有效性。数据需要长期持续收集，以便提供及时的、最新的（或是尽可能实时的）自杀行为信息，并能够识别不断变化的自杀模式和有重复自伤风险的人。然而，在资源非常有限的情况下，可以从几个监测某个地区/人群在有限时间内自杀行为的研究开始，然后不断扩大收集数据的范围。

谁来做？

[43] The Oxford Monitoring System for Self-Harm. Oxford: University of Oxford (https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/research-projects-1/the-oxfordmonitoring-system-for-self-harm, accessed 28 January 2021).

不论是全国的还是地区的监测系统，卫生部代表都应参与进来。其他相关部门人员也如此，如国家统计局或是负责民事登记和人口统计的部门，可以为监测的长期稳定性提供指导和资源。利益攸关方应包括那些最适合收集和处理目标数据的机构或个人（例如医护人员、太平间工作人员、警察、当地卫生工作者），以及那些有能力部署实施监测系统的人（例如卫生信息系统专家和公共卫生学者，包括流行病学家、统计学家、数据系统管理员，数据采集者）邀请那些可能已经在研究目标人群相关队列数据的学者加入也会有所帮助。

专栏 27. 斯里兰卡：监测

南亚临床毒理学研究合作组织(SACTRC)于 2002 年建立了一个长期前瞻性的蓄意中毒患者群体，重点关注农药中毒。研究人员在所有中毒患者进入研究医院时均有访谈，旨在确定所用毒药、检测处置，以及记录结局。

通常是通过汇报病史确定所用的农药。在一个嵌套样本中，使用实验室中的质谱分析来验证根据病史确定农药种类的准确性（＞80%）。该队列现在超过 80000 人，其中 35000 人服用农药。研究结果展示了各种农药对于人类相对毒性的新数据（Buckley 等，2021）。该队列研究筛选出三种毒性非常强的农药(Dawson 等，2010)，并将数据提交给农药监管局和农药技术咨询委员会。2008 至 2011 年，这些农药被禁止在农业中使用，这使得斯里兰卡的自杀和用农药自杀总人数持续下降。(Knipe 等，2017)。

专栏 28. 俄罗斯联邦：自伤监测

俄罗斯联邦是欧洲地区国家中官方承认自杀是重要公共卫生问题的国家之一。为了应对这一挑战，加强精神卫生系统对自杀的监测和预防，俄罗斯的主要卫生专家们开始与世界卫生组织欧洲区域办事处和世界卫生组织驻俄罗斯联邦国家办事处合作，合作结果对其他东欧国家也是有利的。世界卫生组织的自伤监测方法已在一些英语国家落实，如爱尔兰，并在识别易感人群和促进获取所需卫生服务方面已显成效。俄罗斯联邦的试点项目旨在分析国家级的正确做法，同时对工具和方法进行微调和修改。

作为世界卫生组织成员，俄罗斯联邦在国家协作战略（CCS）下的合作符合创建预防、终身健康促进、提高全球和区域卫生领域合作能力一体的综合条件的目标。2018 年，来自俄罗斯三个区域的专家（乌拉尔联邦区、北高加索联邦区和远东联邦区）与塞尔布斯基中

心协商（由卫生部领导，被任命为俄罗斯联邦主要精神卫生机构），分享了各自的经验，并表示已准备好在示范试验区改编并使用世界卫生组织的工具和手册，以改进医院里自伤和自杀未遂的监测系统[44]。

该工具以一套世界卫生组织推荐的程序为基础，经过培训的卫生工作者可遵循这些程序，在医院和专科卫生服务机构识别自伤病例。该措施的目的是在世界卫生组织工具俄文版的基础上建立一个多中心监测系统，并开发一个在线平台，用于收集和分析自伤和自杀未遂的高质量数据。北高加索联邦区斯塔夫罗波尔边疆区的卫生专家目前正在修改这个在线软件。在任何卫生系统中，建立这样一个监测系统都是加强自杀预防的一个关键步骤。

作为此次合作的另一项成果，世界卫生组织欧洲办事处和俄罗斯卫生专家为监控和监测系统的工作人员开办了培训课程。使用这些材料将有助于培训卫生人员和数据收集员，便于将该项目推广到全国和国际范围。世界卫生组织推荐的这套工具与俄罗斯地方级的卫生服务标准相互补充，并有可能进一步扩大规模。这一项目意在成为欧洲自杀和自伤预防基本建设的有机组成部分，帮助有自杀行为风险的人更方便地获得心理健康和其他服务的机会。该项目的成功归功于所有参与者的承诺与激励、合作伙伴之间的良好协作以及承诺将预防自杀作为可持续发展议程一项重要内容。

怎么做？

1. 召集一个工作组（见引言专栏 1）

- 成立团队（见上文的“谁来做”和附录 1 的“部门和利益攸关方”）。
- 考虑成立一个指导委员会来提供持续支持；成立一个技术咨询小组为计划、实施和评价提供指导；以及一个管理团队来实施监测。
- 告知主要利益攸关方对自杀和自伤进行监测的必要性，以及需要提供持续支持来维护系统。

2. 规划监测系统

- 定义系统的总体目标、当前目标和适用范围。

例如，要说明需收集哪些信息，如何将这些信息用于自杀预防，是否已有任何收集类似信息的系统，以及该系统应当部署于何处。

---

[44] Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/208895, accessed 17 February 2021).

• 考虑分阶段实施，从试点阶段开始逐步扩大到全国层面。

• 为所需的成本和资源(例如人员配备、系统设备、培训、维护)准备一份可行的预算，分清主要和次要的筹资方式，以长期维持系统。

• 确定数据收集、管理和分析的过程。例如，要收集哪些数据，由谁收集，数据存储在何处以及如何存储。开发标准化操作程序以保持一致性。

• CRVS 系统为的目标是自杀死亡率。自伤监测应当纳入常规医疗记录。必要时，需要获得伦理委员会的批准和许可(例如医院管理层)，以从相关数据资源收集数据。采取保障措施以保密(即不报告可识别身份的数据)。

3. 准备资源

• 开发数据登记表或电子数据录入系统，利用数据编码并按事件(包括按自杀未遂)记录数据。留出人口统计学数据的空间，以识别高危群体。

• 准备数据收集的指导手册，保证数据一致性。

• 对数据收集人员进行培训，强调自杀行为定义一致的重要性，并练习编码和数据录入(尤其是已有信息可能不明确时)。

• 与提供数据的工作人员(如医疗保健管理人员)会面并简短交谈，以鼓励他们在处置有自杀行为的人时，可以进行详细的评估和记录。

4. 试行和实施系统

• 在一到两个地点试验数据登记和收集，以识别并解决问题。

• 开始在更多地方使用该系统。

• 定期(理想情况是按季度)分析数据，以发布最新的数据汇总。

5. 结果交流

• 定期撰写、出版和发布年度报告或较小的证据摘要。安排在战略期发布年度报告，例如在国家或国际预防自杀日，以提高知名度。

• 在设计数据报告时，应考虑利益攸关方的需求和监测系统的目标。思考应该生成哪种类型的报告、多久写一次报告、以及应由谁接收报告。利益攸关方可包括决策者、医疗保健服务机构、公众和媒体（虽然在媒体报道时需要谨慎；见“与负责报道自杀事件的媒体沟通”）。

• 交流关键的研究发现，包括自杀自伤率和特定趋势，并为预防自杀提供建议。

6. 审查和评估

• 创建例会日程和监督制度，确保按操作程序进行数据收集。为那些会接触到自杀相关情绪/图像信息的数据收集者提供情感支持是很重要的。

• 除了持续性监测之外，还应当定期进行详细评估，以确定系统是否实现目标；评估数据的准确性和报告的质量，并评估报告的有效性（见监控与评估）。监控可以包括质控演习，以比较各站点/收集者之间数据的一致性。

• 根据审查结果，对标准化操作程序进行必要的修改。

• 另外还建议对监测系统进行独立审查，以提高质量和效率。

• 扩大监测系统规模，涵盖额外的站点/地区，以建立全国监测系统。

• 定期审核预算及资金来源，以确保系统持续运作。

专栏29. 伊朗伊斯兰共和国：自伤和自杀登记系统

伊朗伊斯兰共和国拥有在卫生与医学教育部(MOH)管理下运行的完善的国家自伤自杀登记系统。根据系统要求，全国所有的医科大学负责其所在区及服务区内自伤自杀数据的日常收集和登记。2009 年，卫生部的精神卫生和药物滥用司正式将该系统设定为一个独立数据收集系统，以便以统一方式收集自伤自杀数据。2017 年，该系统根据《建立维护自伤自杀未遂监管系统实践手册》(世界卫生组织，2016a)进行了修改。

2009 年，来自各个大学经验丰富的精神卫生专家进行了一次全国培训会议。随后，在各医科大学精神卫生专业负责人接受培训后进行数据收集，并以软件形式编写了一个带有用户手册的案例报告问卷，以确保门户数据收集的系统性和统一性。其中也涵盖了最重要的用于设计自杀预防干预措施的流行病学相关因素。问卷内容包括被试的性别、年龄、婚姻状态、职业状态以及受教育程度等人口学特征、既往躯体和精神障碍史、自杀方式和结局（从既往相关研究中采集）。

关于自伤自杀的主要数据来源是城市的综合医院和门诊医疗设施，以及农村的卫生所和公共卫生中心的正式医疗记录。在农村地区，一些病例可能是根据当地卫生工作者的报告得来。尽管没有正式报告，但他们知悉该地区所发生的自杀事件。这些来源的数据在地区卫生中心，即各省确定的服务区医科大学的分支机构收集。各大学只能获取自己地区卫生中心的数据，而国家数据只能由负责监测数据录入的卫生部精神卫生和药物滥用司获取。根据官方报告，一些自杀病例可能并不会被转介到保健或医疗中心。对于这些病例，尸体

会被送往当地法医总部验证死因，然后整理数据正式汇报给医科大学。这些数据也会按季加入卫生部数据中。

专栏30. 美国：在白山阿帕奇部落监测

目前，美国原住民社区的自杀率是美国所有族裔中最高的，尤其是 15-24 岁的年轻人。为了应对这一公共卫生问题，白山阿帕奇部落制定了一种促进心理健康和心理韧性的创新方法。在当地部落精神卫生专家的支持下，“歌颂生命”模式将转诊、监测、预防、危机照护和病例管理整合在一起。(Cwik 等，2014；Cwik 等，2016)

监测已是美国国家自杀预防策略的一部分，但有许多挑战妨碍了报告的及时性和数据发布。在约翰·霍普金斯美国印第安人卫生中心的技术支持下，白山阿帕奇部落首先建立并应用了综合系统来克服这些局限性，为其他社区提供了榜样案例。

白山阿帕奇部落政府在 2001 年通过了一项部落决议，要求在阿帕奇堡印第安人居留地发生的任何自杀事件——包括自杀意念和自杀未遂——都应该向部落自杀监测系统报告(非自杀性自伤和滥用药物的情况后来被添加为可报告事件)。

约翰·霍普金斯美国印第安人卫生中心与白山阿帕奇部落合作修订了转诊形式，开发了一个本人随访表格，设计了一个计算机化数据收集系统，并雇用和培训了一个由当地社区精神卫生专家组成的“歌颂生命”团队。该监测系统获得了美国精神病学会、印度卫生服务以及物质滥用和精神卫生服务管理局所颁发的奖项。“歌颂生命”由其工作人员进行跟进、监控并维护。另外，“歌颂生命”的工作人员帮助分析数据，并根据社区内动态定期向白山阿帕奇部落领导人汇报。

在过去的 20 年中，社区监测系统为自杀预防的规划和评估提供了基础。尽管全国自杀率仍保持稳定或有些许上升，但当自杀监测系统和综合规划启动时，白山阿帕奇人的总体自杀死亡率有所下降。自杀未遂也减少了 53%，寻求治疗的高危个体比例几乎翻了一倍，从 39%增至 71%。

实施过程的提示

表9. 监测的实施建议

问题	建议
漏报	• 由于自杀在很多国家被污名化，许多自杀和自杀未遂并未上报或是被错误归类。提高意识和改变自杀法律地位（即非罪化）是解决污名化的关键。重要的是，监测系统应保证保密性和得到信任。 • 漏报也可能是获得医疗服务机会不足和医疗保险范围有限所致，从而也局限了自杀未遂寻求医疗支持的人数。提供全民医疗保险对于解决这一问题以及全面预防自杀都至关重要。
数据不完整不准确	• 在资源不足的情况下，可能不容易获取数据。必须利用其他信息来源(例如，死因推断/社区监测)，并执行基本的自杀死亡登记制度(例如，与社区登记死亡的人员合作，比如警察和医疗中心)。 • 很多国家对医疗数据的监测都比较差。提倡改善卫生信息系统是提高意识的一个重要部分。 • 自杀行为的登记和分类是复杂的，需要充分的培训、实践和不间断监控来帮助数据收集人员。对报告自杀事件的人员(如警察和急救人员)进行宣传以提高意识，这对于避免误报非常重要；关键是要培训这些服务机构人员详细评估和记录自杀意图的能力。 • 如果有多家机构负责收集自杀数据，那么实践操作上的不同可能会导致结果的差异。重要的是，计划中应包括来自不同机构的代表，为不同地区的数据收集和记录制订共同指导准则。 • 在可能的情况下，应制定关于数据收集的国家指导准则，以汇总来自不同行政辖区的数据。

问题（续）	建议（续）
缺少数据和信息会影响决策者的优先次序和资源分配。在实施过程中，数据收集不充分可能会导致在无效的干预措施上浪费资源。	• 建立和强化自伤自杀监测系统；监测是预防自杀的核心支柱。 • 通过精确的数据收集监控主要结局的有效性，从而能够进行后续调整以提高有效性。 • 与感兴趣的学者合作，建立可以为公共政策提供建议的监测系统。
数据敏感性	• 确保采取防护措施以保证数据的保密性(例如，使用个案识别码，而不是身份信息)。 • 在使用数据、数据的获取以及数据传递方式方面应谨慎。自杀数据可能对高危人群产生的影响也要纳入考虑。（见**与媒体互动促其负责地报道自杀**）

监控与评估

是什么？

监控与评估对于评估自杀预防是否有效至关重要。监控包括有计划地、连续或定期地对有助于评估“LIVE LIFE”实施进展的信息进行测量。之后需要评估，定期审核“LIVE LIFE”是否达到预期效果。监控和评估应该是干预措施的一部分，这些信息可以结合起来评估“LIVE LIFE”的整体有效性。

评估应该考虑以下因素：

- 有效性。干预措施是否能带来预期效果；是否实现了目标？在普遍实施干预措施之前，与专业学者合作设计和说明有关干预措施有效性的强有力的研究是有益的（Kolves 等，2021）。此类研究可能需要大规模进行，才能为决策提供明确且相关的证据。
- 实施。是否按预期提供服务，表现如何？实施过程中，哪些对其产生积极影响？障碍或挑战是什么？
- 效率（成本效益）。干预成本是否得到了足够的回报？这些成本是可持续的吗？在将来如何能维持？

所有自杀预防行动的主要目标均是降低自伤和自杀率（见**监测**）。

然而，检测出干预活动对自杀率的影响是较困难的，只能通过长期评估才能确定。

鉴于这些问题，重要的是监控和评估干预进程中的其他指标。这些指标需要与主要目标有明确且直接的联系。举例如下：

- 强制限制自杀方式可及性；
- 媒体更负责任地报道自杀；
- 更多年轻人接受情感生活技能培训；
- 更多的人获取支持和服务并加以利用；
- 提高卫生工作者对有自杀行为的人的认识、态度、实践。

进度的衡量必须事先计划，并有具体、可行、相关以及有时限的指标（见“附录 3 “LIVE LIFE”的指标”）。这一过程应该以影响目标人群自杀行为的相关因素现有证据为指导。指标可以由多种来源进行衡量（见**监测**），包括常规收集的数据（如 CRVS、服务考勤数据、人口统计、转诊来源）和为特定目收集的数据（如对利益攸关方和项目工作人员的访谈，人口调查，焦点小组，调查研究）。

为什么？

要评价“LIVE LIFE”是否达到减少自杀自伤的预期效果，监控和评估是很有必要的。监控和评估可以显示“LIVE LIFE”在该国背景下能否发挥作用，能否提供关于哪些干预措施影响最大，以及需要做出哪些修改的反馈。重要的是，除了确定需要改进的地方以外，评估还应考虑到可能对实施产生积极或消极影响的因素(例如设计问题、资金变化、社区参与、经济条件)，以便提出有用的改进建议。

评估报告可确保在这一过程中吸取的信息和教训得以分享，并为计划采取类似干预措施的其他服务或地区提供信息。向主要利益攸关方和公众通报进展情况也有助于促进问责和社区支持。这些数据可以成为寻找和获取额外资源以支持持续干预的强大工具。

在哪里？

除了监控和评估国家级数据外，地方层级的数据也应被纳入(如关于提供服务的数据、主要工作人员的反馈)。

什么时候？

要事先计划监控和评估工作并达成一致，以确保所有利益攸关方的参与。监控和评估还应包含参与实施干预措施的关键人员的投入，以及服务对象和一般人群的反馈。这就形成一个不间断的反馈回路，以便在干预过程中对其进行调整。

谁来做？

建议有专业团队专门负责监控和评估“LIVE LIFE”。其中应该包括有规划和实施监控评估技能的人员(例如卫生流行病学家、统计学家、数据收集者)。可能的情况下，与学术机构合作来支持数据收集、分析和评估也会有所帮助。

怎么做？

1. 组建专门的工作小组进行规划、监测和评估（见引言专栏 1）

- 成立团队（见前文的“谁来做”和“附录 1 部门和利益攸关方列表”）
- 其中包括具有规划并实施监测和评估技能的人员。
- 分配小组成员的角色和职责，计划例会日程。

2. 计划主要目标的测量

• 自杀预防的重点是降低自杀自伤率（见**监测**）。

3. 识别结局

• 在形势分析的基础上，确定预期结果和实施干预措施希望实现的目标。这些结果应该有助于减少自杀的主要目标（见附录 3）。

4. 确定每个结局指标

• 确定可用于评估每个结局的指标。例如，如果预期结果是负责任的媒体报道，指标便可能包括提供培训的媒体机构的数量以及自杀报道的质量。

5. 计划收集数据

• 计划如何为每个指标收集数据(例如，对媒体机构进行调查以确定哪些接受过培训，对媒体报告的随机样本进行评估)。

• 在计划干预措施时，要求有关人员定期提供包含最新数据的进度报告。

6. 数据收集

• 可能的话，持续收集数据，以便得到持续的反馈。

• 目的是定期总结数据(理想情况下是按季度)，提供监控报告，为进行中的行动提供信息。

7. 评估数据

• 定期分析数据(理想情况下每 1-2 年一次)，并利用这些数据评估干预措施是否取得了预期效果。

8. 交流研究结果，回应得到的经验教训

• 编写适合不同受众的调查结果报告；利益攸关方可能包括决策者、其他可能采取干预措施的服务机构以及公众。

• 交流重要研究结果，包括不同干预措施的有效性、实施的推动因素和障碍，以及改进的建议。

• 利用所吸取的经验教训，在必要时改进干预措施的设计和实施，或是扩大干预规模。

9. 审核并计划改进后的监控与评估

• 创建工作组例会日程，以审核进度。

• 监控和评估的目标之一是改善自杀数据质量。这些数据可用于定期监控进度，并确定数据有效性，或质量可得到改善的部分，以及可能相关的其他指标。

• 在审核的基础上，对监控和评估进行必需的调整。

专栏31. 爱尔兰：监控和评估国家自杀预防策略

2014 年，爱尔兰卫生部和国家预防自杀办公室开始制定新的预防自杀策略——联结生命（2015-2020 年；延长至 2024）[45]。该策略一开始就聚焦于结局指标，即设想在自杀自伤率方面可以取得显著降低，以便之后通过结局改善来评估该策略及其组成部分的作用。

该策略开展了广泛的研讨和互动过程，以听取一些利益攸关方的声音和意见，其中包括服务供应商、一般公众、受自杀影响的人、政府部门和国家机构。在制定策略时还进行了大规模的证据和数据回顾，以确定影响特定人群的危险和保护因素，并制定有效措施来支持这些群体。

根据这一信息制定了若干目标以及初期和中期成果，并制定相应的成果框架，以便跟进进展，并根据基线指标客观衡量该策略的影响[46]。同时制定了一个计划，即对在“联结生命”支持下开展的所有主要活动进行适当评估，并向方案执行者及合伙人分享调查结果和经验教训。除了衡量初期和中期成果指标外，该策略还计划对主要活动的实施质量进行过程性评估，以了解导致策略成功和失败的因素。

[45] Connecting for Life. Dublin: Health Service Executive (https://www.hse.ie/eng/services/list/4/ mental-health-services/connecting-for-life/, accessed 28 January 2021).

[46] Implementation progress reports. Dublin: Health Service Executive (https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/strategyimplementation/implementation-progress-reports/, accessed 28 January 2021).

实施过程的提示建议[47]

表10. 实施监控和评估的建议

问题	建议
缺少规划	•监控和评估应当是初步规划的关键部分，并应当与实施干预措施同时进行。 •在规划期间，确定干预措施的目标，将使用哪些指标来评估进度，以及如何衡量这些指标（见附录3）。
评估数据不足	•将监控和评估作为“LIVE LIFE”的一个主要目标。根据情况分析了解自杀相关数据的现状，制定计划，提高数据有效性、全面性和质量。 •作为干预项目筹资过程的一部分，定期提供进度报告。 •建立和加强对自杀自伤的监测系统（见监测）。
缺乏资金和资源	•在与主要利益攸关方讨论自杀预防时，强调有效监控与评估的重要性。 •将监控与评估所需的资金和资源纳入所有预防行动的计划中。 •与能够访问数据或能够协助进行数据收集、调查研究、分析和解释的学术机构合作。
能力不足（从事自杀预防工作的人可能没有监控和评估方面的经验/知识）	•让在数据收集的监控、评估和规划方面有经验的人（如公共卫生或社区发展方面的专家）参与进来，特别是在识别可衡量的指标方面。

[47] Further challenges and recommendations specific to different types of intervention are discussed here (http://www.sprc.org/sites/default/files/resourceprogram/ChallengesRecommendations EvaluatingSPPrograms.pdf, accessed 28 January 2021).

B 部分

“LIVE LIFE”：预防自杀主要的有效干预措施

以下各部分介绍了预防自杀的四种主要循证干预措施[48, 49]：限制自杀手段的可及性，与媒体沟通如何负责任地报道自杀，培养青少年的社会情感生活技能，对高自杀风险者的早期识别、评估、管理和随访。

必须同时建立多个交叉的基础支柱，以实现这些主要的干预措施(LIFE)。

[48] Evidence-based recommendations for management of self-harm and suicide in non-specialized health settings. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/en/, accessed 28 January 2021).

[49] Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents, accessed 28 January 2021).

限制自杀手段可及性

是什么？

限制致命自杀手段的可及性是预防自杀的一项关键的循证的通用干预措施。限制自杀手段的可及性包括：

- 通过以下方式限制获取自杀手段（例如，通过国家立法和政策限制、禁止或管制）：

»在孟加拉、约旦、韩国、斯里兰卡（Gunnell 等，2017）和印度（Bonvoisin 等，2020）等国家已经成功地禁止了剧毒和高危农药。

»澳大利亚（Chapman 等，2006）、以色列（Lubin 等，2010）、瑞士（Reisch 等，2013）和英国（Haw 等，2004）成功管制和限制枪支；

»在桥梁或铁路运输地点等可能发生坠落的地点安装护栏，澳大利亚的盖特威大桥（Law 等，2014）和韩国地铁站均在安装了护栏后取得了成功（Chung 等，2016）；

»在拘留所或其他机构环境（如监狱、住院病人的精神卫生）减少带子的可及性，或是改变挂钩点；

»减少高毒性药物的处方，特别是那些存在更安全替代品的药物（例如巴比妥酸盐（Oliver & Hetzel, 1972）和萘普生（Hawton 等，2009）。

- 通过以下方式减少自杀手段的利用度：

»限制药品和其他有毒物质的零售数量，例如降低药品的包装量，或使用气泡包装使得各种药品更难拿出来，这种方式在英国取得了成功（Hawton 等，2001）。

- 降低自杀手段的致命性（例如增加低风险替代品的供应）：

»像英国一样，推荐家庭使用天然气，其有毒一氧化碳比烧煤更少（Kreitman，1976）；

»降低杀虫剂的致命性。

- 提高解毒剂的可得性和有效性，提高常用自杀手段有关的急性中毒或受伤后的临床处置能力（世界卫生组织，2008a）。

彻底清除某种自杀方式将会产生最大的作用，尽管这可能会遇到来自利益攸关方的最大阻力。

有效限制自杀手段应关注以下：

»造成大多数死亡和/或高致死率（最致命的手段）；

»最常用的手段。

应优先考虑致死率最高的手段，因为消除常见但低致死率的手段有可能会促使人们采用更致命的手段。

不同地域和不同社会人口群体(例如城市/农村、年龄、性别)使用的自杀方法会有所不同，还会随时间而变化。有必要进行监测以识别人群或亚人群使用的自杀手段，尤其是任何新手段。这在最开始可以通过情况分析确定（见**情况分析**）。

本节重点介绍关于农药的例子。据估计，服农药自杀占全球所有自杀事件的五分之一，尤其是在农村居民和农业工作者占比很大的国家(Mew 等，2017)。据估计，自从农业绿色革命期间农药被引入贫困的农村社区以来，多达 1400 万人过早地死亡(Karunarathne 等，2020)。农药的毒性差异很大，有一些在摄入人体后具有剧烈毒性，而有些则可能不那么致命。干预措施旨在处理剧毒和高危农药，即对健康构成最严重风险的农药，而不是限制农业中使用的所有农药。

主要的措施包括禁止销售和使用剧毒、高危农药，同时鼓励使用低风险替代品，包括有机/非化学农药；加强对低风险替代品的研究；加强对农药产品的管理；鼓励妥善处置危险农药（联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织，2016；世界卫生组织和粮农组织，2019）。更安全储存农药的措施，如农药存放于家里上锁的箱子里或社区存放设施中，均没有明显的证据表明其有效性（Pearson 等，2017；Reifels，2019）。

为什么？

世界卫生组织提倡一些农药自杀占比较高的国家禁止使用高危农药，将其作为一种成本效益比较高的降低自杀死亡率的干预措施(世界卫生组织，2021)。据估计，在禁用高危农药后，自杀死亡率能下降 20%，相当于实现了联合国可持续发展目标 3.4(Lee 等人，2021)。

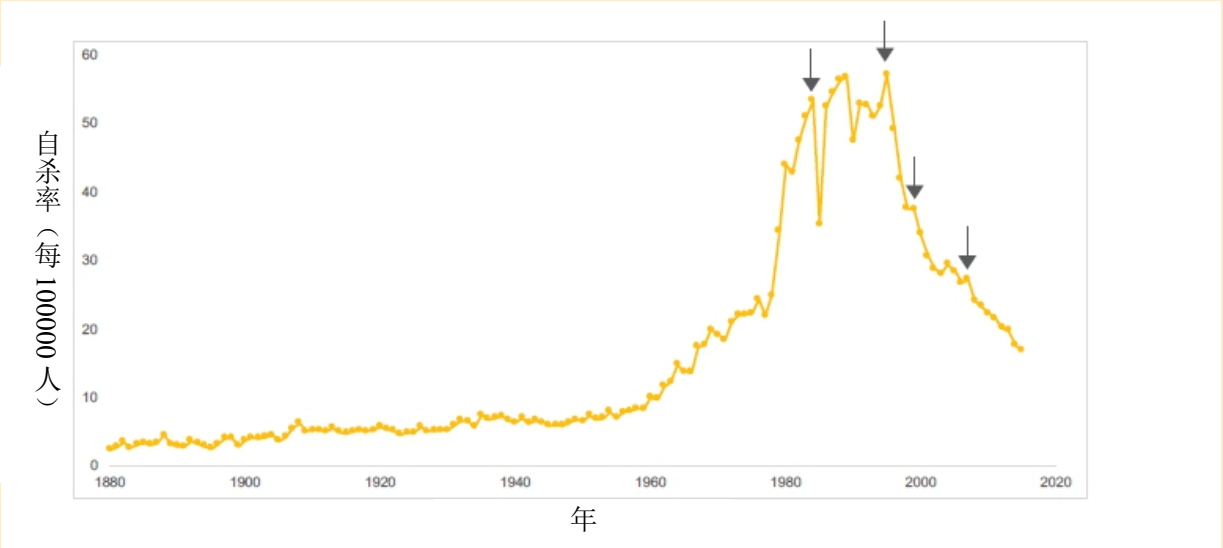
限制手段的获取不仅减少了与这些手段有关的自杀，且发现在一些国家降低了总体自杀率（这表明，替代自杀方法并不能弥补最初自杀率的减少，因为人们转而采用的是不那么致命的方法)。大多数有自杀行为的人都经历过想死还是想活的矛盾心理，许多自杀行为是急性应激反应下而冲动发生的（通常思考时间不到 30 分钟）。使致命的自杀手段更不容易获得，可以为处于困境中的个人提供时间，使其在采取致命行动之前度过严重危机。自杀未遂可能让其他人第一次意识到这个人处于痛苦中，而活下来会使这个人能够得到支持。在农业生产中去除高毒性农药（这样使得人们服入的农药毒性小得多），并提高农药中毒后的临床处置能力，无论其自杀意图强度如何，都可减少死亡人数。

专栏 32. 斯里兰卡：禁止使用高危农药

直至 1980 年，斯里兰卡被认为是世界上自杀率最高的国家之一，主要原因是服农药。当时农药登记处官员意识到了这一问题。鉴于资源有限，1983 年将首要预防重点放在禁止使用两种主要的农药——有机磷杀虫剂对硫磷和甲基对硫磷来减少自杀。十年后，农药登记处禁用了所有仍存留的被世界卫生组织划定为第一类的高危农药，特别是久效磷和甲胺磷，促使自 1995 年以来总体自杀人数明显下降。在接下来的 20 年里，随着 2008 年至 2011 年再次禁止使用百草枯和另外两种有机磷杀虫剂，总体年度自杀率从 1995 年的 57/10 万人下降至 2016 年的 17/10 万人，下降了 70%。据估计，这些禁令挽救了 9.3 万人的生命，政府每挽救一个生命的直接成本为 50 美元（Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017），而且没有影响农业产量（Manuweera 等，2008）。使用替代农药的方法是很适用的（Gunnell 等，2007）。这项工作得益于该国总统对自杀问题的重视，这是跨部门合作和项目可持续性的关键，也是监管部门、学术界、农业推广和工业之间积极互动的关键（Pearson，Anthony & Buckley，2010；Pearson 等，2015）。

为了将自杀问题成为全国的关注点，人们已经付出了不少努力，工业界也参与到解决方案之中。透明度、开放性、一致性、可预测性和包容性是利益攸关方参与的关键因素。自1983年以来，取得成功的过程和机制都是循环往复，随着每次禁令成功而逐步调整。

图 2. 斯里兰卡的自杀率，1880-2015



下箭头显示了农药禁令的时间（1984：对硫磷，甲基对硫磷；1995 年：所有依然在用的世界卫生组织第一类农药，包括甲胺磷和久效磷；1998 年：硫丹；2008 年：乐果、倍硫磷、百草枯）。自杀数据从警方记录中获取。

来源：Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017.

在哪里？

国家级的应对措施对于有效管理农药等手段至关重要，尤其是在农药有关的自杀率较高的国家。还可能需要在地区级合作执行地区的干预方案，并为类似农业国家的找到保护农业生产的有效解决方案。

什么时候？

当服农药中毒被认定为最常见和/或最致命的自杀方法之一时——比如通过情况分析、监测或其他国家层面研究而了解到的。进行持续性监测是必要的，有助于确定自杀方式及其随着时间产生的变化趋势——如使用哪个农药自杀，在哪个社区。

谁来做？

限制农药的可及性需要所有利益攸关方之间的跨部门合作，其中包括卫生部、农业部、监管和注册部门。农业地区的利益攸关方可能会认为限制自杀是侵略。与(农业)社区的领导人合作并得到他们的认可，这对于提高对剧毒物相关问题的意识和认可度，以及提高低风险替代品的利用度和好处至关重要。媒体在提高意识以及通过负责任的报道来减少“传染”效应方面，也是重要的合作伙伴（见“**与媒体互动促其负责任地报道自杀**”）。

全国性的多部门合作原则也同样适用于其他自杀手段（例如交通部门和设置防护栏的需求）。社区可以扮演一个重要的角色，提倡限制那些影响当地社区的自杀手段。
在可行和有效的情况下，在社区层面实施限制自杀手段也是一种选择（例如在地方级实施国家禁令）。在个人层面，若家中有处于自杀危险中的人，家庭成员要把家里的自杀工具（如农药、枪支、刀、药物）清理掉。

怎么做？

1. 召集一个工作小组（见引言专栏 1）

- 建立小组（见上文“谁来做”）

2. 找出某个人群中最常见和最致命的自杀方式

- 通过监测、监控或已有研究，找到这个群体中最常见和最致命的自杀和自杀未遂方式。

• 了解不同社会人口群体之间是否存在差异（例如，农村和城市地区之间）。

• 就农药而言，要弄清楚哪种农药造成的死亡最多。从医疗记录中可能很难获知这一点，可能需要对自杀死亡或医院诊治的农药中毒病例进行有针对性的调查。在可行的情况下，与法医毒理学实验室的合作可以识别最重要的农药并加以限制。

• 重要的是，致命的自杀方式是限制的重点，因为限制常见的低致命方式存在一个潜在风险，即可能会促使人们使用更致命的方法。

3. 与有关政府部门和其他涉及自杀方式的利益攸关方交流

• 限制自杀方式需要与上面第 2 点中所确定的自杀方式涉及的部门合作。

• 就农药而言，涉及卫生和农业部门以及农药监管/登记处。

• 通过数据向有关部门进行宣传（例如，与农药有关的自杀死亡或自杀未遂人数）。

• 了解农药行业利益攸关方和农药使用者的不同利益（世界卫生组织和粮农组织，2019）。

• 预期在一段时间内参与宣传。

• 确保讨论是双向沟通：更好地理解部门或利益攸关方之所以没有采取行动禁止高危农药的潜在担忧。利用这些信息来调整宣传工作。例如：

»如果有人担心更换农药可能会减少作物产量，那么就拿出证据证明情况并非如此，并找到保护农作物的替代的农业方法（Gunnell 等，2017；Manuweera 等，2008）；

»与媒体合作，使全国都注意这个问题，通过公众宣传给予压力。

• 对于其他自杀方式，请考虑以下利益攸关方：

»（枪械）立法委、枪械零售商、使用枪械的地点或职业（例如射击场、军役、警务）；

»（药物或有毒物质）监管机构，负责配药或开处方的机构，处理有毒燃料如某些有毒气体的部门。考虑对此类产品（在线）销售的监管也同样重要；

»（桥梁、高层建筑、铁路、地铁等坠落场地）交通和建设部门和机构；

»（对于带子/挂钩）司法部门，监狱和拘留机构，以及其他机构（如长期护理机构）。

4. 支持禁止或限制使用自杀方式所需的政策或立法行动

• 就农药而言，可采取下列行动：

»通过对当前流通的农药进行审查，识别出需要退市的高毒农药（粮农组织&世界卫生组织，2016）；

»禁止和管制销售和使用剧毒高危农药的行动，包括对进口致命农药及违反农药法规的处罚；

»对新产品注册的风险评估；

»加强对农药使用的检查和控制；

»推动低风险农药的登记和使用；

»增加对低风险替代品研究的资金和机会；

»支持无农药农业和农业生态学。

• 此外，还应考虑到政策行动的可接受性，并采取措施争取公众支持——例如，在农药问题上与利益攸关方（农民/农药零售商）合作，提高对监管和可行替代品必要性的认识。

5. 支持限制自杀方式可及性的社区行动

• 需要与地方当局合作，监督和执行国家法规和政策。

• 就农药而言，可以包括与地方农业管理部门（尤其是农业推广服务）合作，以加强检查和控制。与农民和农药零售商密切合作，提供关于产品退市的理由以及使用替代品好处的教育。

• 确保卫生部门具有关于农药中毒的临床处置和报告的能力和准则（世界卫生组织，2008a）。

6. 评估方案有效性（见监控与评估）

• 监控限制自杀方式对于自杀率的影响，核实从观察点收集的信息，并与国家和地方利益攸关方一起安排定期审核。具体而言，找到任何替代高致死率方式的方法或更换导致大多数死亡的农药的方法。

• 利用经验教训为政策和地方举措的进一步调整提供信息。例如，如果观察发现禁用的农药仍在使用，可以召集焦点小组来确定原因并制定更有效的补救措施。

• 评估结果可以告知利益攸关方，以鼓励进一步对自杀手段的限制和所吸取的经验教训的落实。

7. 确保实施有效监测，来评估自杀方式和自杀的变化

• 重要的是要确保对自杀方式和自杀未遂进行不间断监测，并对自杀方式的变化模式做出应对。

专栏 33. 韩国：一个成功的故事

与其他高收入国家和世界卫生组织西太平洋区域国家相比，韩国的自杀死亡率一直居高不下。2006 年至 2010 年期间，由农药导致的自杀约占韩国自杀总数的五分之一。2011 年以前在该国关于尽量控制和减少农药有害影响的努力并没有产生实质性影响，因为造成多数人死亡的农药没有得到充分管控。

2011 年，韩国制定了《自杀预防法案》，取消了百草枯的重新注册，并于 2012 年禁止其销售。这些方案使农药中毒自杀率直接显著下降，且使整体自杀率下降。干预措施似乎降低了所有群体的自杀率，包括了男性、女性、所有年龄组以及居住在城市和农村地区的人。

在 2011 年至 2013 年期间，一半以上的整体自杀率下降可以归因于百草枯禁令。重要的是，这一目标的实现对农作物产量没有任何影响。考虑到世界各地农药中毒自杀的人数，如果在全世界范围内有效实施对农药的管控，每年则可以挽救数万人的生命。确保能更安全地获取农药，需要采取跨部门合作，包括农药禁令和其他相关政策，以及社区干预措施、医疗改善以及培训和监测活动。韩国的成功做法为其他立志于减少自杀死亡的国家提供了令人鼓舞的榜样。

实施过程的提示

表11. 关于限制自杀方式可及性的建议

问题	建议
利益攸关方可能不愿意投资限制自杀方式，因为他们担心人们会转而使用另一种方法，而且也无法阻止那些决心自杀的人。	•与利益攸关方分享关于循证信息： »告知利益攸关方，限制一种自杀方式并不一定会导致其他自杀方式的增加（Yip等，2012）。 »在找到替代方式后，可以经常看到人们使用毒性较低的农药，从而降低了死亡率和整体自杀率（Gunnell等，2007）。 »大多数有自杀行为的人都有着想要活着还是死去的矛盾心理。限制自杀方式的获取可以在采取致命行动之前，为严重的危机提供时间。

问题（续）	建议（续）
利益攸关方出于与自杀方式相关的便利/财务利益而抵制	• 通过教育提高对与特定方式相关的认识，减轻焦虑。例如，向利益攸关方宣传低风险替代品的好处，并宣传使用低风险替代品不会对农作物产量产生负面影响（世界卫生组织，粮农组织，2019）。
自杀的主要方式之一是服用农药；然而在许多情况下这点仍未得到承认，很少采取行动或几乎没有行动。	•鼓励现有的中毒中心分享关于蓄意农药中毒病例的数据，以确定问题的规模。 •监测使用农药进行自杀或自杀未遂的情况以了解问题；让监管机构和相关政府部门（如农业部）参与国家对于农药可及性的监管。 •针对与自杀方式涉及的利益攸关方提高其强烈的自杀预防意识并举行宣传活动。 •将自杀和自杀未遂非罪化，以减少将中毒病例报告为自杀/自杀未遂的阻碍。
最常用的自杀方式并不容易被限制（例如在社区内的封闭场所外上吊；自焚）	•确保继续努力限制在机构场所中获取自杀方式；通过与媒体合作减少模仿这些方式的可能性（在报道自杀事件时删除对自杀方式的描述）；提高对上吊或烧伤的临床处置能力；改善社区求助（Gunnell等，2005）；提高对有自杀风险的人的早期鉴别能力（见早期识别、评估、管理和随访）。
数据收集不充分可能会妨碍对理应重点干预的自杀手段进行识别	•建立或加强对自杀自伤的监测系统，尽可能及时并准确记录所使用的自杀方式。这可能涉及鼓励报告自杀和自杀未遂的相关教育。

与媒体互动促其负责任地报道自杀

是什么？

证据表明，媒体对自杀的报道可能会导致自杀率因模仿而上升，尤其是在名人自杀以及对自杀方式进行描述的报道中（Niederkrotenthaler 等，2020）。相反，描述在不利情况下寻求帮助的故事，包括在哪里寻求帮助的信息，有助于预防自杀（Niederkrotenthaler 等，2014）。媒体（如记者、电影制作人）在塑造公众舆论和态度方面发挥着重要作用，在提高意识和减少自杀耻辱感方面是重要的利益攸关方。与媒体合作可以包括一起制定指南（例如最近的印度；Vijayakumar，2019），并规范对自杀的负责任的报道，以及与技术部门合作找出不符合报道准则的文章[50]。与媒体互动包括提高媒体专业人员负责任报道的能力建设。此外还包括监控数字媒体平台上用户内容的政策。

为什么？

对公众瞩目的自杀案件反复和美化的报道可能包括对自杀的详细描述和虚构描写——这些都没有准确反映现实的自杀率（世界卫生组织，2017）。反而导致了公众对于自杀的误解，阻碍了有效的自杀预防。随着数字媒体使用的越来越多，监测这些问题变得越来越困难，因为信息可以在用户之间迅速传播。然而，根据媒体指南来报道和描述自杀问题可能有助于预防自杀。

专栏 34. 立陶宛：媒体监测

媒体监测的主要目的是与媒体就负责任地报道自杀和自杀未遂达成共识。自杀预防局每一个工作日都会在网络媒体上审核近 700 份关于自杀或自杀未遂的报告。使用特定的关键字和媒体监测搜索引擎来实现监测，然后分析标题、文本、视频和照片材料。该分析基于世界卫生组织为媒体专家提供的资源手册（世界卫生组织，2017）以及立陶宛心理学家协会的指导。如果出版物违反了《公共信息道德规范》，将会联系网络媒体的编辑，并要求其对出版物进行修改。自杀预防局还为媒体专业人员提供了简短的研讨会，介绍如何负责任地报道自杀和自杀未遂。

[50] See the beta version of a data science tool developed to screen text automatically for its adherence to reporting guidelines for suicide (https://reportingonsuicide.cisco.com, accessed 28 January 2021).

在哪里？

理想的与媒体合作是与全国性的媒体机构合作，包括媒体监管机构。如果无法做到这一点，可以与可能接触到特定地域或社会群体的地方的或更专门的媒体机构建立合作关系。就跨国媒体而言，例如社交或数字新媒体，可能需要在总部(国际)和国家级开展合作，以促进在线自杀相关内容的管理的具有各国特色的方法。戏剧和影视行业也要纳入合作。

什么时候？

与媒体的合作可以随时开始，或许由需要回应的不良媒体报道引发。然而最好是先发制人启动合作，防止此类的报道。与媒体利益攸关方建立良好关系，例如通过让他们积极参与活动提高意识，这有助于建立更友好的关系，并为负责任的报道及监测方面的培训或政策制定做准备。可以在关键时间节点，例如在媒体专业人员的教育课程期间或在既定的开始一个招募周期时进行培训。可以利用增加对自杀预防关注的机会来促进合作，例如在世界预防自杀日或世界精神卫生日。

谁来做？

这项工作需要多个利益攸关方之间的合作。在国家层面，领导作用可以源自卫生部与媒体相关部门、国家媒体、媒体监管机构（如新闻监察员）以及社交媒体公司等跨国媒体之间的协作。在社区中，领导作用可能还来自于对自杀预防感兴趣的利益攸关方(他们可能有与媒体合作的经验或联系)。非政府组织可以在与媒体接触方面发挥影响力。例如，撒玛利亚会（英国）和自杀意识教育之声（美国）除了向报道自杀的记者提供个人建议外，还制定了关于负责任的自杀报道的媒体指南和培训[51, 52, 53]。

专栏 35. 奥地利：帕帕基诺媒体奖

关于媒体报道自杀准则的宣传和应用，在国家和国际上都是预防自杀的成功案例。同时，也有研究表明，特定形式的报道不仅可以防止模仿自杀(“维特效应”)，而且可以产生的整体上预防自杀的效应(“帕帕基诺效应”)。帕帕基诺效应指的是莫扎特的歌剧《魔

[51] Guest Blog: Samaritans Media Advisory Service and guidelines. London: Independent Press Standards Organisation (https://www.ipso.co.uk/news-pressreleases/blog/guest-blog-samaritans-media-advisory-service-and-guidelines/, accessed 28 January 2021).
[52] Samaritans' media guidelines. Epsom: UK Samaritans (https://www.samaritans.org/about-samaritans/media-guidelines/, accessed 28 January 2021).
[53] Journalist and media training. Bloomington (MN): Suicide Awareness Voices of Education (SAVE) (https://save.org/what-we-do/training/journalists-andmedia/, accessed 28 January 2021).

笛》中帕帕基诺的角色。在这部歌剧中，帕帕基诺在别人的帮助下克服了自己最初的自杀想法。在奥地利，奥地利新闻委员会于 2012 年在其道德规范中规定了预防自杀的报道。不符合负责任报道的媒体，将会受到国家新闻委员会的警告。为了进一步宣传媒体指南并促进奥地利预防自杀报道，在 2019 年，联邦社会事务部、卫生照护和消费者保护部与奥地利预防自杀协会、维也纳自杀研究工作室和克里森干预中心合作创立了“帕帕根诺媒体奖”[54]。每年都会从奥地利印刷和数字媒体专业记者中选出一位获奖者。对媒体文章根据指南以及新闻标准(例如文章本身的质量)对自杀的正面主题化进行评估。获奖者由五名记者(由新闻委员会、记者协会、新闻俱乐部、奥地利报业协会提名)和五名自杀预防专家组成的评审团选出，这体现了与媒体间的良好合作。这些专家包括有亲历和丧亲者（由获得“帕帕基诺媒体奖”的奥地利国家自杀预防计划 SUPRA 的咨询委员会提名)。2020 年预防自杀媒体报道的“帕帕根诺媒体奖”于 9 月 10 日由联邦部长颁发给来自 ORF(奥地利广播公司)的乌苏拉.特雷兹巴赫，表彰其在《帕诺拉马旅行记》上关于自杀的广播故事。

怎么做？

1. 召集一个工作小组（见引言专栏 1）

- 创建小组（见上文“谁来做？”）

2. 了解当前的媒体报道和媒体监管框架

- 评估目前媒体对自杀的报道，找出负责任报道的例子，以及需要干预的有问题的报道的例子。
- 为媒体专业人员确定负责任的自杀报道方面的现有政策、指导或培训机会（如果在情况分析中尚未确定)。
- 如果没有特别有效的，则考虑是否需要新的政策、指导或培训，或这些是否可以纳入现有的做法。
- 确认是否有针对媒体的道德规范，规范中又是否包括负责任的自杀报道。负责监管的机构应作为其中关键的利益攸关方。

3. 与媒体专业机构沟通

[54] Papageno media award for suicide prevention reporting. Vienna: Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Preise-und-Guetesiegel/Papageno-Medienpreis-fuer-suizidpraeventive-Berichterstattung.html, accessed 28 January 2021).

• 如果无法与国家或地区代表机构沟通，就与个体媒体组织合作（例如无线电广播公司或是服务于当地地区的印刷报纸）。然而整体来说，首先与多个（当地）媒体见面有助于培养集体责任感。

• 跨国媒体公司，如数字社交媒体，可以与国家媒体组织一起作为利益攸关方。他们可能需要一个单独的合作安排，取决于他们在国家的法律地位。

4. 传达负责任报道的重要性，并讨论合作努力

• 确保所有利益攸关方都清楚，合作的目的是对媒体对自杀行为负责任的报道实施循证干预。

• 一个重要的论点是关注和理解到耸人听闻式自杀报道的传染效应。

• 确保信息适合媒体利益相关方，并且是基于循证的——例如利用现有的世界卫生组织资源（世界卫生组织，2017；世界卫生组织，2019）。

• 确定媒体关注的领域，如新闻、娱乐或社交媒体。

5. 商定用于增加负责任的自杀报告的策略；例如：

• 制定负责任报道的政策和准则，监督并管理有问题报道的问责机制。

• 在教育课程中为媒体专业人员或媒体学生提供持续性培训。包括耸人听闻的媒体报道对自杀的影响，并对负责任的报道提供实际指导，增加关于如何应对自杀的正面报道，及包括关于资源和读者/观众可以到哪里寻求帮助的信息。

• 建立一套可识别最佳做法的系统（例如，提名个人或机构获得已有的杰出报道奖，或设立新的表彰方案）。

• 商定提供资源（如，媒体资料包）或为媒体专业人员提供自杀预防专家的联系信息，以供报道自杀事件时用，

• 对社交媒体，要考虑：

»管理社交媒体和数字媒体中用户创建内容的政策和机制；

»针对用户的当地背景提供特定转诊路径或资源。

• 加强与媒体的合作还需考虑：

»在提高认识和宣传运动和活动中利用媒体（见**提高意识和宣传**）；

»为可能受到自杀影响的媒体专业人员提供支持。

6. 商定行动计划

• 概述开发和实施每项活动需要采取的步骤。商定哪些利益攸关方将要负责执行行动计划的每个步骤。

• 考虑实施不同的行动时的重要时间节点（例如，培训可以作为新员工入职的一部分，并且可以定期举办进修研讨会）。

• 商定工作覆盖范围例如，覆盖面可以是全国的、地区的、针对特定媒体类型的（如所有印刷新闻）或针对单一媒体公司（如当地广播电台）。

7. 实施方案并进行评估

• 使用有意义的指标，提前计划如何评估每个方案的有效性（例如，耸人听闻的或负责任的自杀报道方面的变化）（见监控与评估）。

• 创建培训、指导方针和政策的定期评审日程，以确保这些反映的是最新研究和基于实践的证据。

• 实施监控程序来收集恰当报道自杀的信息，并对不良描述提供及时的建设性反馈。

• 评估可传播给更广泛的媒体，以鼓励进一步采纳建议并实现所吸取的教训。

专栏 36. 马来西亚：与媒体合作的成功与挑战

2004 年世界预防自杀日，马来西亚卫生部以“使媒体成为宣传预防自杀的伙伴”为主题，为媒体专业人员组织了一次国家级研讨会和讲习班。这促进了马来西亚 2011 年更新的媒体自杀报道准则的发展。然而，马来西亚报纸的框架分析似乎表明，截至 2018 年，马来西亚的报纸并未遵守媒体指南（Victor 等，2019 年）。因此，政府、非政府以及国际组织在过去的两年中加强了提高负责任报道的努力——如公开演讲、媒体采访、能力建设研讨会以及社媒互动。尽管在不同区域和国家情况各不相同，但利益攸关方的参与一直是鼓舞人心的，为解决这一问题，医疗专业人员、有亲历自杀者、媒体专业人员、学术界人士和行业监管机构之间的壁垒正在被努力破除。同时也需要进行进一步的评估，以弄清媒体对准则的执行程度及其对马来西亚自杀行为的影响。

专栏 37. 特立尼达和多巴哥：媒体指南

自杀是特立尼达和多巴哥的一个重要的公共卫生问题。作为降低国内自杀率策略的一部分，特立尼达和多巴哥卫生部与泛美卫生组织/世界卫生组织一起，与当地新闻媒体代表共同举办了一次提高意识的研讨会。这次研讨会有记者、播报员、编辑、电台播音员和博客作者等参加，讨论媒体在预防自杀方面起到的作用。在研讨会期间，专家们分享了负责和不负责的文章对自杀的影响的证据，并分享了媒体报道这一问题的规范行为。一位高级制作人说，研讨会让她知道媒体不该对死亡原因做出假设：“我们应该提供事实而不是

进行揣测或耸人听闻……让人们知道自杀行为是有迹象的，可以帮助他们识别这些警告信号，并提供寻求帮助的建议。”

卫生部在泛美卫生组织的支持下，制定了关于负责任的自杀自伤报道的 11 项最佳做法准则。包括一个国际专家小组在内的利益攸关方对准则草案进行了一系列审查，确保其与最佳做法一致，并对媒体遵循该草案的可能性进行了评估。该准则与利益攸关方共享，并在最终定稿和发布之前得到进一步反馈。

为了衡量准则所产生的影响，卫生部还制定了一个监控和评估框架，用以评估媒体如何遵守准则。该工具用于评估媒体的依从性，并确定进一步完善的问题和机会。该框架对网上所有与自杀相关的新闻报道（死亡、自杀未遂、自伤、自杀预防的文章等）进行评级，包括违反准则的数量和报告中包含有用信息的数量，如自杀热线、应对策略。然后根据媒体机构的分数联系他们，提醒他们遵循准则，并告知所需的额外资源。

关于准则发布以来所产生变化的正式研究尚未完成。然而，报道的基调已经发生了显著的变化，尤其是对故事情节的处理以及对于明确自杀细节的省略。此外，还将计划进行一次全面审查，以评估自准则提出以来媒体报道在质量和数量上产生的变化。这是评估准则所必需的。其中一个挑战是偶尔还会引来对谋杀后自杀的不负责任的报道。

实施过程的提示

表 12. “LIVE LIFE”与媒体互动的实施建议

问题	建议
耸人听闻的标题对于媒体是有利的，但会导致违反负责任报道的商定准则	• 让利益攸关方参与到关于自杀报道的道德影响及责任的合作性的、非惩罚性的讨论中。 • 强调将报道与自杀之间关联起来的证据。 • 让有相关经验的人（包括媒体界）发声，突出受众对非哗众取宠的报道的偏好。提供关于知名人士分享他们从心理健康问题/自杀念头中成功康复的故事作为例子。

对负责任的报道缺乏结构性支持（例如期限较短、采编后修改）	• 让媒体专业人士渗透机构的各个层级，包括管理层和编辑。 • 在媒体中培养预防自杀的拥护者（例如有实际经验的记者）。 • 加强对负责任报道的监督，并与利益攸关方讨论监管问题。
限制不同利益攸关方之间的合作，尤其是在牵扯盈利的利益攸关方可能相互竞争的情况下	• 定期召开会议以维持关系并培养集体责任感。在会议期间建立起不同利益攸关方之间的沟通渠道。 • 一旦在组织中建立起了良好行为规范，通过学习重点可以促进其他目标机构的主动性。
监管公开生成的内容的困难（例如社交媒体）	•与社交媒体公司合作，提高他们的意识，并制定/改进关于识别并删除有害内容的协议。 •建立公开举报有害内容的机制（如污名监察[55]）。

[55] StigmaWatch, Sane Australia (https://www.sane.org/get-involved/stigmawatch, accessed 28 January 2021).

培养青少年的社会情感生活技能

是什么？

对于预防青少年自杀，世界卫生组织的《帮助青少年茁壮成长(HAT)指南》（世界卫生组织，2020）和具有成本效益的心理健康干预方案（世界卫生组织，2021）建议在学校开展社会情感生活技能培训。准则中包括心理健康意识培训（即普及心理健康知识）和技能培训（例如问题解决和应对压力）。建议采用积极的心理健康方法，而不是直接关注于自杀问题[56]。

为了强化在学校推行循证的社会情感生活技能课程，可以考虑在以下方面进行补充完善：

- 为教职员工提供守门人培训，包括如何创造一个支持性的校园环境，如何识别自杀行为的风险因素和警告信号，如何为痛苦的年轻人提供支持，以及如何通过合作寻求额外支持。
- 营造安全的校园环境（例如：反欺凌计划、加强社会联系的措施、营造支持性环境的教职员培训）。
- 建立和加强与外部支持服务的联系，并将这些信息提供给学生。
- 为面临自杀风险的学生提供特定支持，如曾自杀未遂的学生、因自杀而丧失亲人的学生、或是来自有自杀风险群体的学生（例如性取向或性少数群体）；
- 为被判断为有自杀危险的教职员提供明确的支持政策和规定，教职员或学生有自杀或自杀未遂时开展沟通，以及为自杀未遂的学生重返校园提供支持。
- 提升教职员心理健康。包括对自身心理健康以及获得支持渠道方面的培训。
- 让学生家长参与其中，提高家长对心理健康和危险因素的意识。
- 开展关于健康使用互联网和社交媒体的教育（例如，安全使用互联网、利用社交媒体建立健康的社会支持、识别及应对不健康的网络活动——如网络欺凌）。
- 制定解决青少年面临的其他危险因素的措施（例如家庭暴力、家庭创伤、药物滥用）。

[56] 积极的心理健康方法包括聚焦于培养学生的长处和能力，以及帮助他们掌握新技能以改善精神健康，而不是刻意聚焦于自杀预防。

专栏 38. 世界卫生组织《帮助青少年茁壮成长》(HAT)

世界卫生组织的《帮助青少年茁壮成长》(HAT)指南（世界卫生组织，2020）提供了关于社会心理干预的循证建议，以促进青少年的心理健康、预防心理障碍，减少自伤和其他危险行为。该指南用于发布在各种平台，如学校、医疗或社会照护机构、社区或数字媒体。该指南旨在为一系列干预措施——HAT 工具包提供信息。开发该工具包是为了用以指导 HAT 指南的操作，目的在于收集一系列核心的循证依据来支持旨在努力促进和保护青少年心理健康的策略。HAT 工具包介绍了促进青少年心理健康或减少精神疾病、药物滥用和自伤危险因素的证据。该工具包聚焦于：1)完善法律政策；2)改善学校、社区和网络环境，促进和保护青少年心理健康；3)支持其照护人员；4)提高青少年的心理技能。该工具包还为用户提供了有关实施工具和经验的其他来源信息。联合国儿童基金会和世界卫生组织于 2021 年推出 HAT 系列漫画，并附带一份教师指南，旨在加强学校青少年的社会情感学习。

为什么？

青春期（10-19 岁）是获得社会情感技能的关键时期，也是将来健康和幸福的基础。然而，青春期也标志着一段罹患精神障碍的风险期，所有病例中有一半发生在 14 岁之前。与积极心理健康相关的社会情感技能的形成，是青少年发展为心理健康成年人的基础（世界卫生组织，2015；Sánchez Puerta 等，2016）。提高心理健康素质，可能有助于减少耻辱感，增长心理健康知识（Milin 等，2016）。同时，帮助年轻人注意到自己和他人的警告信号有助于他们寻求帮助（Burns & Rapee，2006）。鉴于教育环境是许多国家年轻人与社会的主要联结，在教育环境中实施自杀预防是能够触及青少年群体的可行方法。

在哪里？

在国家层面或地区级，都可以教育环境中合作开展青少年的社会情感生活技能训练。活动范围可以从学校或学校的合作伙伴、青年中心/活动中心、以及无家可归的青年教育方案等项目，到全国范围内将社会情感生活技能干预措施纳入到对教育课程。越来越多的证据表明，此类技能课程正在被改编，以适应数字化。在扩大规模之前，最好先在一个地区或规模较小的学校进行试点测试

专栏 39. 澳大利亚：针对青少年原住民和托雷斯海峡岛民的循证应用

iBobbly[57]是一款为澳大利亚 15 岁以上的年轻原住民和托雷斯海峡岛民设计的社会和情感健康类自助 app。这款 app 使用了接纳与承诺疗法和认知行为疗法。iBobbly 首先在一项随机对照试验中进行了测试，该试验涉及了来自西澳大利亚金伯利的 61 名原住民（Tighe 等，2017）。用户上报他们的抑郁和心理痛苦程度明显降低。iBobbly 受到了试用者的好评，用户的反馈也很正面（Tighe 等，2020）。第二次也是大规模的试验于 2019 年 8 月结束，试验涉及澳大利亚 6 个地区的 400 多名参与者。初步结果是较为乐观的。重要的是，在应用程序中看到、听到和经历的一切都是由原住民和托雷斯海峡岛民社区成员打造的，以确保 iBobbly 是符合文化背景且安全的。iBobbly 应用程序中的大部分艺术作品都是由当地艺术家设计的。该应用程序中使用的语言也是在与年轻人协商后选择。年轻人提议的其他种类的语言等方面的建议也被纳入该应用程序。此外，大部分旁白是由当地一家土著媒体机构录制的。iBobbly 是与澳大利亚当地原住民和托雷斯海峡岛民密切合作下开发的，由一个顾问小组指导、发布并组织与 iBobbly 实施和质保相关的项目活动。这个小组确保 iBobbly 能持续符合文化标准，且由该应用程序的目标对象——原住民和托雷斯海峡岛民——发布、打造并指导。

什么时候？

在开始行动之前，应在学校与地方医疗和社会保障服务之间建立起能支持青少年的医疗路径（如儿童和青少年心理健康服务）。培训的实施或许要取决于时间安排，例如在压力很大的时期（例如考试期间），提前开展技能课程。然而，在自杀发生后立即开始自杀预防活动是不可取的（但应该向学校成员师生提供社会心理支持）。

谁来做？

学校的自杀预防在有多个利益攸关方合作时效果最好。卫生部和教育部之间的合作可以发挥领导作用。在社区中，领导角色可以由能从自杀预防或年轻人健康获益的个别学校或组织来承担。为了最优地实施预防，必须要考虑得到当地政界人士、学校、工作人员（包括教师和学校辅导员/护士）、家长和看护人、当地医疗和保障服务机构和/或与年轻

[57] iBobbly. Black Dog Institute (Australia) (https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/digital-tools-apps/ibobbly/, accessed 28 January 2021).

人合作的组织（如体育团体或青年团体）的支持。在设计学校预防方案时，必须让年轻人参与其中。年轻人可以很好地提出关于如何吸引同龄人以及识别社区特有危险因素的建议。

怎么做？

1. 召集一个工作小组，计划及推行学校项目（见引言专栏 1）

- 成立小组（见上文“谁来做？”）
- 在实施方案之前，确保学校有足够的行动计划来支持学生，且与心理健康服务机构建立足够的联系，以便将有风险的学生转到这些服务机构。确保学校员工了解这些流程，并有信心和能力执行。
- 安排在选定地区或是选定的若干学校进行试点，然后再扩大试点范围。

2. 为年轻人选择一种循证干预措施

- 应该聘请一名青少年心理健康和预防自杀方面的专家，以确保选定的方案是基于循证的。
- 确定符合目标人群、社区或学校需要的课程；除了现有资源之外，还将取决于年轻人的需求。如果该支持方案需要确定一个循证项目，建议工作小组咨询研究专家、专门从事自杀预防的机构或是熟悉这一领域知识的人。
- 应优先考虑以前评估过的方案，这些方案表明执行所需资源及其优势和局限性。
- 与原方案相比，学生对自杀的态度——或他们如何表达警告信号和寻求帮助的行为——可能存在文化差异，因此要根据目标人群调整方案。
- 就如何在不降低效率的情况下做出最佳调整，征询方案制订者的意见。或找到已经成功调整了方案的临近地区或学校的学生群体进行咨询。

3. 商定行动计划和所需资源的计划

- 计划实施方案所需的人力资源和能力建设（例如，需要培训一名协调员或学校工作人员）。
- 决定由谁来实施该方案（例如，心理健康服务提供者、学校福利工作人员、健康服务提供者）。确保在学校和当地精神卫生服务机构之间建立督导机制。也可以有机会让同龄人或父母参与进来。
- 决定执行每项行动的时间线。考虑什么时候执行该方案最有效，以及重复执行的频率。
- 定期安排会议，回顾进展并决定新的行动。

4. 制定评估计划

• 预先计划如何评估方案的有效性（见**监控和评估**）。可从方案创建者现成的验证流程中获得指导，其中可能包括：

»在方案实施前后就心理健康/自杀的知识和态度进行问卷调查、对自尊以及其他技能的测评；

»对自杀行为的影响

»学生和教职员工对于方案及其资源的经验和意见的反馈。

• 利用所吸取的经验教训，为今后执行方案的变化提供信息。

• 确定扩大干预措施的计划（例如，扩大至一所特定学校里更多的学生、至另一地区或至全国所有学校）。

专栏 40. 瑞典：青年心理健康意识促进(YAM)，从研究到实施

拯救和关怀欧洲青年生命(SEYLE)是一个研究项目，旨在评估三个以学校为基础的促进心理健康和自杀预防的方案。这项随机对照试验对 11110 名青少年进行研究，他们分别来自 10 个欧盟国家中随机抽取的 168 所学校。SEYLE 研究表明，与其他两个方案和对照组相比，YAM 显著改善了年轻人的心理健康水平。参加 YAM 项目的年轻人新发生的自杀未遂和严重自杀意念比对照组减少了 50%(Wasserman 等，2015)，而中度和重度抑郁症的新发病例减少了约 30%。

这个五小时课程的 YAM 项目，由一名受过专业培训的讲师和一名助手讲授，为期三周。它为上课的年轻人提供一个安全和不加评判的空间，让他们探索心理健康话题。重点是对他人经历和同伴支持的共情，同时使年轻人能够思考自己的心理健康需求(Wasserman 等，2018)。为支持角色扮演活动，讲师提供互动的谈话环境；向每位参与者分发主题小册子以及在教室墙上张贴海报，这些海报提供了包括当地医疗保健和青年支持服务在内的信息。

在 YAM 结束后的访谈中，年轻人表示更有信心支持需要帮助的朋友。他们还指出，可以使用在课程中获得的技能和策略来帮助他们度过负性生活事件。也许最重要的是，YAM 帮助年轻人认识到在遇到困难时支持的必要性。为了实现这一需求，可以与他们分享有关当地身心健康护理方案以及社区中的青年服务组织的信息。

YAM 项目是一个新颖、有效且经济实惠(Ahern 等，2018)的以学校为基础的自杀干预措施，它改善了年轻人的应对技能，培养了共情能力、寻求帮助的行为和同伴

互助，鼓励了积极的课堂氛围。YAM 项目已被世界各国采用。国际精神心理健康（The Mental Health in Mind International）是一家在卡罗林斯卡创新研究所的支持下创建的研发企业，正在推广 SEYLE 项目的成果。目前正在欧洲(奥地利、法国、挪威、瑞典、英国)、澳大利亚、印度和美国实施和评估该项目。到目前为止，全球已有超过 10 万名学生参加了这项 YAM 计划。

有助于实施 YAM 的因素包括：1)已经制定了一套可用于实施 YAM 的现成方案，而且开发人员与新试点进行合作，其中包括培训和质量保证措施；2)所有实施 YAM 的地点都设有基础设施，以便进行监督和持续培训；3)有一个将该项目依据文化特点进行翻译和改编的方案；4)这一过程是参与性的，并且参与者始终包括年轻人；5)提供关于参加项目的点如何获得实施资金的建议；6)当人们致力于在 YAM 中通过发展年轻人的技能来贯彻自杀干预方案的情况下，该方案效果最好。

实施过程中的提示

表 13.培养青少年社会情感生活技能的实施建议

问题	建议
不愿在学校讨论心理健康话题；(领导、学校或父母/看护人)不愿与年轻人讨论心理健康问题、情绪困扰和自杀行为	• 鉴于年轻群体的自杀风险，与教育部门密切合作，了解干预以及情感和生活技能培训的必要性；为教师提供守门人培训；让社区中的家长/看护人代表提高意识和/或提供培训；有意识地让年轻人参与所有干预方案的设计。 • 提醒教师或看护人，与年轻人谈论自杀不会增加自杀风险，反而意味着年轻人更有可能因此在需要的时候向他们寻求支持。 • 如果由于以前在学校内自杀的经历导致不愿谈论自杀，那么重要的是向受影响的人提供足够的支持(如事后干预咨询)，并做好干预工作以防今后发生类似事件。 • 通过冠军/名人鼓励青少年参与。
来自员工的阻力	• 在启动学生方案之前确保教职员工的良好状态是至关重要的，这样他们才能够更好地帮助处于危险的人。其中包括提供一个安全的学校环境，鼓励教职员工获得支持，并进行充分的培训，以增强他们对于与陷入困境的学生沟通和管理风险的信心。 • 对需要校外服务/支持的学生，确保良好的跨部门协作也很重要。
缺乏时间和资源来计划和实施，或者与传统的学术课程相比，它不被视为优先项	• 干预方案可纳入现有的学校干预举措(如健康课程或其他健康项目)或同伴领导方案。 • 学校日程上现有的活动可以为启动干预方案提供机会，如学校健康周和心理健康意识日/周。

早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为影响的人

是什么？

早期识别、评估、管理和随访可以确保有自杀风险或自杀未遂行为的人获得所需的支持和照顾。卫生系统需要将自杀预防纳入核心内容，以便在人们被确定有自杀危险时及早进行干预。医护工作者应接受早期识别、评估、管理和随访方面的培训(WHO，2019b)。接触高危人群（例如在社区）的非卫生行业人员应具备早期识别和随访的能力。卫生保健系统应协调出照护通道，以便将个体转介到社区或精神卫生专科接受后续干预。高危人群可能会遇到仅靠卫生部门无法解决的危险因素和照护需求。例如，某个人除了需要卫生系统的支持外，可能还需要在获得就业机会或经济方面的支持。比如在日本，因经济困难去社会福利部门求助的人会被自动转介到卫生部门进行同步照护。

事后干预支持[58]要为自杀未遂和因自杀而丧亲者提供帮助。除卫生服务提供的支持外，社区主导的随访适用于因自杀而丧亲的幸存者团体(WHO，2008b)，有自杀行为经历者的自助小组，或志愿服务[59]。此外还应提供危机服务，如社区危机治疗小组或危机热线，以向处于严重困境中的个体提供即时支持(WHO，2018c)。

专栏 41. 韩国：针对自杀未遂者的病例管理

在韩国，在中央政府的支持下，2013 年对因自杀未遂去急诊室就诊的患者实施了病例管理。2018 年 1 月，政府相关部门发布了《全国自杀预防行动计划》，提出了加强对自杀未遂者的咨询和随访管理的具体行动任务。2013 年，以急诊科为基础的自杀未遂病例管理在 25 个地点启动，至 2020 年已扩大到 85 个地点，并将继续扩大。病例管理者在病人因自杀未遂到急诊科的 24 小时内联系他们，并且每周都会开会讨论手头所有的病例。所有参与医院都得到督导，目前也在进行对该方案的评估。

[58] 事后干预支持是指自杀未遂或自杀后进行的干预。
[59] Befrienders Worldwide (https://www.befrienders.org/) (2021.1.28 获取)

为什么？

卫生系统目前无法满足人们的心理健康需求，服务的稀缺和分配不均意味着许多人得不到所需的照护(WHO，2018b)。至关重要的是，必须以全民健康为目标[60]，确保所有人都能获得有质量的照护[61]。在英格兰和威尔士，实施精神卫生康服务建议之后——包括提供 24 小时危机照护、对双重诊断患者的地方政策，以及在自杀后提供多学科检查——临床人群自杀率随时间的推移而降低(While 等，2012)。此外还包括提供数字化随访和管理。

由于经历躯体和精神疾病的患者自杀风险增加(WHO，2018b；WHO，2019b)，而且由于他们可能已经接触过卫生服务机构，所以卫生保健工作者能更方便地识别处于风险中的人。因此，卫生工作者应该培训如何去接受识别、评估、管理和随访有自杀风险的人，并应该有信心完成这个任务。人们在去卫生服务机构就诊后，可能会感到孤立，自杀未遂的缝隙可能会进一步增加。因此，及时和系统的随访照护非常重要，既往已有证据表明这样做可以减少出院后的自杀和自杀未遂(Goldman-Mellor 等，2019；Fontanella 等，2020)。受自杀影响的家人和朋友也可能有较高的自杀风险，因为他们可能会因为该自杀事件而感到内疚、羞愧和耻辱，进而使他们很难获得社会支持。应向这一群体提供积极的随访。

在哪里？

促进早期识别、评估、管理和随访的举措应在国家级别协调，但也要适应当地社区的需要。在扩大规模之前，应在个别卫生服务或地区卫生服务中进行试点。应在各级卫生医疗服务——特别是初级医疗服务中开展活动。初级卫生服务可能是许多国家(精神)卫生服务的主要来源，以及人们在自杀未遂(这是自杀的一个重要危险因素)后可能前往的急诊场所。

什么时候？

在开展能够识别高危人群的活动(如培训卫生工作者)之前，应建立管理和随访的照护通道。培训社区卫生工作者或实施者需要具有策略性的时间安排(见**能力建设**)。

---

[60] 全民医保。日内瓦：WHO((https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1，2021.2.19 获取)。

[61] WHO 质量权利倡议。日内瓦：WHO(https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools，2021.1.28 获取)

谁来做?

卫生部应与当地卫生服务机构一起领导这项工作——即，活动针对有机会与高危个体接触的特定卫生部门或单位，如那些急诊、精神卫生、酒精使用障碍、慢性疼痛或慢性病的部门或单位。这项工作需要与社区中能在早期识别或随访方面发挥作用的利益攸关方(如社会关怀、社会福利、教育、警察和其他守门人)合作。

怎么做?

1.召集一个工作组(见引言专栏 1)

- 建立工作组(见上文“谁来做？”)。
- 该小组应包括了解当地卫生系统和公共卫生政策的人，以及了解该系统当前问题的卫生专业人员。
- 该小组还可能包括来自其他部门的人(如警察、教师、社会护理工作者)，具体取决于该背景下的照护通道或随访情况。

2.绘制当前资源图

绘制卫生和其他部门的资源图(见**情况分析**)，为受自杀影响的人提供早期识别、评估、管理和随访(例如，社会照护、教育、司法、服务用户群体)。

3.协调照护通道

- 安排各种途径，使被评估为高危的个体能够在卫生机构中得到评估，并能转介到社区或专门的精神卫生机构 (WHO，2019b)。
- 创建统一的转诊文件，并商定在照护通道中的所有部门之间进行转诊的路径、程序和标准。
- 为制定明确的指导方针提供支持，使在其他部门识别的有自杀危险的个体能够被转介到卫生保健部门进行评估、管理和随访。

4.培训非专业卫生工作者

- 培养非专业的社区卫生工作者的能力，包括管理有自杀风险的人、进行转介、并与接受过自杀预防和心理干预培训的专家及非专家建立联系(见**能力建设**)。

• 在情况分析中发现差距所在，利用社区资源的支持，制定计划提供充足的地方服务进行干预(包括危机管理)和随访[62]。

5.培训社区守门人和利益攸关方早期识别和随访相关技能

• 其中应该包括：1)认识自伤/自杀的常见表现，以识别有危险的个体；2)自伤的评估和管理原则，包括正处危机中的人(例如，如何询问自伤；识别自伤或服毒)；3)心理社会干预(例如，提供关于自杀的心理教育；调动社会支持资源)；和 4)转介至专家并进行随访。

6.监控、评估和扩大规模(见**监控和评估**)

• 应事先计划好监控测和评估，并在实施过程中同步进行。

• 使用卫生系统中目前可用的数据收集机制，或创建其他方法来监控进展。指标可包括： 1)含接受过自杀干预培训的非专业人员的机构比例; 2)新增病例和随访病例数； 3)每个医疗机构的转诊人数； 4)用户对于干预和支持的结果和反馈（见附录 3）。

• 根据学到的经验改善服务条款和照护通道，并计划扩大规模。

• 进一步分析情况，找出服务中的差距，并制定改善计划。

专栏 42. 澳大利亚：原住民特有的出院后照护

南澳大利亚州建立了澳大利亚第一个原住民特有的出院后照护模式，该模式由当地原住民社区提供并共同设计。2017 年，南澳大利亚国家初级卫生网络(CSA PHN)与黑狗研究所合作举办了一系列原住民社区论坛。磋商结果表明，人们乐意为自杀危机后出院的人提供随访服务，且认为这是当地的服务缺口。在与当地社区的合作下成立一个原住民工作组，成员包括有自杀经历者以及来自当地卫生网络和原住民社区控制卫生组织代表。该小组花了 8 个月的时间见证了联合设计过程并开发了一个模型，然后花了 4 个月的时间征求利益攸关方的意见。

CSA PHN 委托皮卡威亚原住民健康服务公司在奥古斯塔港提供原住民出院后照护理服务。皮卡威亚健康服务公司成立了一个由临床小组组长——一个社会工作者——和两名原住民医疗工作者组成的出院后照护小组。出院后照护小组隶属于社会和情感健康团队(SEWB)，并得到了心理学家和特邀精神科专家的支持。

[62] WHOmhGAP 培训手册。日内瓦：WHO(https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/，2021.1.28 获取)

该项目已经制定了两套指南用于急诊科和社区精神卫生团队，这些是原住民出院后照护服务设计和与自杀有关的危机和随访护理综合准则。每一个都提供了一个全面的阶段性方法，在入院和出院后保持联系，结合心理社会、临床和治疗的方法，重点关注家庭和社区。

一个意想不到的积极结果是，在精神卫生服务各个领域的临床和文化工作者之间加强了合作。由特邀精神科医生审阅的精神卫生和转介计划往往还包括康复建议及其他支持。出院后照护工作人员被邀请参加与 ngangkari(丛林医学的土著从业者)共同进行的传统治疗。同样，据报道，医院精神卫生工作人员更愿意将出院后的人转介到社会和情绪健康服务机构以及全科医疗服务机构，因为他们知道这些服务机构可以利用出院后照护小组的专业知识。目前的临床处置，包括医学支持都在皮卡威亚卫生服务中心而不是医院进行，因此要继续在卫生服务中心内进行能力建设。

出院后照护服务还与现有的事后干预服务联合，其中包括国家原住民危急应答服务和“远离忧郁”——即“回家之路”服务。

专栏 43. 伊朗伊斯兰共和国：扩大心理健康服务和自杀预防规模

伊朗伊斯兰共和国将精神卫生服务纳入初级卫生保健的举动，被认为是扩大公共精神卫生服务——包括自杀预防方案——的主要转折点之一。主要通过全国农村和城市地区的初级卫生保健领域的全科医生 (GP)、多功能全科卫生保健人员和临床心理学家提供初级精神保健，来寻求获得更多精神卫生保健服务的机会，及早识别抑郁症和其他（与自杀有关的）精神卫生疾病。多功能全科卫生保健人员根据客户的年龄组进行精神健康问题的初步筛查，并与其他健康领域的评估同步进行。如果检查结果呈阳性，便会评估当事人是否有自杀意念或自杀未遂史，如发现有自杀危险，便会转介给全科医生作进一步评估。

根据全科医生风险评估和临床判断，如果患者被认为是高危患者，就会被转介到最近的医院。对于不合作的病例，全科医生会根据事先准备的工作流程指导处理。对于低风险个体，由全科医生根据初级卫生保健中精神障碍管理指南启动管理。如果任何阶段需要专家会诊，患者都会被转介给当地的精神科医生。

所有自杀患者都被推荐给城市卫生中心的临床心理学家。如果患者已被转介到医院或精神科医生，在接受其他治疗模块的同时，还将接受电话随访、心理教育和/或简短的心理干预。在另一个层面上，自杀未遂后入院的病人也会在出院后被转介到卫生中心，进入上述流程。

此外，还制定了支持幸存者(因自杀失去亲人)的随访服务套餐，并将培训临床心理学家提供这项事后干预服务。提供这些服务的能力建设是以所有服务提供者的强制性职前培训和在职强化培训为基础的。卫生和医学教育部的国家自杀预防方案有六个战略目标。该方案自 2005 年起正式运作，并在得到国内和国际顾问的反馈后于 2018 年扩大规模。

实施过程中的提示

表 14.早期识别、评估、管理和随访所有受自杀行为影响的人的建议

问题	建议
自杀预防不是公共卫生的优先事项	• 与政策制定者一起倡导自杀预防，并提高社区的相关意识。从其他部门(例如教育部门)寻找倡导者，并加强倡导小组，使其成为社区自杀预防的领导者。 •提供证据证明自杀预防的有效性和成本效益。
可用的资源有限	• 与地区和国家政策制定者合作，重新分配预算。 • 使用级联培训模式(培训讲师)最大限度地增加受过培训的工作人员的数量，这些工作人员随后可以培训其他人并分享知识和技能。促进自助小组和幸存者团体等社区资源的发展。
在管理自杀风险方面信心/知识不足	• 确保充分培训有关发现自杀风险时如何进行下一步行动(管理即时风险和转诊至护理机构)。 • 为管理和照护制定明确的政策和循序渐进的指导，并确保这些政策和指导便于个体参考
难以接触处于危险中的个体	• 扩大提高意识和能力建设的范围，以覆盖能够接触那些难接触社区的一系列部门。 • 确保对综合卫生医疗工作人员(如全科医生、社区卫生工作者)和其他领域的工作人员(如警察、教师)进行培训，以识别有风险的人

附录 1. 自杀预防相关部门和利益攸关方

政府部门：

- 卫生部；
- 农业部、教育部、司法部、劳工/就业部、媒体部、少数民族事务部、计划和发展部、社会事务/福利部、交通部、青年部、国防部；
- 政治家、议员或众议院；
- 地方政府、地方决策者；
- 决策者和意见领袖

利益攸关方(个体和组织)：

- **所有人**
- 有过自杀经历的人；
- 精神卫生服务用户组织；
- 精神和综合医疗工作者、健康促进官员、卫生行政当局、药物使用问题服务、社会工作者、社区发展服务；
- 教师、教育工作者、青年工作者、学校、青年俱乐部和中心；
- 警察、消防员、救护人员/护理人员；
- 为老年人服务的人、护理提供者、养老院、日间护理中心；
- 宗教、信仰或精神领袖、组织、社区礼拜/集会场所；
- 传统治疗师或社区长辈；
- 媒体(印刷、电视和电影、网络、社交媒体)、记者、新闻协会；
- 基于性别的暴力相关服务（机构）、儿童保护服务；
- 性取向和性别认同团体；
- 与自杀风险或工具有关的零售商，如药剂师、调酒师、酒类零售商
- 工作场所、工会、专业协会、职业卫生部门、商界领袖；
- 在失业机构、就业中心、社会福利服务机构工作的人；
- 军队；
- 精神卫生住院部和监狱的安全服务部门；
- 金融服务、追债服务、养老金服务；
- 非政府组织，包括关心福利和福祉或为弱势群体提供服务的国际团体或慈善机构；

- 科学界、学术专家；
- 名人和有影响力的人；
- 指南中列出的许多其他组织。

附录 2. 其他国家的更多例子

情况分析

专栏 44. 澳大利亚：数据分析和探索系统

阻碍澳大利亚自杀预防工作的一个主要挑战是，缺乏关于这一问题规模和程度的细节。黑狗研究所与澳大利亚国立大学和 SAS(一家软件公司)合作，持续开发数据分析和探索系统以了解这个问题，并帮助当地社区制定更有针对性、更有证据支持的自杀预防举措。该系统目前作为黑狗研究所 Lifespan 试验的一部分进正在开展工作。

该系统的组成部分包括：

自杀数据分析报告(SDARs)

当地审查机构用以监测自杀趋势，识别易自杀的高危群体，并为当地降低自杀风险策略的制定和实施提供信息。这些报告提供了特定区域的信息，对将研究结果转化为实际效果具有重要意义。

地理空间分析

审计和情报系统能可视化数据源并显示空间分布的重要性。将地理空间数据可视化有助于描述当地自杀死亡的集中区域。该分析能让决策者更好地考虑社会和经济的优势与劣势、服务的可得性和特定的热点位置等因素。

限制自杀手段

限制自杀手段是减少自杀的最有效策略之一。该系统有助于确定是否有自杀方法及其可及性的模式，以及地理空间分布变化。这些有助于提供有针对性的限制手段区域策略，并根据当地需求确定具体的限制自杀手段行动和干预措施。

资源图集

LifeSpan 资源图集是一种在线互动资源，研究人员和政策制定者可以使用它来创建地图和分析。该图集有助于回答有关自杀预防的问题，并改善相关协调工作。它允许用户探索社区特征并共享信息。

由 8 名数据官员、地理学家和博士后组成的团队负责设计和设置数据平台，向基层数据管理者申请数据采集，并制定数据管理程序。维护系统的运行和产生上述规

定的产出至少需要两名全职数据官员，一名数据经理，和一名相当于全职地理学家的人。

目前，该系统旨在为新南威尔士州（澳大利亚的主要州之一）提供非常具体的信息。然而，它也提供了国家层面的自杀死亡数据。一个主要的终极目标是将自伤数据扩大到全国范围。然而，实现这一目标需要更多的资源（至少另外三名数据官员和一名地理学家）以具备适当的能力来应对数据采集和使用的伦理要求，并承担以合作的方式将多个数据源纳入系统所需的复杂的数据管理工作。

专栏 45. 伊拉克：全国自杀研究

2015 年至 2016 年间，在国际研究者（Abbas 等，2018）的合作下，伊拉克卫生部精神卫生办公室发起了一项针对自杀的全国研究。内政部协助将数据收集表格分发到该研究涵盖的 13 个省的警察局。警察人员填写了 2015 年至 2016 年期间其管辖范围内被裁定为自杀的个体死亡的相关表格，并对司法记录中数据缺失的家庭进行随访。数据收集表包括人口统计学变量、自杀方法、医疗检查、心理健康，自杀未遂史和潜在的死因。该结果被用于确定人群和亚群体的自杀率（例如年龄和性别）、常见的自杀方式，以及与自杀死亡有关的医疗、心理健康、自杀和诱发因素的概况。还在不同的人口群体之间进行了比较，以确定高危人群。从实施第一次全国性研究中汲取的经验教训，为制定伊拉克全国自杀登记册的计划提供了依据。其中包括提高数据质量——在本研究中依赖于可能导致认识或报告不足的司法和家庭报告——以及纳入额外的专业知识（例如流行病学家和法医专家）来为设计和数据收集提供信息。该研究还表明，在伊拉克未来的自杀预防工作中，需要对枪支和煤油（与自焚有关）实施工具限制。

专栏 46. 阿拉伯叙利亚共和国：情况分析

旷日持久的危机对叙利亚西北部(NW)居民生活的影响，包括新冠肺炎疫情的影响，引起了多个领域对自杀预防的关注。精神健康和心理社会支持(MHPSS)服务记录表明，与 2020 年 1 月至 3 月相比，2020 年 4 月至 6 月期间的自杀未遂案例增加了 57.7%。在同一时期，记者的社交媒体报道称，自杀死亡人数有所增加。然而，现有的卫生信息系统中没有记录死亡率数据，这反映了叙利亚西北部的自杀和自伤监管所面临的巨大挑战。

WHO 的加齐安泰普中心在跨机构常任委员会 MHPSS 专题工作组的支持下，意识到解决叙利亚西北部自杀行为的迫切需要。专题工作组成立了一个由六名成员组成的自杀预防特设工作组，他们一致认为需要进行情况分析，以便为预防计划提供信息并提供有助于提出募资请求的证据。这是工作组制定的“自杀问卷”的开始。调查的目的是更好地了解过去 12 个月内叙利亚西北部的自杀情况，从而确定截至 2020 年第四季度在叙利亚西北部采取的自杀预防行动。问卷包括 36 个问题，这些问题都与卫生工作者在过去六个月内与自杀身亡或未遂自杀/自伤的人打交道的经历有关。问题包括提供者从事自杀预防工作的能力和技能。评估心理健康和心理社会需求和资源工具包中的问题也被翻译并根据叙利亚西北部的情况进行调整（WHO 和 UNHCR，2012）。出于后勤原因，数字调查方法被认为是收集必要数据的最可行方法。使用 KoBo Toolbox[63]——一个免费的数字数据收集开源工具——进行收集。该工具为用户提供了图形生成等功能，非常适合在人道主义环境中使用。

2020 年 9 月，向叙利亚西北部的共计 534 名受访者（包括 206 名女性）发出了参加调查的邀请，其中包括初级卫生保健和医院的医生、MHPSS 工作人员（心理社会支持工作者、精神科医生和心理学家）、基于性别的暴力和儿童保护工作人员以及护理人员。在新冠肺炎疫情期间的六个月里，受访者报告了 1748 起自杀未遂和 246 起自杀死亡事件。其中 76%的自杀死亡者及 86.6%的自杀未遂者是国内流离失所者（IDPs）。在自杀未遂者中，42.2%为 21-30 岁，25%为 31-40 岁，18.1%为 16-20 岁。在自杀的方法中，据报道，21.4%的人在家中服用农药，16%使用刀子，11.5%的人跳楼。自杀的诱发因素有：关系/婚姻问题（26.3%）、经济问题（23.7%）、与父母关系问题（12.7%）和失业（10.4%）。调查结果还指出了在卫生部门讨论自杀存在的阻碍，社区中的阻碍——特别是最担心讨论自杀的利益攸关方（如宗教领袖）——以及评估受访者目前有限的知识和能力建设要求。在对调查进行分析后提出了一系列关键建议，这些将成为叙利亚西北部自杀预防工作的重点领域。

[63] 参见: https://www.kobotoolbox.org/ (2021.02.18 获取)

专栏 47. 巴西：自下而上的多部门合作示例

在过去 10 年里，圣保罗州农村一个中等城镇（人口 14 万）的自杀率是全国的两倍。2016 年 3 月，应社工在当地媒体的公开邀请，约 100 人在当地行业联合会办公室会面。这些人有不同的背景：医护工作者、教育工作者、宗教领袖、家庭主妇、警察和消防员、政治家和准政治家、媒体专业人士、热线专员、司法人员、当地名人等。

这个小镇过去和现在都拥有非常丰富的精神卫生资源——既有公立的（一所设有精神病病房的大学医院、一家精神病医院、一家专门治疗药物滥用障碍患者的医院、数个门诊服务和日间中心），也有私人的（全国人口中第三大比例的精神科医生和几个为物质滥用障碍患者提供治疗的社区）。然而，公共服务在行政和财政上依赖于各种联邦、州和市政机构，但它们之间的协调有限。利益攸关方会议决定利用自己的资源并充当志愿者，建立一个生命保护网络(LPN)。

与会人员选举了一个四人协调委员会，并成立了八个工作组，即：1）支持者（由没有专业精神卫生背景但积极参与社交媒体的人组成，通常是家庭主妇、商业雇员和学生）； 2）精神支持者（宗教领袖）； 3) 评估（卫生工作者，主要是心理学家）；4) 精神卫生专业人员（心理学家、治疗师、精神科医生）； 5) 教育者（教师、学校校长）； 6) 地方当局[市长、市议员、相关县委书记(健康教育、社会福利、文化、体育和公共安全)，精神卫生服务部主任]； 7) 当地媒体； 8) 大使（专门受 LPN 培训的年轻人）。

想成为 LPN 志愿者成员需要接受协调员根据 WHO mhGAP 干预指南中的自伤/自杀模块进行的 4 小时培训。鉴于志愿者的广泛支持，LPN 现在有一份专业和看护志愿者的等候名单。每月定期举行的督导会议向所有志愿者开放，讨论他们感兴趣的问题，特别是如何处理更复杂的案件。在第一次会议两周后和所有特定志愿者团体的培训课程结束不久后，该网络开始运作。

人们可以通过网站 www.precisodeajuda.org（葡萄牙语：“我需要帮助”）为自己或他们发现的处于困境中的人联系 LPN。初级医护工作者和紧急护理服务者也可以联系 LPN。LPN 志愿者开展了一些活动：一些具有支持性质（社会和精神支持），心

理健康促进（生活技能培训）或临床照护（综合社区疗法、卫生部推荐的补充疗法、心理治疗、随访和转诊、事后干预），有些涉及全面促进和预防（例如在社区层面提高认识）。LPN 的所有成员都充当志愿者，临时费用（会议室租金、印刷材料等）由当地商业和工业承担。

虽然 LPN 的具体影响有待衡量，但一个显著的结果是，之前几种医疗保健服务之间缺乏协调的问题已经得到解决。通过 LPN，现在由有能力和训练有素的人员及时提供早期识别和护理，并在需要时在不同程度的护理之间平稳快速地过渡。

专栏 48. 加拿大：多部门合作

联邦协调委员会

加拿大政府支持采取合作方式预防自杀，以改善信息共享并促进合作。2016 年底，政府发布了《联邦自杀预防框架》，它建立了策略目标和指导原则，以协调联邦自杀预防工作。为帮助改善联邦政府部门之间的合作，加拿大公共卫生署担任联邦自杀预防协调委员会主席，该委员会每季度召开一次会议。该委员会由在精神卫生和自杀预防领域工作的联邦部门和机构的代表组成，包括来自卫生部、原住民服务部、经济发展部、交通部和统计部的代表。每季度举行一次的委员会会议重点是确定整个联邦政府的自杀预防优先事项和发展，尽可能协调工作；分享有关自杀预防的信息和专业知识，包括与自杀相关的监管； 并支持编写两年期进度报告。

全国自杀预防合作

全国自杀预防合作组织（National Collaborative for Suicide Prevention）是一个由个人（例如自杀未遂和自杀丧亲的幸存者）和组织组成的泛加拿大组织，为自杀预防、干预和事后预防行为提供领导力、资源和信息共享。组织成立于 2012 年 6 月，合作组织成员促进心理健康，建立心理弹性，培养希望，并努力减少自杀对所有加拿大人的影响。在执行委员会、三个工作组（通信工作组、国家战略行动计划工作组和数据与研究工作组）和一个秘书处的支持下，合作组织的工作得到支持并实现了结构化。合作组织的目的是：促进组织之间关于生命促进的讨论和知识交流，心理健康和自杀预防；成为成员之间合作的催化剂；倡导并提供一个可以就与自杀预防有关的问题发表集体意见的论坛。

专栏 49. 俄罗斯联邦：酒精政策和立法

1990 年代俄罗斯联邦酒类市场的私有化和放松管制可能促成了酒精相关问题的恶化，酒精消费大大增加了发病率和死亡率[64]。2004 年，政府开始了加强酒精控制政策的进程（Levintova，2007），随后对酒类产品生产和交易量管理法规进行了一系列修订。之后对与酒精相关的其他法律法规进行了修订。2007 年至 2016 年，人均酒精消费总量（已记录和未记录）减少了 3.5 升纯酒精。2005-2015 年期间，酒精使用造成的死亡率也有所下降，尤其是男性。在被诊断患有酒精依赖和其他酒精相关疾病的患者中也观察到类似的模式，同时成人总死亡率也显著降低——所有这些都可能是整体酒精消费量呈下降趋势的结果。许多实施政策都是以证据为基础的，符合 WHO 减少有害性酒精使用的全球战略（WHO，2010），并逐步实施。因此，限制酒精政策可能有助于降低俄罗斯联邦的自杀率。

专栏 50. 苏格兰：亲历自杀行为者参与的意义

亲历小组(LEP)，于 2019 年 9 月由苏格兰国家自杀预防领导小组(NSPLG)成立，支持苏格兰实施自杀预防行动计划[65]。LEP 由来自不同专业和社会背景的 14 人组成，他们响应全国号召，作为忠诚的志愿者奉献了自己的时间。每个小组成员都与自杀有着不同的联系：有些人是因自杀而丧亲的幸存者，有些人过去曾有过自杀或曾照顾有自杀念头和行为的家人或朋友。苏格兰心理健康协会的一名协调员以尊重和敏感的态度支持着他们。全国有 100 多个有过受自杀影响的亲身经历的人组成更广泛的网络，也通过一系列活动参与支持 NSPLG 的工作。

根据从 LEP 的建立及其与 NSPLG 的合作伙伴关系中汲取的经验，已经确定了 13 个关键要素，这些要素已被证明是让有自杀经历的人有意义并真实地参与苏格兰自杀预防行动计划的关键要素：

- **招募志愿者——**志愿服务有固定的标准（建议自上次自杀未遂或自杀丧亲以来的两年时间作为间隔）。这样可以更安全地参与并减少潜在的痛苦。
- **招聘指定的亲身经历协调员——**管理志愿者，与利益攸关方联络，并实施安全保护方案。

[64] 俄罗斯联邦的人际暴力和酒精：政策简报。哥本哈根：WHO 欧洲区域办事处；2006(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/98804/E88757.pdf, 2021.01.28 获取)

[65] 自杀预防行动计划：每个生命都很重要。爱丁堡：苏格兰政府(https://www.gov.scot/publications/scotlands-suicide-prevention-actionplan-life-matters/, 2021.01.28 获取)

• **指导小组——**建立伙伴关系指导小组以支持协调员的角色并通过学习更新政策和流程。

• **就结果达成一致并设定期望——**确保志愿者了解计划结果，并确保活动与这些结果一致；管理志愿者的期望。

• **参与和审议的方法——**促进尊重和诚实的对话有助于培养志愿者之间的开放性并建立信任关系。分享生活经验的非争议性方法有助于志愿者优先考虑关键问题并确定需要改进的领域。

• **参与计划和准备——**专业人员和志愿者协调员应在每次会议之前就会议计划达成一致并与志愿者分享信息。

• **收集反馈——**部署一系列收集反馈的方式（书面、音频、焦点小组、数字的），最大限度地增加参与机会。事实证明，较小的团体是志愿者分享个人故事的最有效也最安全的方式。

• **良性反馈循环——**与志愿者达成一致的反馈机制可以避免象征性的参与。它确保那些采取行动的人留下证据表明他们使用了相关知识，同时也向志愿者保证他们的观点被认真对待。

» 与志愿者就进展情况举行随访会议。

» 商定反馈时间表。

» 将视图合并到报告中。

» 确保志愿者参加项目会议。

• **每个节点都寻求许可——**在共享个人信息时，必须时时征询志愿者的意见。他们对信息共享拥有最终决定权；并检查许可是否应延续。

• **情感支持和保障——**必须在参与会议之前、期间和之后定期检查志愿者的心理健康。

• **志愿者协议和手册——**应明确记录志愿者的职责和界限，包括危机支持服务清单。

• **分享生活经历后的任务报告——**开放的渠道是必不可少的：分享可以宣泄，但也可能引发痛苦的回忆和负面的情绪。

• **自我照顾——**这不是可选的额外服务。健康会话至关重要。

专栏 51. 澳大利亚：海洋玫瑰——一个为亲历过自杀行为者设立的组织

海洋玫瑰（Roses in the Ocean）成立于 2008 年，是一个自杀亲历者(LE)组织，工作人员由有过自杀经历的人组成。该组织成立之际，澳大利亚的社区里还几乎没人谈论自杀。很明显，政府和服务部门需要听取那些有自杀相关经历的人的意见。它已经发展成为澳大利亚自杀预防重大改革的推动力，在澳大利亚，真正融合了生活经验的专业知识目前被认为是所有自杀预防举措的核心。

海洋玫瑰将自杀的生活经历定义为有过自杀念头，自杀未遂，照顾过处于自杀危机中的人，或因自杀而失去亲人。

海洋玫瑰的工作始于通过在社区和企业活动中讲述亲身经历的故事来提高社区意识，但人们很快就意识到它的作用远远超过一个演讲者。该组织很快为自杀亲历者开发了一套能力建设讲习班，以培养他们的技能和知识，以便在当地社区和国家层面以各种方式参与自杀预防。

在社区基层开展自杀亲历者人力资源建设，与在战略层面和自杀预防部门和政府合作同等重要。亲历者在主动发布、影响和加强自杀预防的服务设计、提供、研究、政策等各个方面都能发挥作用。

前八年没有提供资金，因此海洋玫瑰依靠志愿者的慷慨解囊取得了进展，其中一些是全职志愿者。一些自杀预防的关键人物开始倾听并利用他们的信誉为政府打开正确的大门并帮助该组织发展。 由于该组织是一个有董事会的注册慈善机构，它为政府提供了一种载体去支持自杀亲历者的声音——开始是试探性的，然后是更有目的的。

2018 年，澳大利亚政府通过国家自杀预防领导和支持计划为海洋玫瑰提供了核心资金。海洋玫瑰的其余收入来自各种初级卫生网络、州和区域卫生部门以及行业组织的有偿服务工作和特定项目资金。

如今，海洋玫瑰参与了广泛的活动，例如为有自杀经历者举办能力建设讲习班，国家 LE 指导服务，将有自杀经历者融入组织中，社区实践，培训当地人 LE 相关知识、提供“救生员”培训来培养能力，发展新兴的专业自杀预防同伴人力资源，并与研究机构和研究人员合作，将 LE 纳入研究并指导新的研究重点。

建立 LE 人力资源的步骤是：

- 建立在世界各地已经学习和发展的基础之上。
- 支持并资助建立一个 LE 组织，该组织将：
  - » 与热衷于讲述和影响自杀预防的有自杀经历者互动；
  - » 投资培养 LE 能力以分享人们的故事和见解，并有目的地参与地方和国家自杀预防的对话和工作；
  - » 发展具有不同 LE 观点和技能的 LE 网络；
  - » 努力在组织和政府之间嵌入 LE 框架，并且在各级治理中都有 LE 代表；
  - » 确定重点关注的地方和国家领域。

专栏 52. 美国：整合全国、全政府的方法

“赋能退伍军人并结束全国性自杀悲剧的总统路线图”(PREVENTS)[66]旨在建立一个为期三年的解决美国自杀问题的行动计划，重点关注退伍军人群体。PREVENTS 的创建得到了白宫以及美国每个联邦机构的高级领导的全力支持。为了领导这项工作，一位来自非政府部门、拥有 15 年创建和协调大型多部门联盟经验的心理健康专家被选为执行主任。 PREVENTS 能够利用白宫的召集力来确保政府以及非政府领导人充分参与建设和实施过程。此外，执行董事将那些致力于为这项工作增加资源和专业知识的组织和伙伴纳入该计划。重要的政治支持、政府和非政府合作伙伴提供的充足资源、以及推动该计划的强力和有效的领导力，这三者的结合是 PREVENTS 取得成功的关键。

来自 15 个联邦机构的 150 多名专家在为期一年的过程中合作开发了 PREVENTS。它制定了一项以公共卫生为基础的自杀预防计划，其目标是文化变革、无缝获得照护、互联的研究生态系统、稳定的社区参与。该行动计划强调全民、全政府的方法，将继续利用由 1000 多个合作伙伴和拥护者组成的网络，包括国家 PREVENTS 大使，以及代表联邦/州/地方/部落政府、有信仰的团体、非营利组织、学术界的组织，退伍军人和军事服务组织，以及其他私营行业合作伙伴合作，发挥出最佳实践，改善健康和预防自杀。PREVENTS 路线图的实施持续了多年，其中包括重点关注计划评估，以衡量每个战略领域及整体方法的有效性和影响。

PREVENTS 创建了一个综合模型，以争取所有美国人共同努力：

[66] 华盛顿（DC）：美国退伍军人事务部（https://www.va.gov/prevents/，2021.1.28 获取）。

• 通过大力开展公共卫生运动改变关于心理健康的讨论，并促进对与自杀相关的潜在危险和保护因素的理解（REACH[67]公共卫生运动于 2020 年启动，为人们提供了工具和资源，以便在痛苦时通过 REACH 寻求帮助，并帮助其他正在苦苦挣扎的人）；

• 设计和支持有效的计划，为退伍军人提供他们需要的服务；

• 建立一个鼓励数据共享与合作的研究生态系统；

• 跨联邦机构工作，培养一种文化并制定支持个人在整个生命周期中茁壮成长的举措。

PREVENTS 通过以下方式提升了全国关于心理健康和自杀的讨论：1) 采用国家公共卫生方法，告诉所有美国人关于心理健康和自杀预防的重要性； 2) 在政府内外建立强大的合作伙伴联盟； 3) 促进全国首个自杀预防工作的合作和协调。

专栏 53. 包括东部耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土：自杀预防和管理

自 2016 年以来，约旦河西岸的年度警方报告显示，与往年相比，自杀率和自杀未遂率有所上升[68]。在加沙地带，数据显示自杀率还在继续上升，尤其是年轻人和青少年[69]。然而，关于在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上自杀和自杀未遂的数据很少，大多数案例都被掩盖、忽视、无记录或根本未被发现。许多因素导致在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上缺乏关于自杀的研究和登记，包括社会污名、宗教误解（圣地/罪恶），以及当地主要执行者之间缺乏能力和协调。在此背景下，2017 年各方共同努力在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土建立全国自杀预防委员会。该委员会由卫生部牵头，在 WHO 的技术支持下，提出了第一个 2021-2026 年国家自杀预防策略。该策略标志着委员会成员和包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上的主要利益攸关方，包括政府执行者、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）、WHO、国家非政府组织和国际非政府组织 Médecins du Monde (MdM-CH) 关于解决包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上自杀问题的承诺。该委员会还致力于促进数据收集，为不同部门制定行动计划，并鼓励利益攸关方为计划的实施分配资金。尽管如此，该项目仍因面临许多挑战而停滞不前，这些挑战包括：精神卫生专业人员数量有限；主要提供者（卫生、教育和保护）之间在服务

[67] 华盛顿（DC）：美国退伍军人事务部（https://www.reach.gov/，2021.1.28 获取）。
[68] 参见：https://www.palpolice.ps/annual-statistics，2021.1.28 获取。
[69] 日内瓦：联合国人道主义事务协调厅，救济网（https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/brink-gaza-syouth-are-turning-suicide-amid-growing, 2021.1.28 获取）。

提供、检测和预防方面存在差距；缺乏准确的数据；以及污名化。因此，委员会的成员通过国家多媒体运动努力提高对该主题的重视，并与媒体合作进行负责任的报道。此外，MdM-CH 在 2019 年对西岸自杀未遂的危险因素进行了一项研究[70]。根据这项研究的结果，与卫生部合作制定了急诊室和社区精神卫生中心的培训计划。WHO 和其他执行者还开展了 WHO mhGAP 培训，以应对关键专业人员缺乏解决自杀问题的能力。宗教领袖和军事医疗服务提供者也将接受自杀预防的培训。尽管最近做出了这些努力，但仍有必要继续在不同部门之间合作，以在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土上建立一个宣传、发现、转诊和治疗自杀的综合系统。

[70] 纳沙泰尔：世界医学会（(https://medecinsdumonde.ch/wp-content/uploads/2020/03/2019_MdM-Suisse_Attempted-Suicide-Patients-Risk-FactorsSuicide-Prevention-Strategies-in-Palestine_Study_EN-002.pdf，2021.1.28 访问）

提高意识和宣传

专栏 54. 加拿大：提高认识和宣传

由于 15 年来没有有效的自杀预防策略，魁北克自杀预防协会(AQPS)看到了倡导新策略的机会，并开始建立一个团体来动员利益攸关方实现这一目标。该团体于 2019 年成立，由大约 35 个组织组成，汇集了对自杀预防和精神卫生感兴趣的组织，以说服魁北克政府采取专门的国家自杀预防策略。在动员计划的指导下，该小组旨在创造一种目标感和归属感。该集体通过发表公开信、要求与政府官员会面、在世界自杀预防日举行新闻发布会、请求普通民众的支持、举办信息会议和在整个魁北克进行磋商等方式获得了支持。在 10 个月内计划并实施了具体行动。2019 年 10 月，魁北克卫生部长宣布制定全面的全国自杀预防策略。

专栏 55. 世界精神卫生日和世界自杀预防日

2019 年 10 月 10 日的世界精神卫生日（WMHD）的主题是自杀预防。由于在一个月前正好是世界自杀预防日，因此倡议开展为期一个月的活动，用了七个月的时间准备世界自杀预防日这一天的活动。目的是强调自杀问题相关的全球关键数据——每 40 秒就有一人死于自杀。动画视频针对关键的守门人人群而开发（例如教师[71]、应急响应人员[72]、雇主[73]、卫生工作者[74]），并制作了额外的资源讲义[75]。塔琳达.彬宁顿是 320 改变方向[76]的联合创始人和自杀亲历者，也是自杀预防的倡导者。她参与了多项社交媒体活动，例如推特直播和三个脸书直播，以及在 Instagram 发布内容。她的活动还包括与 WHO 总干事会面并联合呼吁参与该倡议。一个由政府间和非政府组织组成的处理自杀预防和心理健康的核心计划小组成立，以协调 WHO、国际自杀预防协会(IASP)、世界心理健康联合会和全球心理健康联合组织之间的宣传活动（40 秒的

[71] 参见：https://www.youtube.com/watch?v=Le7n6i0dpTI&feature=emb_logo，2021.1.28 获取。
[72] 参见：https://www.youtube.com/watch?v=ECarCNxgM-4&feature=emb_logo，2021.1.28 获取。
[73] 参见：https://www.youtube.com/watch?v=C0iQLEwABpc&feature=emb_logo，2021.1.28 获取。
[74] 参见：https://www.youtube.com/watch?v=Fy7n8SfwS_A&feature=emb_logo，2021.1.28 获取。
[75] 急救人员、卫生工作者、教师、监狱官员、媒体专业人员和雇主可以做些什么来帮助自杀预防。日内瓦：WHO（https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts，2021.1.28 获取。
[76] 参见：https://www.changedirection.org/320-changes-direction/，2021.1.28 获取）。

行动）[77]。这使得参与其中的知名全球影响者进一步传播该活动的关键信息。通过网站访问资源的次数、社交媒体上的浏览次数和分享次数以及网站访问者的地理位置来监测该计划的成败。自活动启动后，网站访问量增加了 160%。

能力建设

专栏 56. 澳大利亚：适合 LGBTIQ 团体循证的守门人培训

澳大利亚政府勾略出一系列自杀预防政策方面的改革，这些改革将强有力的国家领导与承认地区差异的系统区域治理相结合。其中的关键是国家自杀预防试验(NSPT)，这是一项重大举措，涉及 11 个初级卫生网络(PHNs)，它们采用基于系统的方法为有自杀风险的人提供帮助。澳大利亚政府建立了 PHNs 以提高医疗服务的效率和有效性，减少碎片化照护，并改善每个人尤其是最弱势群体的健康结果。

墨尔本西北部初级卫生网络(NWMPHN)是维多利亚州唯一参与 NSPT 的初级卫生网络。NWMPHN 是维多利亚州六个初级卫生网络中最大的一个，汇集约 160 万人口，覆盖高度多样化的社区，从墨尔本的中央商务区和内城到北部快速发展的郊区，及西部初级卫生网络相关部门所在地。

NWMPHN 国家自杀预防试验关注的易感群体是女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、双性别和酷儿 (LGBTIQ) 群体。澳大利亚 LGBTIQ 群体的心理健康状况较差且自杀倾向严重，有很大一部分居住在墨尔本西北部地区。国家自杀预防试验的活动由 LGBTIQ 工作组领导，该工作组由来自 LGBTIQ 组织和倡导机构的代表、更大的 LGBTIQ 群体的代表以及为自杀亲历发声者组成。工作组确定了教育和培训的必要性，为 LGBTIQ 专家服务部门和其他与 LGBTIQ 群体合作的人进行能力建设，以掌握评估 LGBTIQ 群体心理健康状况和识别自杀警告信号的技能。

澳大利亚生命工作组（LivingWorks Australia）已开始与工作组和 LGBTIQ 群体的代表合作，调整现有的循证自杀预防和干预方法（ASIST 和 safeTALK）。所有 LivingWorks 计划都经过了大规模的设计和开发，并定期更新，以反映有关自杀预防的最新证据和最佳实践知识。培训计划是通过与 LGBTIQ 利益攸关方进行大规模的共同设计来改进的，旨在使工作组感到安全和包容，并对 LGBTIQ 群体和更广泛的

[77] 2019 年第 77 届世界精神卫生日宣传单。日内瓦：WHO（https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-40secondsweb.pdf?sfvrsn=5ba643c_2，2021.1.28 获取）。

主流部门进行能力建设，以提高他们应对需要自杀干预支持的 LGBTIQ 群体成员的技能。

截至 2020 年底，共有 206 人接受过 LGBTIQ ASIST 和 safeTalk 培训，包括 33 名 LGBTIQ 群体领袖，由 10 名 ASIST 培训师和 7 名 safeTALK 培训师通过培训讲师模式进行培训。其中一些讲者现已注册为 ASIST 和 safeTALK 培训师，他们将在 2021 年 6 月试验结束后继续提供适应性培训并支持项目的持续运行。

此外，与 LGBTIQ 群体一起开发了为 LGBTIQ 群体提供 LivingWorks 教育培训的基本知识指南，作为 ASIST 培训师手册的补充，以及为培训师提供 LGBTIQ 版 ASIST 培训时使用的指南，指导现有培训师如何确保他们的培训对 LGBTIQ 社区内的参与者来说始终安全和包容。

该项目的影响包括：

- 创建服务于 LGBTIQ 群体的包容和安全的培训工作组；
- 加强 LGBTIQ 组织的能力以成为安全防治自杀的社区。

一位参与工作组的人说：“让所有处于工作组中的酷儿感觉非常安全，是培训中最棒的部分之一。”

专栏 57. 加拿大：社区守门人培训项目

不列颠哥伦比亚省的社区守门人自杀预防培训项目旨在建立一个受过正式培训人员的网络，这些人员可以识别和支持表现出痛苦或有自杀危险的人，并让他们找到可利用的服务。确定参与该项目的 9466 名个人守门人的依据是他们经常与社区成员直接接触、处于负责和受信任的位置、了解社区资源以及乐于鼓励他人寻求帮助。这些守门人接受了 LivingWorks 的 safeTALK 或 ASIST 培训，该项目为该省增加了 40 多名培训师。该项目始于 2015 年，由不列颠哥伦比亚省卫生部一次性投资 300 万加元给加拿大心理健康协会不列颠哥伦比亚省分部。虽然项目于 2018 年结束，但基于守门人培训项目的工作在未来将得到可持续发展基金的支持，用于开展研讨会的费用。

专栏 58. 伊朗伊斯兰共和国：能力建设

为了管理包括自杀行为在内的社会危害，在隶属于科学技术研究部的所有 136 所大学/学院中建立了一个咨询中心，提供咨询和心理健康服务。“大学自杀预防综合

计划”成立于 2007 年，最近一次更新于 2018 年。该计划包括能力建设的两个要素。一个是在每所大学/学院中设置一个行政部门，包括大学/学院的主要官员，开展自杀未遂等危机的干预。第二个要素是由接受了 BTE 计划培训的学生建立一个支持委员会——心理健康助手学生协会（SAMHH）。B 代表 Bepors（询问），T 代表 Targhib（鼓励），E 代表 Erja（参考）。SAMHH 已经举办了多次研讨会来培训和再培训成员，每年都会举行一次全国会议。

专栏 59. 伊拉克：IOM 心理健康和社会心理支持计划：自杀预防和应对

根据国际移民组织(IOM)的《紧急情况和流离失所中以社区为基础的心理健康和社会心理支持手册》，在确定预防和应对自杀在相关社区中的优先级后，国际移民组织伊拉克心理健康和社会心理支持(MHPSS)计划已将该主题作为其社区稳定部的战略活动之一。

2019 年，IOM 伊拉克在不同营地和营地外组织了焦点小组讨论，以了解社区对流离失所者自杀相关的认知和其危险因素。国际移民组织确定，有关危险和保护因素的信息以及对社区支持的认识不足，是导致对自杀的耻辱感和缺乏适当反应的关键问题。IOM 的 MHPSS 团队针对不同的受众，例如卫生保健工作者、在学校工作的人、因自杀而丧亲的家庭开发了一个提高意识的项目。制定了一份面向公众的介绍自杀常见误解的传单。这些传单有英语、阿拉伯语、索拉尼语和巴迪尼库尔德语版本。电子版已分发给伊拉克 MHPSS 技术工作组的所有成员，国际移民组织向巴格达和埃尔比勒的卫生部以及许多要求印刷版的地方和国际非政府组织捐赠了数千份。

IOM 伊拉克的 MHPSS 团队意识到，训练有素的、可以参与到社区提高对敏感话题意识的人力资源稀缺。在 2019 年至 2020 年期间，国际移民组织组织了一系列培训师的培训课程，为参与者（例如医护工作者、在校工作人员、因自杀而丧亲的家庭）提供提高社区意识所需的知识和技能，用于了解自杀并克服围绕该主题的污名和敏感性的障碍。来自伊拉克不同地区 10 个省的约 200 人接受了培训，掌握了如何向他们的社区介绍危险因素、保护因素、自杀预防的可能方法，以及如何在社区层面向个人和家庭提供简短的支持直到获得专业帮助。国际移民组织支持参与者在境内流离失所者营地、非正规住区和村庄组织提高社区意识的课程。这些课程是“在职”监督和指导的机会，以确保培训的有效性。这也是一个良好的机会来试发行提高意识材料并增加用户友好性。

专栏 60. 荷兰：评估守门人培训

荷兰守门人培训计划是由两名培训师提供的四小时课程。该计划包括对自杀、危险因素和预防的介绍，反复进行角色扮演以练习技能，并加深对如何帮助人们获得额外支持的理解。113 自杀组织评估了 2015 年至 2016 年间培训的有效性，在此期间，526 人进行了 42 次培训课程（Terpstra 等，2018）。守门人学员来自医疗保健、教育和社会经济部门，以及安全和司法、交通、教堂和清真寺。守门人培训证明了在增加自杀预防的知识和技能以及建立守门人信心方面的有效性。有趣的是，这对于被守门人识别处于危险中的人数或转介人数没有影响。

专栏 61. 土耳其：自杀预防

土耳其的国家自杀预防工作根据国家心理健康行动计划（2011-2023）进行了重组。2019 年，土耳其所有省份都被要求确定一个联络点来领导自杀预防工作。这些专业人员接受了卫生部的培训，培训内容包括制定当地自杀预防计划、干预后转诊和快速进行精神科评估的重要性。由于地区之间的风险可能不同，这些训练有素的专业人员被要求确定他们所在省的地区自杀危险因素，以及有自杀念头或自杀未遂者的支持资源。为此，在各省卫生局的协调下成立了“省自杀预防委员会”。委员会成员是省安全局、省宪兵司令部、省家庭、劳动和社会服务局、省穆夫提办公室、省国民教育局、市政府和非政府组织的代表。这些委员会与所有可以在该领域提供服务的单位合作。到 2018 年底，各省都制定了自己的自杀预防省级行动计划，以有效实施行动。行动每年向卫生部报告两次。行动示例包括 2015 年根据土耳其情况改编的 WHO 自杀预防资源手册。这些手册用于在全国范围内对五个不同专业进行能力建设培训：家庭医生、初级保健护士、教师、记者和监狱雇员。自 2015 年以来，已为 155426 人提供了培训。卫生部已成功确保执法界、学术界、非政府组织和卫生专业人员之间的相互合作。这包括为在该国自杀预防方面发挥主要作用的警务人员开展培训。

专栏 62. 澳大利亚：昆士兰自杀登记系统

昆士兰自杀登记系统(QSR)是一个自杀死亡率监测系统，由格里菲斯大学澳大利亚自杀研究与预防研究所(AISRAP)的研究人员管理，并由昆士兰心理健康委员会资助。它涉及与昆士兰警察局(QPS)和昆士兰验尸官法庭(CCQ)的密切合作。由于需要实时信息，AISRAP 于 2011 年建立了临时 QSR(iQSR)。

QSR 包含自 1990 年以来关于昆士兰州自杀事件的大量信息。信息有四个主要来源，包括警方对验尸官的死亡报告、尸检、毒理学报告和验尸官的调查结果。AISRAP 从 QPS 和 CCQ 收到警察的表格。AISRAP 访问国家验尸信息系统(NCIS)以获取其他报告。昆士兰出生、死亡和婚姻登记处会额外进行反复核对。每例疑似自杀都分两个阶段录入，即 iQSR 和 QSR。在第一阶段，将所有疑似自杀的警察报告电子信息添加到 iQSR，每周三次。在第二阶段，尸检调查结束，案件在 NCIS 中结案，然后从 iQSR 转移到 QSR，输入来自不同报告的附加信息，并由训练有素的研究助理进行复核。

QSR 工作人员使用决策树将所有死亡事件编码为四种可能性之一：不太可能、可能、很可能或无可置疑。仅报告属于可能或无可置疑类别的死亡[78]。QSR 是主要数据来源，为昆士兰州的自杀预防策略和其他自杀预防活动和评估提供信息。

专栏 63. 巴西：故意伤害监测

巴西故意伤害监测的成功关键是提高意识、资金投入和将自杀预防纳入卫生议程，该监测被整合到该国的暴力和事故监测系统中。2006 年，巴西卫生部发布了一项部级法令（Portaria 1.876，2006.08），制定了在各级（联邦、州、市）实施的自杀预防国家指导方针。从 2006 年到 2008 年，卫生部实施了暴力和事故监测系统，包括由紧急和专业服务机构（例如妇女中心或暴力咨询中心）强制报告自伤情况，以及为在州和市级实施监测系统提供资金。2011 年，卫生部发布了一项新的部级法令，规定所有卫生服务（不仅是专业服务和紧急服务）都必须对自伤和自杀未遂进行监测报告，并规定了卫生专业人员和卫生服务的标准和责任。2014 年，卫生部发布了一

[78] https://www.griffith.edu.au/griffith-health/australian-institute-suicide-research-prevention/research/qsr, 2021.01.28 获取。

项新的部级法令，要求市政当局的卫生秘书在 24 小时内报告自杀未遂。2019 年通过了一项法律，制定了《防止自伤和自杀国家政策》，由联邦政府与各州、联邦区和市政府合作实施。

专栏 64. 中美洲和多米尼加共和国：自杀行为观察站

中美洲和多米尼加共和国自杀行为观察站[79]由 PAHO 和中美洲和多米尼加共和国卫生部长理事会(COMISCA)共同发起，于 2013 年成立，用于收集中美洲和多米尼加共和国自杀行为的数据和信息。观察站的目的是获得官方的和及时的流行病学信息，以便对各国的自杀行为进行定性，加强国家在制定和设计循证计划和方案方面的决策能力。

拉丁美洲的死亡率数据被描述为“无规律的”，尤其是与欧洲国家的数据相比（Bertolote & Fleischmann，2002）。其他问题中最重要的问题之一是报告数据的延迟（泛美卫生组织，2014）。另一方面，不同国家之间的自杀率存在显著差异，甚至在一些发展水平相似的国家之间也存在显著差异（Liu，2009），这可能反映了方法问题（PAHO，2016）。为加强精神卫生信息系统建设，改进基于可靠流行病学数据的问题分析和决策，提出了建立自杀行为小区域观察站的建议。开始仅收集自杀死亡的数据，但最近扩展到涵盖有关自杀未遂的数据。

专栏 65. 巴基斯坦：阿迦汗大学医院自伤监测系统(AKUH-SHMS)

阿迦汗大学医院(AKUH)是一所拥有 700 个床位的私立教学医院，位于卡拉奇的中心，卡拉奇是巴基斯坦最大城市，人口约 2200 万。医院使用医院信息和管理系统(HIMS)来保存病历。医院每年平均收治 60-65 起自伤案例。自伤案例包括三种：已入院的严重自杀未遂；在急诊室治疗后出院的；以及那些违反医疗建议(LAMA)离开的人。所有自伤患者都被转介给随时待命的精神科团队进行评估，详细信息记录在患者的医疗记录中。定期为医疗、精神科和护理人员举办有关评估和记录自伤案件重要信息的培训讲习班。

1990 年，精神科部门为报告给 AKUH 的自伤案件设立了登记处。从医疗记录中检索数据，并记录在专门设计的数据提取表上（包括社会人口学的详细信息、使用的

[79] 中美洲一体化和多米尼加共和国健康管理、信息和交流虚拟办公室（http://comisca.net/content/observatorio_suicidio，2021.1.28 获取）。

方法、使用物质类型、可及性、意图、自伤原因、精神科诊断、处置和随访），并且由研究人员输入计算机数据库。每季度举行一次会议以审查数据库的数据和质量。目前，大部分信息都是以电子方式获取的。

尽管 AKUH 收到的发生在卡拉奇的自伤案例数量相对较少，但该数据库提供了有关自伤模式的有用信息，并已出版了若干文献。巴基斯坦关于自伤的一些开创性研究结果是基于 AKUH 自伤管理系统(SHMS)数据库生成的信息（例如年轻已婚女性的自伤率高、再自伤或再自杀率低、大量使用苯二氮卓类药物、在自伤行为中使用少量镇痛剂）（Khan & Reza, 1998; Syed & Kahn, 2008; Zakiullah et al., 2008）。

有助于监测系统可持续发展的关键因素包括部门领导、专业研究人员的存在、医疗和护理人员的培训和教育、文件和病历保存、信息系统和质量控制。

AKUH-SHMS 仍然是该国唯一的自伤数据库，并提供了一个基于常规收集数据的低成本、低资源密集型卫生设施系统的极好例子。这对于缺乏国家自伤监测系统的低收入和中等收入国家非常有用。

专栏 66. 孟加拉国：农药禁令

2000 年，孟加拉国的农药登记处取消了所有 WHO I 毒性类农药的农业用途，包括剧毒有机磷杀虫剂敌敌畏、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷酰胺。在接下来的几年中，农药导致的自杀率急剧下降，从 1996 年的 10 万分之 6.3 下降到 2014 年的 10 万分之 2.2——下降了 65.1%（Chowdhury 等，2018）。由于在此期间上吊死亡率保持不变，这些禁令的确减少了自杀的总数。同时，没有证据表明这些有针对性的杀虫剂禁令对农业产量有任何影响。

专栏 67. 加拿大：社区限制自杀手段的可及性

在萨斯喀彻温省（加拿大）北部的拉荣格社区，作为限制使用致命自杀方法的策略，方法安全工作组正在整个社区实施药物安全规划。拉荣格的社区协调员正在采用多层次的方法，改编一本关于创建更安全家庭的小册子，其中包含当地的支持信息；与当地药剂师合作提供虚拟教育计划；向被确定为自杀风险较高的人分发药物保险箱。药物保险箱由社区主要卫生服务点的临床医生分发给曾有过自杀念头或自杀未遂的人的照护者。在拉荣格获得的经验教训直接被萨斯喀彻温省其他地区的社区借鉴，当地协调员正在调整该计划以适应他们自己社区的需求。展望未来，拉荣格的方法安全工作组已将酒精的使用确定为未来探索方法安全规划的另一个重要领域。

专栏 68. 斐济：限制杀虫剂的获取

斐济政府自 2020 年 1 月 1 日起禁止进口、销售和使用两种农药（百草枯和吡虫啉）。百草枯与斐济的多起自杀事件有关，并已证明对环境有害。政府的支持对于农药禁令的通过至关重要。已通过以下方式向政府强调禁令的重要性： 1) 结合农业部、卫生部和有机农业非政府组织的多部门方法，展示禁令背后的原因； 2) 利用媒体对自杀的报道来展示禁令的重要性。

卫生部全国自杀预防委员会请愿限制使用杀虫剂以预防自杀。由于对环境（动物、供水、人类健康）的负面影响，农业部建议禁用杀虫剂。与此同时，由于百草枯和吡虫啉对土地的负面影响，非政府组织和社区在斐济提倡使用天然农药进行有机农业。保护土地和环境是斐济特性和文化不可或缺的一部分。

利用媒体报道来宣传自杀预防的重要性以及禁止使用杀虫剂。媒体报道包括由全国自杀预防委员会领导的自杀预防运动、社区高层成员在社交媒体上分享的关于自杀的个人故事，以及警方关于自杀的数据。

经常使用这些杀虫剂的农民和杀虫剂的销售商都对禁令持反对态度。为了克服这些障碍，农业部和参与有机农业的非政府组织直接与农民和销售商联系，向他们宣传这些农药的危害以及在哪里可以找到替代品。提高意识的重点是宣传对气候变化和健康的好处。为了让农民和销售商有时间适应即将发生的变化，在禁令实施前六个月就开始了宣传工作。

政府禁令自上而下的性质意味着禁令得到遵守，这体现了政府支持的重要性。

“我们不能孤军奋战、孤立无援”，斐济卫生部国家自杀预防项目官员 Tavaita Sorovanalagi Matakaca 女士。

全国自杀预防委员会利用这一机会促进心理健康，以此作为自杀预防的一种方式（例如提高社区对管理压力的认识）。政府正在监测该国的自杀人数，以评估杀虫剂禁令的影响。2020 年 1 月至 5 月的初步数据表明，与 2019 年相比，自杀率略有下降。

专栏 69. 马来西亚：禁用百草枯

农药中毒是马来西亚第二大自杀方式。该国于 2020 年 1 月 1 日开始全面禁用百草枯。百草枯是一种除草剂，因为没有解毒剂或有效治疗方法，人服用后致死率极高。到 2015 年，百草枯中毒率比 2006 年增加了 5.5 倍，2002 年最初决定禁止百草枯后，2006 年又允许限制性使用（Leong 等，2018）。在实际中实施百草枯禁令以减少致命农药的获取需要解决农业社区中获取百草枯可持续替代品的问题。

专栏 70. 斯洛文尼亚：改编和实施负责任的媒体自杀报道指南

2010 年，国家公共卫生研究所、UP 研究所 Andrej Marusic（斯洛文尼亚自杀研究中心）、国家生活质量组织(OZARA)和斯洛文尼亚自杀预防协会合作，根据斯洛文尼亚的情况调整了媒体指南并付诸实施。WHO 出版物《自杀预防：媒体专业人员的资源》被翻译成斯洛文尼亚语。工作组与媒体专业人士合作，收集有关文本有用性和清晰度的反馈，并在进一步调整指南时纳入他们的反馈。工作组在世界自杀预防日（2010）著名媒体专业人士出席的一次发布会上，发布了斯洛文尼亚媒体指南的最终版本。由国家公共卫生研究所协助发行。斯洛文尼亚各卫生区的媒体代表受邀成为该指南的倡导者，并鼓励当地媒体代表参加 90 分钟的培训研讨会。这些研讨会旨在促进自杀预防专家和媒体之间的意见交流，而不是采用对抗或说教的方法。指南的复印件也被发送给媒体协会，要求将指南分发给其成员。

一项研究旨在评估干预措施（指南和研讨会）是否能有效提高自杀报道的质量（Roškar 等，2017）。通过媒体监测机构在两个为期 12 个月的时间段内检索印刷版媒体文章——一个是在引入指南之前，另一个是在其传播之后。根据指南评估文章是否含有负责任报道的关键性指标。研究发现，干预后与自杀相关的文章总数显著减少。对于指南中 11 条建议中的 6 条，在预期方向上观察到了显著变化。然而，关于自杀的方法和地点的报道没有显著减少，使用不恰当的摄影材料的情况有所增加。研究人员建议，在未来指南推广时，将分别与编辑、记者和摄影师进行研讨以获得建议，满足他们的不同需求和工作要求。

早期识别、评估、管理和随访任何受自杀行为的影响的人

专栏 71. 加拿大：自杀丧亲团体支持促进者网络

在全国范围内开展延伸工作后，加拿大自杀预防协会(CASP)发现，人们越来越有兴趣发起一场动态运动，专门解决自杀丧亲和自杀后的担忧、需求和诉求。作为回应，该协会发起了一个自杀丧亲和事后干预联盟来解决这一问题。该联盟的主要优先事项之一是为自杀丧亲团体支持促进者建立一个网络。该网络的目的是将提供丧亲支持的人们聚集在一起，以交流知识、证实和推广最佳实践、减少孤立并增加支持。该网络的主要作用是： 1) 为提供自杀丧亲服务的促进者创造相互支持，分享经验（挑战和庆祝活动）和最佳实践方法的空间； 2) 减少加拿大城市和农村地区个别促进者之间的隔离。该网络将于 2021 年初正式启动。

专栏 72. 伊朗伊斯兰共和国：对自杀未遂者的随访

为配合伊朗伊斯兰共和国的自杀预防计划的规划和实施，2017 年在该国的一个西部省份——自杀率高的西阿塞拜疆(WA)启动了一项新计划。该计划基于： 1) 急诊科的自杀未遂者登记； 2) 通过电话随访自杀未遂者并提供简短的咨询来提供持续的护理； 3) 鼓励自杀未遂者使用心理健康服务。第一步，成立了一个由警察局、福利组织、伊朗总统办公室妇女部代表、法律医学部、伊朗非政府组织自杀预防科学协会(IRSSP)，电视管理组织和教育部门组成的指导委员会。该委员会由卫生部精神卫生局领导。IRSSP 负责在 WA 医科大学的健康和治疗系开展该项目。在省一级，指导委员会每个参与者都有其代表性并在 WA 有自己的职责。每个参与者各负其责，通过电视组织提高公众意识，通过福利组织提供社会支持，并为自杀者提供安全保障。法律医学部提供自杀案例的实时数据，教育部转介自伤行为和筛查呈阳性的学生，健康和治疗部在该计划中发挥主要作用——登记案例，随访并提供简短的辅导。该计划实施一年后，自杀率已从每 10 万人中的 7.9 人降至 6.1 人（23%）。IRSSP 协调各合作者的工作以确保该计划的成功实施方面发挥了关键作用。

专栏 73. 波兰：作为新兴职业的康复助理

有心理健康问题和自杀倾向的人常常觉得他们是孤独的，是家庭和社区的负担，而且他们永远无法康复。康复助理给了他们希望。康复助理是具有自杀经历的专家，他们为在自杀未遂后有心理健康危机的人提供支持，无论他们是否有自杀念头。他们

还支持因自杀而丧亲者——以他们自己在心理健康问题和/或自杀行为、治疗、痊愈和康复方面的经历为引导。康复助理从事兼职工作或在非政府组织担任志愿者。根据2019年卫生部长条例，康复助理可以作为波兰精神卫生中心核心活动的一部分。康复助理在住院和门诊诊所、社区治疗团队、患者自助俱乐部和家庭支持小组工作，由康复助理协会(Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia)组织。康复助理的作用是支持患者的康复过程。在心理健康中心，康复助理参加会议和心理治疗课程，为患者提供支持，并在社区访问期间陪伴他们（包括作为流动的外延团队的一部分）。他们还赋予人们解决问题、日常运作任务、获得社会支持以及以自己的兴趣和热情支持他人的能力。康复助理是同行的榜样，可以在康复过程中加强治愈的感觉。他们接受过培训，可以在需要时将患者转诊给专家。康复助理还通过提供培训、进行公开演讲和媒体采访、与雇主接触、参与研究项目以及代表心理健康服务向决策者进行宣传，在提高意识和宣传方面发挥作用。

附录 3. “LIVE LIFE”指标框架

“LIVE LIFE”的愿景是一个这样的世界：自杀不再是导致死亡的主要原因，有自杀意念或自杀未遂者可以放心地向有能力并且乐于助人者寻求帮助。

为了帮助实现这一愿景，本指南中包含了“LIVE LIFE”的指标框架模板。指标框架是一种可帮助规划者制定必要行动的工具，以实现“LIVE LIFE”的预期结果和目标。该框架可用于监控实现目标的进度。

组成部分可以描述为：

- **目标**：项目旨在实现的总体目标（或要解决的总体问题）。
- **结局**：项目要实现目标所需的变化（有时称为目的或结果）。
- **输出**：对**结局**有贡献的具体可交付成果。输出（有时称为可交付成果）可能需要许多单独的行动（活动）。在此框架中，“输出”行留空白，因为这些内容在很大程度上取决于上下文。但是，在“输出”下包含的任务示例则可在“LIVE LIFE”实施指南的相应章节中的“怎么做”小节下找到。
- **指标**：定量或定性数据，用于评估**结局**和**目标**是否已实现或发生变化的程度。
- **假设**：实现目标、结局和输出所必需的条件，可能超出项目的控制范围。

表 15. “LIVE LIFE”目标、结局和指标

目标：	**目标指标：**	**验证方式：**	**目标假设：**
a） 国家自杀死亡率降低： 15%（2019-2023）； 或三分之一（2015-2030）。 b) 改进了对自伤就诊的监测系统。	a） 国家自杀率变化百分比， 2019-2023； 国家自杀率变化百分比 2015-2030。 b) 建立全国自伤监测系统。	a） 每年国家自杀率 b) 全国自伤监测系统	a） 国家拥有基于以下方面的高质量自杀数据： • 国家民事登记和生命统计（CRVS）系统； • 国家自杀监测系统； • 卫生部/统计部记录。 b) 各国有能力开发、实施和维持以基于医院的自伤监测系统。

结局 1： 情况分析可为国家规划自杀预防提供信息。	**结局 1 指标：** • 实施、处理和发布国家、地区或特定情况（例如学校）的情况分析。	**结局 1 假设：** • 具备开发、执行和分析必要数据的技术能力。
输出 1： **[适应国情]：包括将导致实现单个或多个结局的输出。可包含的输出示例可以在“LIVE LIFE”**实施指南的每个相应章节中的**“怎么做”**小节下找到。 **输出 1 指标：** **输出**应该有相应的指标。		
结局 2： 自杀预防需要整合相关的非卫生部门，建立和加强治理和多部门合作（包括政府部门和社区中的其他利益攸关方）。	**结局 2 指标：** • 引进全职专注于国家自杀预防的人员并发放薪水。 • 任命一个国家自杀预防多部门指导委员会（治理小组）[80]。 • 任命一个国家或地方自杀预防工作组来规划和实施“LIVE LIFE”支柱和干预措施。 • 全国自杀预防指导委员会（治理小组）与“LIVE LIFE”支柱和干预措施相关的会议次数。 • 每个国家或地方自杀预防工作组的关于“LIVE LIFE”支柱和干预措施的会议次数。 • 向问责机制报告合作活动的[频率]。	**结局 2 假设：** •在自杀预防方面发挥领导作用需要建立工作关系。 • 需要在政府内部（或来自社区）进行宣传，以促进工作组的建立；政府认可在自杀预防方面的政治意愿。
输出 2： [适应国情]：包括将导致实现单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的**“怎么做”**小节下找到。 **输出 2 指标：** **输出**应该有相应的指标。		

[80] 指导委员会和工作组成员的建议包含在多部门合作中

结局 3：	**结局 3 指标：**	**结局 3 假设：**
提高民众、高危人群以及国家代表或其他部门负责人对自杀、自伤和心理健康的认识和态度（并减少污名）。提高对自伤和心理健康可用服务的认识。	• 提高意识活动所覆盖的人群和高危群体的百分比或数量。 • 人群和高危群体的知识、态度、求助行为的变化[比例]。 • 面临风险寻求医疗服务的人数变化（心理健康状况、自杀念头或自伤）。	• 在提高意识的同时或之前应确保有可利用的服务。 • 卫生信息记录可以按可能与风险相对应的社会人口数据（例如年龄、种族）进行分类。 • 卫生信息记录可利用。
输出 3： [适应国情]：包括将导致实现单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 3 指标：** **输出**应该有相应的指标。		
结局 4：	**结局 4 指标：**	**结局 4 假设：**
加强卫生部门和社区的自杀预防能力建设。	• 接受过自伤/自杀早期识别、评估、管理和随访培训（每 6 个月或每年一次）的非专业卫生工作者和专业精神卫生工作者的百分比或数量（或卫生人员所在的初级卫生、二级卫生和社区设施或服务的百分比或数量）。 • 经过评估，在自伤/自杀的早期识别、评估、管理和随访（每 6 个月或每年一次）方面有胜任力的非专业卫生工作者和专业精神卫生工作者的人数。 • 卫生工作者接受岗前培训课程，包括早期识别、评估、管理和后续培训的百分比。 • 接受过社区自杀风险早期识别、转诊和随访培训的社区守门人的百分比或数量（每年）。	• 由有技术胜任力的人员开展能力培训，着眼于自伤/自杀识别、评估、管理和随访。
输出 4： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 4 指标：** **输出**应该有相应的指标。		

结局 5：	**结局 5 指标：**	**结局 5 假设：**
明确预算并确保资金用于实施“LIVE LIFE”支柱和干预措施。	• 用于自杀预防活动的年度预算拨款增加的百分比。 • 每年有系统地分配用于自杀预防的国家预算。	• 愿意资助自杀预防。
输出 5： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 5 指标：** **输出**应该有相应的指标。		
结局 6：	**结局 6 指标：**	**结局 6 假设：**
建立或加强自杀/自伤监测系统。 监控和评估有助于提高国家和项目特定的关于“LIVE LIFE”实施的知识。	• 该国建立了民事登记和生命统计（CRVS）系统。 • 参与自伤监测系统的医院或地区的百分比或数量。 • 自杀死亡和自伤数据至少按年龄、性别和方式分类。 • 正常运行的监测系统提供的数据质量很高。 • 监控每年报告的“LIVE LIFE”框架指标。 • 发布对“LIVE LIFE”实施的评估（在商定的时间段内）。	• 有实施这项工作的技术能力；在环境中可用的卫生信息系统，并倡导使用卫生信息系统；与现有监测机制（例如传染病监测）整合的潜力。
输出 6： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 6 指标：** **输出**应该有相应的指标。		
结果 7：	**结果 7 指标：**	**结果 7 假设：**
通过限制获得自杀手段可及性来减少自杀死亡。	• 自杀死亡的变化百分比（减少）（根据国家情况而定）。 • 为限制获得自杀手段可及性而实施的措施数量。	• 各国建立了监测系统，其中包括监测自杀/自伤方式。 • 各国建立了与自杀方式相关的登记、许可或监测机制。 • 该方法能够被限制（例如农药、枪支）。
输出 7： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 7 指标：** **输出**应该有相应的指标。		

结果 8：	**成果 8 指标：**	**结果 8 假设：**
媒体负责任地报道自杀事件。	• 不符合国家标准或指南的报道数量或百分比。 •提及寻求帮助资源的报道数量或百分比。 •提及应对生活压力或自杀念头的故事，以及如何获得帮助的报道的数量或百分比。	• 各国建立了媒体监测机制。 • 各国与媒体合作，制定了负责任的报道和问责机制的指导方针或报告标准。
输出 8： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的**“怎么做”**小节下找到。 **输出 8 指标：** **输出**应该有相应的指标。		
结果 9：	**结果 9 指标：**	**结果 9 假设：**
通过普遍提供社会心理干预措施来培养年轻人的生活技能。	• 向青少年提供循证的社会心理干预措施的学校或教育机构的数量或百分比。 • 15-19 岁青少年或年轻人自杀死亡的变化百分比。	• 与国家教育课程规划者进行协调。 • 有能力在教育环境中提供通用的社会心理干预。 • 各国拥有包括社会人口学数据（年龄）和死因在内的 CRVS 或监测系统。 • 各国拥有在教育环境中收集数据的机制（包括建立社会情感生活技能基线数据）。
输出 9： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的**“怎么做”**小节下找到。 **输出 9 指标：** **输出**应该有相应的指标。		

结果 10：	**结果 10 指标：**	**结果 10 假设：**
卫生和社区环境（包括公共、私人和非政府或民间社会服务，可能包括教育等其他部门）能够胜任对自杀未遂者和自杀风险进行早期识别、评估、管理和随访。	• 有能力识别的自伤案例数量。 • 被合理评估过的自伤案例数量。 • 妥善管理的自伤案例数量。 • 有效的转诊路径数量，包括： 1) 记录在案，2) 传播，3) 由卫生和社区工作者应用。 • 出现在初级卫生、二级卫生或社区设施或服务中并在社区进行随访的自伤病例的百分比。 • 向失去亲人的人提供及时的事后支持的百分比。	• 能力评估由自伤/自杀识别、评估、管理和随访方面技术能力强的人员开发和提供。 • 各国拥有卫生信息系统，其中包括不同卫生和社区系统之间的一致性记录保存，例如卫生和社会护理记录。 • 卫生工作者能够在出院后进行随访。 •在健康档案中记录自伤——即对自伤进行监测。
输出 10： [适应国情]：包括能够实现的单个或多个**结局输出**。输出示例可以在“LIVE LIFE”实施指南的每个相应章节中的“**怎么做**”小节下找到。 **输出 10 指标：** **输出**应该有相应的指标。		

附录 4. 资源

情况分析

WHO 资源

• Assessing mental health and psychosocial needs and resources: toolkit for humanitarian settings. Geneva: World Health Organization; 2012 (https://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/, accessed 1 January 2021).

• Assessment Instrument for Mental Health Systems (AIMS). Geneva: World Health Organization; 2005 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70771/WHO_MSD_MER_05.2_eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

• mhGAP Intervention Guide, version 2.0. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252071/WHO-MSD-MER-16.6-eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/publications-detail/preventing-suicide-a-global-imperative, accessed 1 January 2021).

• Rajan D. Situation analysis of the health sector. In: Schmets G, Rajan D, Kadandale S (editors). Strategizing national health in the 21st century: a handbook (Chapter 3). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250221/9789241549745-chapter3-eng.pdf?sequence=19, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Arensman E, Khan M (2017). Evaluation of National Suicide Prevention and Suicide Registration Programs in Iran.Tehran: World Health Organization and Ministry of Health and Medical Education; 2017 (https://iums.ac.ir/files/irssp/files/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D9%88_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf, accessed 1 January 2021).

• Data infrastructure: recommendations for state suicide prevention. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center; 2019 (http://www.sprc.org/sites/default/files/StateInfrastructureDataSupplement.pdf, accessed 1 January 2021).

• Instructions for Conducting a SWOT Analysis. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Centre (https://www.sprc.org/sites/default/files/migrate/library/swot_0.pdf, accessed 1 January 2021).

• KoBo Toolbox. Cambridge (MA): Harvard Humanitarian Initiative (https://www.kobotoolbox.org/, accessed on 1 January 2021).

• Malakouti SK. Evaluation of Iran's National Suicide Prevention Program: the lessons learnt. Journal of Suicide Prevention (Iran).2019;1:35 40 (http://isssp.ir/article-1-29-en.pdf, accessed 1 January 2021).

• Shekhani SS, Perveen S, Akbar K, Bachani S, Khan MM. Suicide and deliberate self-harm in Pakistan: a scoping review. BMC Psychiatry. 2018;18(1):44.
• Torok M, Konings P, Batterham PJ, Christensen H. Spatial clustering of fatal, and non-fatal, suicide in New South Wales,Australia: implications for evidence-based prevention. BMC psychiatry. 2017;17(1):339 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28985736/, accessed 1 January 2021).
• Torok M, Shand F, Phillips M, Meteoro N, Martin D, Larsen M. Data-informed targets for suicide prevention: a small-area analysis of high-risk suicide regions in Australia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2019;54(10):1209–18 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31041467/, accessed 1 January 2021).
• Veto violence. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (https://vetoviolence.cdc.gov/apps/violenceprevention-practice/#!/, accessed 1 January 2021).

多部门合作

WHO 资源

• NCD map tool. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/ncd-multisectoral-plantool/home.htmlhttps://apps.who.int/ncd-multisectoral-plantool/home.html, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252071/WHO-MSD-MER-16.6-eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).
• Stronger collaboration, better health: the global action plan for health lives and well-being for all. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan, accessed 1 January 2021).
• Global status report on noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44579/9789240686458_eng.pdf;jsessionid=42BA85A08E2769E793007275AB084122?sequence=1,accessed 1 January 2021).
• Noncommunicable diseases prevention and control in the South-eastern Europe Health Network: an analysis of intersectoral collaboration. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012 (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/164457/e96502.pdf, accessed 1 January 2021).
• Indigenous experiences in wellness and suicide prevention. Washington (DC); Pan American Health Organization; 2018 (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34578/PAHONMH17037-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y, accessed 1 January 2021).
• Promoting mental health in indigenous populations: experiences from countries. Washington (DC): Pan American Health Organization; 2016 (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28415/9789275118979_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 1 January 2021).

外部资源

• #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (http://www.mentalhealthcommission.ca/English/initiatives/11884/308conversations, accessed 1 January 2021).
• 10th Anniversary Report. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention; 2020 (https://theactionalliance.org/10th-anniversary-report, accessed 1 January 2021).
• Action against suicide. Erbil: Azhee (http://azhee.org/, accessed 1 January 2021).
• Community engagement toolkit. Burnaby: The Social Planning and Research Council of British Columbia; 2013 (https://www.sparc.bc.ca/wp-content/uploads/2017/03/community-engagement-toolkit.pdf, accessed 1 January 2021).
• Engaging people with lived experience. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/keyssuccess/lived-experience, accessed 1 January 2021).
• Framework for the engagement of people with a lived experience in program implementation and research. Randwick, Australia:Black Dog Institute (https://www.blackdoginstitute.org.au/about/who-we-are/lived-experience/, accessed 1 January 2021).
• Lived experience. Zero Suicide Institute (https://zerosuicide.edc.org/toolkit-taxonomy/lived-experience, accessed 1 January 2021).
• Partner engagement tool. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Centre (http://www.sprc.org/statewidepartnerships, accessed 1 January 2021).
• Partnerships and collaboration. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Centre (https://www.sprc.org/keys-success/partnerships-collaboration, accessed 1 January 2021).
• PREVENTS: The President's Roadmap to Empower Veterans and End a National Tragedy of Suicide. Washington (DC):Department of Veteran Affairs; 2020 (https://www.va.gov/PREVENTS/docs/PRE-007-The-PREVENTS-Roadmap-1-2_508.pdf,accessed 1 January 2021).
• Prompts and suggestions for speaking with local leaders on suicide prevention. London: Department of Health; 2012 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/137641/Prompts-for-local-leaders-on-suicide-prevention.pdf, accessed 1 January 2021).
• RISING SUN: Reducing the Incidence of Suicide in Indigenous Groups – Strengths United through Networks-Toolkit for Resilience. Geneva & London: Mental Health Innovation Network; 2014 (https://www.mhinnovation.net/collaborations/rising-sun/rising-sun-toolkit, accessed 1 January 2021).

提高意识和宣传

WHO 资源

• Campaign materials: animations. What emergency workers, health workers, teachers and employers can do to help prevent suicide. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-animations,accessed 1 January 2021).
• Campaign materials: handouts. What emergency workers, health workers, teachers, prison officers, media professionals and employers can do to help prevent suicide. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts, accessed 1 January 2021).

• Depression: Let's talk: handouts. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/suicide-04-handouts-depression.pdf?sfvrsn=7c5eaac4_2;https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/life-worth-living-03-handouts-depression.pdf?sfvrsn=a4fb25b5_2, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779, accessed 1 January 2021).
• World Mental Health Day. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/previous_WMHDs/en/, accessed 1 January 2021).
• World Suicide Prevention Day. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.mentalhealthcommission.ca/English/308conversations, accessed 1 January, 2021).
• #SpottheSigns Campaign. Warrington, United Kingdom (https://www.papyrus-uk.org/spotthesigns/, accessed 1 January 2021).
• #Youcantalk Campaign. Newcastle, Australia (https://lifeinmind.org.au/youcantalk, accessed 1 January 2021).
• 320 Changes Direction Campaign, USA (https://www.changedirection.org/320-changes-direction/, accessed 1 January 2021).
• Be The 1 To Campaign, USA (https://www.bethe1to.com/, accessed 1 January 2021).
• Befrienders Kenya (http://www.befrienderskenya.org/, accessed 1 January 2021).
• Busting Myths Campaign. Beyond Blue. Melbourne, Australia (https://www.beyondblue.org.au/, accessed 1 January 2021).
• Roses in the ocean. Brisbane (https://rosesintheocean.com.au/, accessed 1 January 2021).
• Special Working Group on the Decriminalisation of Suicide. International Association for Suicide Prevention (https://www.iasp.info/decriminalisation.php, accessed 1 January 2021).
• State suicide prevention plans and leadership guidance. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Centre; 2020 (https://www.sprc.org/sites/default/files/State%20Suicide%20Prevention%20Plans%20and%20Leadership%20Guidance.pdf?utm_source=Weekly+Spark+6%2F5%2F20&utm_campaign=Weekly+Spark+June+5%2C+2020&utm_medium=email,accessed 1 January 2021).
• Tennessee Suicide Prevention Network. Nashville (TN) (https://www.tspn.org/about/, accessed 1 January 2021).
• Transforming communities: key elements for the implementation of comprehensive community-based suicide prevention.Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention; 2016 (https://theactionalliance.org/sites/default/files/transformingcommunitiespaper.pdf, accessed 1 January 2021).
• The Way Forward: Pathways to hope, recovery, and wellness with insights from lived experience. Oklahoma City (OK): SuicidePrevention Resource Center; 2014 (https://www.sprc.org/resources-programs/way-forward-pathways-hope-recovery-andwellness-insights-lived-experience, accessed 1 January 2021).

• Lived experience. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention (https://theactionalliance.org/our-strategy/lived-experience, accessed 1 January 2021).
• Check Your Mates Campaign, Australia (www.checkyourmates.com.au/, accessed 1 January 2021).
• Creating an effective suicide prevention awareness campaign. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/roh_safe_activities_eng.pdf, accessed 1 January 2021).
• Framework for successful messaging (http://suicidepreventionmessaging.org/, accessed 1 January 2021).
• Inside My Mind Campaign, Australia (www.insidemymind.org.au, accessed 1 January 2021).
• Campaign resources, International Association for Suicide Prevention (https://iasp.info/resources/World_Suicide_Prevention_Day/2019/, accessed 1 January 2021).
• Messaging resources. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention (https://theactionalliance.org/messaging, accessed 1 January 2021).
• REACH. Washington (DC): U.S. Department of Veterans Affairs (www.REACH.gov, accessed 1 January 2021).
• R U O K? Day, Australia (www.ruok.org.au/join-r-u-ok-day, accessed 1 January 2021).
• Safer conversations about suicide on social media. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-05/safe_suicide_conversations_social_media_eng.pdf, accessed 1 January 2021).
• See Me campaign. Glasgow, Scotland (https://www.seemescotland.org/, accessed 1 January 2021).
• Stichting 113, Netherlands (https://vimeo.com/291877756, accessed 1 January 2021).
• Storytelling for suicide prevention – checklist (information to support people with lived experience). National Suicide PreventionLifeline, USA (https://suicidepreventionlifeline.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeline-Storytelling-Checklist.pdf, accessed 1January 2021).
• Take5ToSaveLives. National Council for Suicide Prevention, USA (https://www.take5tosavelives.org/, accessed 1 January 2021).
• What can be done to decrease suicidal behaviour in Australia? White Paper. Randwick, Australia: Black Dog Institute (https://www.blackdoginstitute.org.au/suicide-prevention-white-paper/, accessed 1 January 2021).
• Wot Na Wot Kine Campaign. Perth: WA Primary Health Alliance, Australia (www.wapha.org.au/wot-na-wot-kine/, accessed 1 January 2021) .
• Yarns Heal Campaign, Australia (www.yarnsheal.com.au/, accessed 1 January 2021).
• ŽIV? ŽIV! [Alive? Alive!] Campaign. Koper: Slovene Centre for Suicide Research, Slovenia (http://zivziv.si/, accessed 1 January 2021).

能力建设

WHO 资源

• mhGAP Intervention Guide. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/, accessed 1 January 2021).
• mhGAP training manuals. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/,accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide resource series. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/en/, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252071/WHO-MSD-MER-16.6-eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Advanced training in suicide prevention. Newcastle, Australia: Life in Mind (https://lifeinmind.org.au/services/advanced-trainingin-suicide-prevention, accessed 1 January 2021).
• Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST). Calgary, Canada (https://www.livingworks.net/asist, accessed 1 January 2021).
• Choosing a suicide prevention gatekeeper training program: a comparison table. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/resources-programs/choosing-suicide-prevention-gatekeeper-training-programcomparison-table, accessed 1 January 2021).
• Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS), USA (https://cams-care.com/about-cams/, accessed 1 January 2021).
• Ireland Taxi Watch: Suicide prevention drive that saved 200 lives. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/news/ireland-taxi-watch-suicide-prevention-drive-saved-200-lives, accessed 1 January 2021).
• Lions Barber Collective, United Kingdom (https://www.thelionsbarbercollective.com/, accessed 1 January 2021).
• Logic model and guidance for how to create culturally and linguistically appropriate suicide prevention and intervention materials for ethnic and migrant minority groups. Boston (MA): Massachusetts Coalition for Suicide Prevention (https://www.masspreventssuicide.org/regional-coalitions/greater-boston, accessed 1 January 2021).
• Mates in Construction, Australia (https://mates.org.au/, accessed 1 January 2021).
• MindOut: LGBTIQ Mental Health & Suicide Prevention training and support, Australia (www.lgbtihealth.org.au/mindout, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide toolkit for high schools. Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) (https://youth.gov/feature-article/preventing-suicide-toolkit-high-schools, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a technical package of policy, programs, and practices. Atlanta (GA): Division of Violence Prevention, Centers for Disease Control and Prevention; 2017 (https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicideTechnicalPackage.pdf, accessed 1 January 2021).
• Question, Persuade, Refer Suicide Prevention Training Programme, USA (http://www.qprinstitute.com, accessed 1 January 2021).
• Ross V, Caton N, Gullestrup J, Kõlves K. A longitudinal assessment of two suicide prevention training programs for the construction industry. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020.17(3):803.
• safeTALK Programme, Australia (https://www.livingworks.com.au/programs/safetalk/, accessed 1 January 2021).

• Setting for prevention. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/settings, accessed 1 January 2021).

• Zero Suicide Alliance, London, United Kingdom (https://www.zerosuicidealliance.com/training, accessed 1 January 2021).

财政支持

WHO 资源

• Mental health financing. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/policy/services/essentialpackage1v4/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Chisholm D, Docrat S, Abdulmalik J, Alem A, Gureje O, Gurung D et al. Mental health financing challenges, opportunities and strategies in low- and middle-income countries: findings from the Emerald project. BJPsych Open. 2019;5(5):e68 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6688460/, accessed 1 January 2021).

• Leaving a legacy: recommendations for sustaining suicide prevention programs. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/sites/default/files/resource-program/Leaving%20a%20Legacy%20-%20Sustainability%20 Recommendations_0.pdf, accessed 1 January 2021).

• Mental health funding and the SDGs: What now and who pays? London: Overseas Development Institute; 2016 (https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/Mental.pdf, accessed 1 January 2021).

• Reframe: funding mental health. Mumbai: Mariwala Health Initiative; 2018 (https://mhi.org.in/media/insight_files/MHI_Progress_Report_DIGITAL.pdf, accessed 1 January 2021).

• Woelbert E, Lundell Smith K, White R, Kemmer D. Accounting for mental health research funding: developing a quantitative baseline of global investments. The Lancet Psychiatry. 2020;8(3):250–80 (https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30469-7/fulltext, accessed 1 January 2021).

监测

WHO 资源

• A resource for non-fatal suicidal behaviour case registration. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112852/9789241506717_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 1 January 2021).

• A resource for suicide case registration. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44757/9789241502665_eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

• Fatal injury surveillance in mortuaries and hospitals: a manual for practitioners. Geneva: World Health Organization;

2012(https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/surveillance/fatal_injury_surveillance/en/, accessed 1 January 2021).
• Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/attempts_surveillance_systems/en/, accessed 1 January 2021).
• STEPwise approach to surveillance (STEPS). Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/en/, accessed 1 January 2021).
• Verbal autopsy standards and instrument. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• 2012 National Strategy for Suicide Prevention: Goals and Objectives for Action: A report of the U.S. Surgeon General and of the National Action Alliance for Suicide Prevention. Chapter 4: Surveillance, research, and evaluation. Washington (DC): US Department of Health & Human Services (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109916/, accessed 1 January 2021).
• Breaking down barriers: using youth suicide-related data. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/resources-programs/breaking-down-barriers-using-youth-suicide-related-surveillance-data-state, accessed 1 January 2021)
• Cavanagh JT, Carson AJ, Sharpe M, Lawrie SM. Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review. Psychological medicine. 2003;33(3):395–405. (https://pdfs.semanticscholar.org/506c/b8389b67602f3f2b02d587c5fe61be304139.pdf,accessed 1 January 2021).
• Cwik MF, Barlow A, Goklish N, Larzelere-Hinton F, Tingey L, Craig M et al. Community-based surveillance and case management for suicide prevention: an American Indian tribally initiated system. Am J Public Health. 2014;104(S3):e18–23 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035881/, accessed 1 January 2021).
• Data infrastructure: Recommendations for State Suicide Prevention. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/sites/default/files/StateInfrastructureDataSupplement.pdf, accessed 1 January 2021).
• Kõlves K, Sisask M, Värnik P, Värnik A, De Leo D, editors. Advancing suicide research. Göttingen: Hogrefe; 2021.
• National Violent Death Reporting System. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/violenceprevention/datasources/nvdrs/index.html, accessed 1 January 2021).
• Suicide surveillance strategies for American Indian and Alaska Native Communities. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/resources-programs/suicide-surveillance-strategies-american-indian-alaska-nativecommunities, accessed 1 January 2021).
• Surveillance success stories. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/news-and-highlights?type=558&populations=All&settings=All&suicide_problem=All&plan_implement=All&strategies=All&state=All, accessed 1 January 2021).
• Thundiyil JG, Stober J, Besbelli N, Pronczuk J. Acute pesticide poisoning: a proposed classification tool. Bull World Health Organ. 2008;86:205–9.

• Värnik P, Sisask M, Värnik A, Laido Z, Meise U, Ibelshäuser A et al. (2010). Suicide registration in eight European countries: A qualitative analysis of procedures and practices. Forensic Science International. 2010;202(1–3):86–92.

监控和评估

WHO 资源

• Monitoring and evaluation of mental health policies and plans. Geneva: World Health Organization; 2007 (https://www.who.int/mental_health/policy/services/essentialpackage1v14/en/, accessed 1 January 2021).
• National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/national_strategies_2019/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• A framework for programme evaluation. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 1999 (https://www.cdc.gov/eval/framework/index.htm, accessed 1 January 2021).
• Challenges and recommendations for evaluating suicide prevention programs. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center; 2016 (http://www.sprc.org/resources-programs/challenges-and-recommendations-evaluating-suicideprevention-program, accessed 1 January 2021).
• Connecting for life. Ireland's National Strategy to Reduce Suicide 2015–020. Dublin: Department of Health (https://assets.gov.ie/15758/e6c74742547a48428e4640e3596a3d72.pdf, accessed 1 January 2021).
• Evaluation of media reporting in Trinidad and Tobago. Ministry of Health, Trinidad and Tobago (https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=monitoring-and-evaluation-of-media-reporting-suicide-in-trinidad-andtobago&Itemid=270&lang=es, accessed 1 January 2021).
• Evaluation of suicide prevention activities. Australian Healthcare Associates; 2014 (https://www1.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/suicide-prevention-activities-evaluation, accessed 1 January 2021).
• Kõlves K, Sisask M, Värnik P, Värnik A, De Leo D, editors. Advancing suicide research. Göttingen: Hogrefe; 2021.
• Platt S, Arensman E, Rezaeian M. National suicide prevention strategies–progress and challenges. Crisis. 2019;40:75–82(https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1027/0227-5910/a000587, accessed 1 January 2021).
• Project/programme monitoring and evaluation guide. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; 2011 (https://jordankmportal.com/resources/ifrc-monitoring-and-evaluation-guide-2011, accessed 1 January 2021).
• RAND suicide prevention evaluation toolkit. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center; 2014 (http://www.sprc.org/resources-programs/rand-suicide-prevention-evaluation-toolkit, accessed 1 January 2021).

限制自杀手段可及性

WHO 资源

• Clinical management of acute pesticide intoxication: prevention of suicidal behaviours. Geneva: World Health Organization; 2008 (https://www.who.int/mental_health/publications/9789241596732/en/, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a resource for pesticide registrars and regulators. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/publications-detail/preventing-suicide-a-resource-for-pesticide-registrars-and-regulators, accessed 1 January 2021).
• Restricting access to the means for suicide. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/pesticides/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Centre for Pesticide Suicide Prevention. Edinburgh, Scotland (http://centerpsp.org/, accessed 1 January 2021).
• Eddleston M, Karalliedde L, Buckley N, Fernando R, Hutchinson G, Isbister G et al. Pesticide poisoning in the developing world—a minimum pesticides list. Lancet. 2002;360(9340):1163–7 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12387969/, accessed 1 January 2021).
• Emergency department means restriction education. London: Public Health England; 2015 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/769006/Preventing_suicides_in_public_places.pdf, accessed January 2021).
• Guidelines on highly hazardous pesticides. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205561/9789241510417_eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).
• Technical Guidelines for the implementation of the International Code of Conduct on Pesticide management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/listguide-new/en/, accessed 1 January 2021).
• Gunnell D, Knipe D, Chang SS, Pearson M, Konradsen F, Lee WJ et al. Prevention of suicide with regulations aimed at restricting access to highly hazardous pesticides: a systematic review of the international evidence. Lancet Glob Health.2017;5(10):e1026–37 (https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30299-1/fulltext, accessed 1 January 2021).
• Lethal means & suicide prevention: a guide for community & industry leaders. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention (https://theactionalliance.org/resource/lethal-means-suicide-prevention-guide-community-industry-leaders,accessed 1 January 2021).
• Limits on analgesic packaging. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Centre; 2005 (http://www.sprc.org/resourcesprograms/reduced-analgesic-packaging, accessed 1 January 2021).
• Means matter. Boston (MA): Harvard School of Public Health (https://www.hsph.harvard.edu/means-matter/, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide in public places. London: Public Health England (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/769006/Preventing_suicides_in_public_places.pdf, accessed 1 January 2021).
• Reduce access to means of suicide. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center, USA (http://www.sprc.org/comprehensive-approach/reduce-means, accessed 1 January 2021).

• Reduce suicides by creating a safer home. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2019-12/means_safety_eng.pdf, accessed 1 January 2021).

与媒体互动促其负责任地报道自杀

WHO 资源

• Preventing suicide: a resource for filmmakers and others working on stage and screen. Geneva: World Health Organization;2019 (https://www.who.int/publications-detail/preventing-suicide-a-resource-for-filmmakers-and-others-working-on-stage-andscreen, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a resource for media professionals. Geneva: World Health Organization; update 2017 (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Best practice recommendations for media reporting on suicide. Bloomington (MN): Suicide Awareness Voices of Education(SAVE) (https://reportingonsuicide.org, accessed 1 January 2021).

• Best practice recommendations for blogging on suicide. Bloomington (MN): Suicide Awareness Voices of Education (SAVE) (https://bloggingonsuicide.org, accessed 1 January 2021).

• Evaluation of media reporting in Trinidad and Tobago. Ministry of Health, Trinidad and Tobago (https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=monitoring-and-evaluation-of-media-reporting-suicide-in-trinidad-andtobago&Itemid=270&lang=es, accessed 1 January 2021).

• Evidence-based media reporting guide. Mindframe, Newcastle, Australia (mindframe.org.au/suicide/evidence-research,accessed 1 January 2021).

• Example media guidelines from countries. International Association for Suicide Prevention (https://www.iasp.info/resources/Suicide_and_the_Media/https://www.iasp.info/resources/Suicide_and_the_Media/, accessed 1 January 2021).

• How journalists can prevent copycat suicides. Frankfurt am Main: European Alliance Against Depression; 2017 (http://www.eaad.net/files/cms/downloads_files/mediaguide_2017.pdf, accessed 1 January 2021).

• Let's talk about suicide and the media. Koper, Slovenia (https://www.iam.upr.si/sl/resources/files/ivzknjizica2010web-final.pdf, accessed 1 January 2021).

• Media guidelines. Ottawa: Canadian Association for Suicide Prevention (https://suicideprevention.ca/Media?locale=en,accessed 1 January 2021).

• Media messaging. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention (https://theactionalliance.org/news,accessed 1 January 2021).

• Mindset: reporting on mental health. London: Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma (http://www.mindsetmediaguide.ca/, accessed 1 January 2021).

• Mindset guidelines for reporting on mental health. London: Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma (https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/mindset-mediaguide-ca/mindset-download, accessed 1 January 2021).

• Pirkis J, Blood RW, Dare A, Holland K. The media monitoring project: changes in media reporting of suicide and mental health and illness in Australia: 2000/01–2006/07. Commonwealth of Australia; 2008:4.
• Project Siren. India Mental Health Observatory (https://cmhlp.org/imho/about-project-siren, accessed 1 January 2021).
• Roškar S, Grum AT, Poštuvan V, Podlesek A, De Leo D. The adaptation and implementation of guidelines for responsible media reporting on suicide in Slovenia: Priredba in implementacija strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru v sloveniji. Slovenian Journal of Public Health. 2017;56(1):31–38 (http://zivziv.si/wp-content/uploads/The-adaptationand-implementation-of-guidelines.pdf, accessed 1 January 2021).
• Suicide prevention toolkit for media professionals. European Union: European Regions Enforcing Action Against Suicide (https://www.euregenas.eu/publications/, accessed 1 January 2021).
• Suicide reporting toolkit (https://www.suicidereportingtoolkit.com/, accessed 1 January 2021).

培养青少年的生活情感生活技能

WHO 资源

• Guidelines on promotive and preventive interventions for adolescents (Helping Adolescents Thrive). Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-foradolescents, accessed 1 January 2021).
• mhGAP guidelines. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/en/,accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a resource for teachers and other school staff. Geneva: World Health Organization; 2000 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66801/WHO_MNH_MBD_00.3.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Aunty Dee. Auckland: LeVa (https://www.auntydee.co.nz/, accessed 1 January 2021).
• Building suicide-safer schools and colleges. Warrington, United Kingdom: PAPYRUS (https://papyrus-uk.org/wp-content/uploads/2018/08/toolkitfinal.pdf, accessed 1 January 2021).
• Enhance life skills and resilience. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/comprehensive-approach/life-skills, accessed 1 January 2021).
• Hope Squad. Provo (UT) (https://hopesquad.com/, accessed 1 January 2021).
• iBobbly. Randwick, Australia: Black Dog Institute (https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/digital-tools-apps/ibobbly/, accessed 1 January 2021).
• Mana Restore. Mental Wealth. Auckland: LeVa LeVa (https://www.mentalwealth.nz/manarestore/, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide toolkit for high schools. Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration (https://store.samhsa.gov/product/Preventing-Suicide-A-Toolkit-for-High-Schools/SMA12-4669, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a technical package of policy, programs, and practices. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2017 (https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicideTechnicalPackage.pdf, accessed 1 January 2021).

• Schools. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/settings/schools, accessed 1 January 2021).

• School-based suicide prevention, intervention, and postvention toolkit. European Union: European Regions Enforcing Actions Against Suicide (https://www.euregenas.eu/publications/, accessed 1 January 2021).

• Sources of strength. Lakewood (CO) (https://sourcesofstrength.org/, accessed 1 January 2021).

• Suicide postvention toolkit: a guide for secondary schools. Headspace, Australia (https://headspace.org.au/assets/School-Support/Compressed-Postvention-Toolkit-May-2012-FA2-LR.pdf, accessed 1 January 2021).

• The Saving and Empowering Young Lives in Europe programme. Stockholm: Karolinska Institutet (https://ki.se/en/nasp/seylesaving-and-empowering-young-lives-in-europe, accessed 1 January 2021).

• Wasserman C, Hoven CW, Wasserman D, Carli V, Sarchiapone M, Al-Halabi S et al. Suicide prevention for youth-a mental health awareness program: lessons learned from the Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) intervention study. BMC Public Health. 2012;12(1):776 (http://zivziv.si/wp-content/uploads/2012suicidepreventionforyouth.pdf, accessed 1 January 2021).

• Wasserman C, Postuvan V, Herta D, Iosue M, Värnik P, Carli V. Interactions between youth and mental health professionals:The Youth Aware of Mental health (YAM) program experience. PloS One. 2018;13(2):e0191843 (http://zivziv.si/wp-content/uploads/Wasserman-idr.-2018-Interactions-betwween-youth-and-mental-health-professionals.pdf, accessed 1 January 2021).

• LEADS: For Youth (Linking Education and Awareness of Depression and Suicide). Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://sprc.org/resources-programs/leads-youth-linking-education-awareness-depression-suicide, accessed 1 January 2021).

早期识别、评估、管理和随访受自杀行为影响的人

WHO 资源

• How to start a survivor's group. Geneva: World Health Organization; 2008 (https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_survivors.pdf, accessed 1 January 2021).

• mhGAP Intervention Guide, version 2.0. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, accessed 1 January 2021).

• mhGAP operations manual. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/mental_health/mhgap/operations_manual/en/, accessed 1 January 2021).

• mhGAP Training manuals. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a resource for establishing a crisis line. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1, accessed 1 January 2021).

• Preventing suicide: a resource for general physicians. Geneva: World Health Organization; 2000 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67165/WHO_MNH_MBD_00.1.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).
• Preventing suicide: a resource for primary health care workers. Geneva: World Health Organization; 2000 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67603/WHO_MNH_MBD_00.4.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

外部资源

• Brodsky BS, Spruch-Feiner A, Stanley B. The zero suicide model: applying evidence-based suicide prevention practices to clinical care. Front Psychiatry. 2018;9:33 (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00033/full, accessed 1 January 2021).
• Care after a suicide attempt. Randwick, Australia: Black Dog Institute (https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/careafterasuicideattempt02-09-15.pdf, accessed 1 January 2021).
• Establishing and sustaining a support group for people bereaved by suicide. European Union: European Regions Enforcing Action Against Suicide (https://www.euregenas.eu/publications/, accessed 1 January 2021).
• Guidelines for integrated suicide-related crisis and follow-up care in emergency departments and other acute settings. Randwick, Australia: Black Dog Institute (http://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/delphi-guidelinesclinical-summary_web.pdf?sfvrsn=0, accessed 1 January 2021).
• Improving emergency and follow-up care for suicidal crisis. Randwick, Australia: Black Dog Institute (https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/LifeSpan_Emergency_and_followup_care_Brochure.pdf?sfvrsn=6,accessed 1 January 2021).
• A systematic tailored assessment for responding to suicidality (STARS). Brisbane: Griffith University (https://www.griffith.edu.au/griffith-health/australian-institute-suicide-research-prevention/systematic-tailored-assessment-for-responding-tosuicidality#:~:text=STARS%20is%20a%20person%2Dcentred,examination%20of%20suicidality%20as%20necessary,accessed 28 January 2021).
• Postvention Australia Guidelines: a resource for organisations and individuals providing services to people bereaved bysuicide. Brisbane: Australian Institute for Suicide Research and Prevention (https://postventionaustralia.org/wp-content/uploads/2019/05/Postvention-Australia-Guidelines.pdf, accessed 1 January 2021).
• Recommended standard care for people at risk of suicide. Washington (DC): National Action Alliance for Suicide Prevention(https://theactionalliance.org/resource/recommended-standard-care, accessed 1 January 2021).
• Resources for postvention support. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (http://www.sprc.org/comprehensive-approach/postvention, accessed 1 January 2021).
• Survivor Outreach Team training manual. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center, USA (http://www.sprc.org/resources-programs/survivor-outreach-team-training-manual, accessed 1 January 2021).

• Toolkit for the integration of mental health into general healthcare in humanitarian settings. Geneva & London: Mental Health Innovation Network (https://www.mhinnovation.net/collaborations/IMC-Mental-Health-Integration-Toolkit, accessed 1 January 2021).
• While D, Bickley H, Roscoe A, Windfuhr K, Rahman S, Shaw J et al. Implementation of mental health service recommendations in England and Wales and suicide rates, 1997–2006: a cross-sectional and before-and-after observational study. Lancet. 2012;379(9820):1005–12 (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61712-1/fulltext, accessed 1 January 2021).
• Zero suicide. Education Development Center, USA (https://zerosuicide.edc.org/, accessed 1 January 2021).

参考文献

Abbas MJ, Alhemiary N, Razaq EA, Naosh S, Appleby L (2018). The Iraqi national study of suicide: Report on suicide data in Iraq in 2015 and 2016. J Affect Disord. 229:56–62.

Ahern S, Burke LA, McElroy B, Corcoran P, McMahon EM, Keeley H et al. (2018). A cost-effectiveness analysis of school-based suicide prevention programmes. Eur Child Adolesc Psychiatry. 27(10):1295–304.

Bertolote JM, Fleischmann A (2002). A global perspective in the epidemiology of suicide. Suicidologi. 7(2).

Bonvoisin T, Utyasheva L, Knipe D, Gunnell D, Eddleston M (2020). Suicide by pesticide poisoning in India: a review of pesticide regulations and their impact on suicide trends. BMC Pub Health. 20(1):251.

Buckley NA, Fahim M, Raubenheimer J, Gawarammana IB, Eddleston M, Roberts MS et al. (2021). Case fatality of agricultural pesticides after self-poisoning in Sri Lanka: a prospective cohort study. Lancet Glob Health (in press).

Burns JR, Rapee RM (2006). Adolescent mental health literacy: young people's knowledge of depression and help seeking. J Adolesc. 29(2):225–39.

Chapman S, Alpers P, Agho K, Jones M (2006). Australia's 1996 gun law reforms: faster falls in firearm deaths, firearm suicides, and a decade without mass shootings. Injury Preven. 12(6):365–72.

Chibanda D, Abas M, Musesengwa R, Merritt C, Sorsdahl K, Mangezi W et al. (2020). Mental health research capacity building in sub-Saharan Africa: the African Mental Health Research Initiative. Glob Ment Health. 7.

Chowdhury FR, Dewan G, Verma VR, Knipe DW, Isha IT, Faiz MA et al. (2018). Bans of WHO class I pesticides in Bangladesh—suicide prevention without hampering agricultural output. Int J Epi. 47(1):175–84.

Chung YW, Kang SJ, Matsubayashi T, Sawada Y, Ueda M (2016). The effectiveness of platform screendoors for the prevention of subway suicides in South Korea. J Affect Disord. 194:80–3.

Cwik MF, Tingey L, Maschino A, Goklish N, Larzelere-Hinton F, Walkup J et al. (2014). Community-based surveillance and case management for suicide prevention: an American Indian tribally initiated system. Am J Public Health. 104(Suppl3):e18–23.

Cwik MF, Barlow A, Goklish N, Larzelere-Hinton F, Tingey L, Craig M et al. (2016). Decreases in suicide deaths and attempts linked to the White Mountain Apache suicide surveillance and prevention system, 2001–012. Am J Public Health. 106(12):2183–9.

Dawson AH, Eddleston M, Senarathna L, Mohamed F, Gawarammana I, Bowe SJ et al. (2010). Acute human lethal toxicity of agricultural pesticides: a prospective cohort study. PLoS Med. 7(10):e1000357.

Doran CM, Ling R, Gullestrup J, Swannell S, Milner A (2016). The impact of a suicide prevention strategy on reducing the economiccost of suicide in the New South Wales construction industry. Crisis. 37(2):121–9.

Fontanella CA, Warner LA, Steelesmith DL, Brock G, Bridge JA, Campo JV (2020). Association of timely outpatient mental health services for youths after psychiatric hospitalization with risk of death by suicide. JAMA Network Open. 3(8):e2012887.

FAO, WHO (2016). International code of conduct on pesticide management: guidelines on highly hazardous pesticides. Rome & Geneva: Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization (http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf), accessed 23 February 2021).

Godoy Garraza L, Kuiper N, Goldston D, McKeon R, Walrath C (2019). Long-term impact of the Garrett Lee Smith Youth Suicide Prevention Program on youth suicide mortality, 2006–2015. J Child Psychol Psychiatry. 60(10):1142–7. doi:10.1111/jcpp.13058.

Goldman-Mellor S, Olfson M, Lidon-Moyano C, Schoenbaum M (2019). Association of suicide and other mortality with emergency department presentation. JAMA Network Open. 2(12):e1917571.

Gullestrup JB, Lequertier G, Martin (2011). MATES in construction: impact of a multimodal, community-based program for suicide prevention in the construction industry. Int J Environ Res Pub Health. 8(11):4180–96.

Gunnell D, Bennewith O, Hawton K, Simkin S, Kapur N (2005). The epidemiology and prevention of suicide by hanging: a systematic review. Int J Epidemiol. 34(2):433–42.

Gunnell D, Fernando R, Hewagama M, Priyangika WDD, Konradsen F, Eddleston M (2007). The impact of pesticide regulations on suicide in Sri Lanka. Int J Epidemiol. 36(6):1235–42.

Gunnell D, Knipe D, Chang SS, Pearson M, Konradsen F, Lee WJ et al. (2017). Prevention of suicide with regulations aimed at restricting access to highly hazardous pesticides: a systematic review of the international evidence. Lancet Glob Health. 5(10):e1026–37.

Gunnell D, Appleby L, Arensman E, Hawton K, John A, Kapur N et al. (2020). Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 7(6):468–71.

Harris FM, Maxwell M, O'Connor R, Coyne JC, Arensman E, Coffey C et al. (2016). Exploring synergistic interactions and catalysts in complex interventions: longitudinal, mixed methods case studies of an optimised multi-level suicide prevention intervention in four European countries (Ospi-Europe). BMC Pub Health. 16(1):268.

Haw C, Sutton L, Simkin S, Gunnell D, Kapur N, Nowers M et al. (2004). Suicide by gunshot in the United Kingdom: a review of the literature. Med Sci Law. 44(4):295–310.

Hawton K, Bergen H, Simkin S, Brock A, Griffiths C, Romeri E et al. (2009). Effect of withdrawal of co-proxamol on prescribing and deaths from drug poisoning in England and Wales: time series analysis. BMJ. 338:b2270.

Hawton K, Townsend E, Deeks J, Appleby L, Gunnell D, Bennewith O (2001). Effects of legislation restricting pack sizes of paracetamol and salicylate on self-poisoning in the United Kingdom: before and after study. BMJ. 322(7296):1203–7. doi:10.1136/bmj.322.7296.1203.

Heller TS, JL Hawgood, De Leo D (2007). Correlates of suicide in building industry workers. Arch Suicide Res. 11(1):105–17.

Karunarathne A, Gunnell D, Konradsen F, Eddleston M (2020). How many premature deaths from pesticide suicide have occurred since the agricultural Green Revolution?. Clin Tox, 58(4), 227–232.

Kasal A, Bechyňová L, Daňková Š, Melicharová H, Winkler P (2019). Situation analysis of suicide prevention in the Czech Republic: a background document for the National Plan for Suicide Prevention 2020–2030 (https://www.nudz.cz/files/pdf/situation-analysis-ofsuicide-prevention-in-the-czech-republic_december_2019_fin_1.pdf, accessed 1 January 2021).

Khan MM, Reza H (1998). Gender differences in nonfatal suicidal behavior in Pakistan: significance of sociocultural factors. Suicide Life Threat Behav. 28(1):62–8.

Knipe DW, Chang SS, Dawson A, Eddleston M, Konradsen F, Metcalfe C et al. (2017). Suicide prevention through means restriction: impact of the 2008-2011 pesticide restrictions on suicide in Sri Lanka. PloS One. 12(3)–e0172893.

Knipe DW, Gunnell D, Eddleston M (2017). Preventing deaths from pesticide self-poisoning – learning from Sri Lanka's success. Lancet Glob Health. 5(7):e651–2.

Kolves K, Sisask M, Vänik P, Vänik A, De Leo D (2021). Advancing suicide research. Götingen: Hogrefe.

Kreitman N (1976). The coal gas story. United Kingdom suicide rates, 1960–1. Br J Prev Soc Med. 30(2):86–93.

Law C, Sveticic J, De Leo D (2014). Restricting access to a suicide hotspot does not shift the problem to another location. An experiment of two river bridges in Brisbane, Australia. Aust N Z J Public Health. 38(2):134–8.

Lee YY, Chisholm D, Eddleston M, Gunnell D, Fleischmann A, Konradsen F et al. (2021). The cost-effectiveness of banning highly hazardous pesticides to prevent suicides due to pesticide self-ingestion across 14 countries: an economic modelling study. Lancet Glob Health. Mar;9(3):e291-e300.

Leong YH, Ariff AM, Khan HRM, Rani NAA, Majid MIA (2018). Paraquat poisoning calls to the Malaysia National Poison Centre following its ban and subsequent restriction of the herbicide from 2004 to 2015. J Forensic Leg Med. 56:16–0. doi:10.1016/j.jflm.2018.03.007.

Levintova M (2007). Russian alcohol policy in the making. Alcohol Alcohol. 42(5):500–5.

Liu KY (2009). Suicide rates in the world: 1950–004. Suicide Life Threat Behav. 39(2):204–13.

Lubin G, Werbeloff N, Halperin D, Shmushkevitch M, Weiser M, Knobler HY (2010). Decrease in suicide rates after a change of policy reducing access to firearms in adolescents: a naturalistic epidemiological study. Suicide Life Threat Behav. 40(5):421–4.

Manuweera G, Eddleston M, Egodage S, Buckley NA (2008). Do targeted bans of insecticides to prevent deaths from self-poisoning result in reduced agricultural output? Environ Health Perspect. 116(4):492–5.

Mew EJ, Padmanathan P, Konradsen F, Eddleston M, Chang SS, Phillips MR et al. (2017). The global burden of fatal self-poisoning with pesticides 2006–5: systematic review. J Affect Disord. 219:93–04.

Milin R, Kutcher S, Lewis SP, Walker S, Wei Y, Ferrill N et al. (2016). Impact of a mental health curriculum on knowledge and stigma among high school students: a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 55(5):383–91.

Namibian Ministry of Health and Social Services (2018). National Study on the Prevalence of and Interventions in Relation to Suicide in Namibia (http://namibie.ngkerk.net/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/FINAL-Suicide-Study-Report-V5-25-October-2018FINAL.pdf, accessed 1 January 2021).

Niederkrotenthaler T, Reidenberg DJ, Till B, Gould MS (2014). Increasing help-seeking and referrals for individuals at risk for suicide by decreasing stigma: the role of mass media. Am J Prev Med. 47(3 Suppl 2):S235–43.

Niederkrotenthaler T, Braun M, Pirkis J, Till B, Stack S, Sinyor M et al. (2020). Association between suicide reporting in the media and suicide: systematic review and meta-analysis. BMJ. 368.

Oliver RG, Hetzel BS (1972). Rise and fall of suicide rates in Australia: relation to sedative availability. Med J Aust. 2(17):919–23. PMID: 4639963.

PAHO (2014). Mortalidad por suicidio en las Américas: Informe regional (Suicide mortality in the Americas. Regional report). Washington (DC): Pan American Health Organization.

PAHO (2016). Prevención de la conducta suicida (Prevention of suicidal behaviour). Washington (DC): Pan American Health Organization.

Pearson M, Zwi AB, Buckley NA (2010). Prospective policy analysis: how an epistemic community informed policymaking on intentional self-poisoning in Sri Lanka. Health Res Pol Syst. 8(1):19.

Pearson M, Zwi AB, Buckley NA, Manuweera G, Fernando R, Dawson AH et al. (2015). Policymaking “under the radar”: a case study of pesticide regulation to prevent intentional poisoning in Sri Lanka. Health Policy Plan. 30(1):56–7.

Pearson M, Metcalfe C, Jayamanne S, Gunnell D, Weerasinghe M, Pieris R et al. (2017). Effectiveness of household lockablepesticide storage to reduce pesticide self-poisoning in rural Asia: a community-based, cluster-randomised controlled trial. Lancet. 390(10105):1863–72.

Reifels L, Mishara BL, Dargis L, Vijayakumar L, Phillips MR, Pirkis J (2019). Outcomes of Community-Based Suicide Prevention Approaches That Involve Reducing Access to Pesticides: A Systematic Literature Review. Suicide Life Threat Behav, 49(4):1019–1031.

Reisch T, Steffen T, Habenstein A, Tschacher W (2013). Change in suicide rates in Switzerland before and after firearm restriction resulting from the 2003 "Army XXI" reform. Am J Psychiatry. 170(9):977–84.

Rošar S, Grum AT, Pošuvan V, Podlesek A, De Leo D (2017). The adaptation and implementation of guidelines for responsible media reporting on suicide in Slovenia (Priredba in implementacija strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročnje o samomoru v loveniji). Slovenian J Pub Health. 56(1):31–8.

Sanchez Puerta ML, Valerio A, Bernal MG (2016). Taking stock of programs to develop socioemotional skills: A systematic review of program evidence. Washington (DC): The World Bank.

Siau CS, Wee LH, Ibrahim N, Visvalingam U, Yeap LLL, Wahab S (2018). Gatekeeper suicide training's effectiveness among Malaysian hospital health professionals: a control group study with a three-month follow-up. J Contin Educ Health Prof. 38(4):227–34

Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M (2009). The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet: 374(9686):315–23.

Syed EU, Khan MM (2008). Pattern of deliberate self-harm in young people in Karachi, Pakistan. Crisis. 29(3):159–63.

Terpstra S, Beekman A, Abbing J, Jaken S, Steendam M, Gilissen R (2018). Suicide prevention gatekeeper training in the

Netherlands improves gatekeepers' knowledge of suicide prevention and their confidence to discuss suicidality, an observationalstudy. BMC Public Health. 18:637.

Thomas K, Chang SS, Gunnell D (2011). Suicide epidemics: the impact of newly emerging methods on overall suicide rates-a time trends study. BMC Public Health. 11(1):314.

Tighe J, Shand F, Ridani R, Mackinnon A, De La Mata N, Christensen H (2017). Ibobbly mobile health intervention for suicide prevention in Australian Indigenous youth: a pilot randomised controlled trial. BMJ Open. 7(1):e013518.

Tighe J, Shand F, McKay K, Mcalister TJ, Mackinnon A, Christensen H (2020). Usage and acceptability of the iBobbly App: pilot trial for suicide prevention in Aboriginal and Torres Strait Islander youth. JMIR Ment Health. 7(12):e14296.

Tuangratananon T, Wangmo S, Widanapathirana N, Pongutta S, Viriyathorn S, Patcharanarumol W et al. (2019). Implementation of national action plans on noncommunicable diseases, Bhutan, Cambodia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam. Bull World Health Organ. 97(2).

Victor J, Koon JHG, Govindaraju GM, Ling TP, Rajaratnam UD, Fong Y L (2019). Media reporting of suicide: a comparative framing analysis of Malaysian newspapers. SEARCH Journal of Media and Communication Research. 11(2):73–88.

Vijayakumar L, Mohanraj R, Kumar S, Jeyaseelan V, Sriram S, Shanmugam M (2017). CASP –An intervention by community volunteers to reduce suicidal behaviour among refugees. Int J Soc Psychiatry. 63(7):589–97.

Vijayakumar L (2019). Media matters in suicide – Indian guidelines on suicide reporting. Indian J Psychiatry. 61(6):549.

Vijayakumar L, Pathare S, Jain N, Nardodkar R, Pandit D, Krishnamoorthy S et al. (2020). Implementation of a comprehensive surveillance system for recording suicides and attempted suicides in rural India. BMJ Open. 10(11):e038636.

Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, Wall M, Eisenberg R, Hadlaczky G et al. (2015). School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. Lancet. 385(9977):1536–44.

Wasserman C, Postuvan V, Herta D, Iosue M, Värnik P, Carli V (2018). Interactions between youth and mental health professionals: The Youth Aware of Mental health (YAM) program experience. PloS One. 13(2):e0191843.

Weiner BJ (2020). A theory of organizational readiness for change. In: Nilsen P, Birken SA, editors. Handbook on implementation science. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

While D, Bickley H, Roscoe A, Windfuhr K, Rahman S, Shaw J et al. (2012). Implementation of mental health service recommendations in England and Wales and suicide rates, 1997–2006: a cross-sectional and before-and-after observational study. Lancet. 379(9820):1005–12.

WHO (2008a). Clinical management of acute pesticide intoxication: prevention of suicidal behaviours. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/pesticides_intoxication.pdf, accessed 1 January 2021).

WHO (2008b). Preventing suicide: how to start a survivors' group. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44801/9789241597067_eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

WHO (2010). Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/9789241599931, accessed 28 January 2021).

WHO (2011). Preventing suicide: a resource for suicide case registration. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44757/9789241502665_eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

WHO (2012). Public health action for the prevention of suicide: a framework. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75166/9789241503570_eng.pdf;jsessionid=076C64B4C897BDFBD746E58238E8CE23?sequence=1, accessed 23 February 2021).

WHO, UNHCR (2012). Assessing mental health and psychosocial needs and resources: toolkit for humanitarian settings. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76796/9789241548533_eng.pdf?sequence=1, accessed 23 February 2021).

WHO (2013). Building back better: sustainable mental health care after emergencies. Geneva: World Health Organization (https:// www.who.int/mental_health/emergencies/building_back_better/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2014). Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/ suicide-prevention/world_report_2014/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2015). mhGAP humanitarian intervention guide (mhgap-hig): clinical management of mental, neurological and substance

use conditions in humanitarian emergencies. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2016a). Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/attempts_surveillance_systems/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2016b). Problem Management Plus (PM+): individual psychological help for adults impaired by distress in communities exposed to adversity. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/emergencies/problem_management_plus/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2017). Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2017. Geneva, World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-eng.pdf?sequence=1, accessed 1 January 2021).

WHO (2018a). National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/national_strategies_2019/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2018b). mhGAP operations manual (guide to scaling up mental health services in non-specialized health settings to achieve universal health coverage). Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/operations_manual/en/, accessed 23 February 2021).

WHO (2018c). Preventing suicide: a resource for establishing a crisis line. Geneva: World Health Organization. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1, accessed 1 January 2021)

WHO (2018d). Preventing suicide: a community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/suicide-prevention-toolkit-for-engaging-communities, accessed 28 January 2021).

WHO (2018e). Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639, accessed 28 January 2021).

WHO (2019a). Preventing suicide: a resource for filmmakers and others working on stage and screen. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications-detail/preventing-suicide-a-resource-for-filmmakers-and-others-working-on-stageand-screen, accessed 1 January 2021).

WHO (2019b). mhGAP Intervention Guide – Version 2.0. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, accessed 23 February 2021).

WHO, FAO (2019). Preventing suicide: a resource for pesticide registrars and regulators. Geneva & Rome: World Health Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations (https://apps.who.int/iris/handle/10665/326947, accessed 23 February 2021).

WHO (2020). Helping adolescents thrive. Guidelines on promotive and preventive mental health interventions for adolescents.

Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336864/9789240011854-eng.pdf, accessed 24 February 2021).

WHO (2021). Menu of cost-effective interventions for mental health. Geneva: World Health Organization (in press).

Yip PSF, Caine E, Yousuf S, Chang SS, Wu KCC, Chen YY (2012). Means restriction for suicide prevention. Lancet.379(9834):2393–9.

Yip PSF, Tang L (2021). Public health approach to suicide research. In: Kolves K, Sisask M, Värnik P, Värnik A, De Leo D, editors. Advancing suicide research. Göttingen: Hogrefe.

Zakiullah N, Saleem S, Sadiq S, Sani N, Shahpurwala M, Shamim A et al. (2008). Deliberate self-harm: characteristics of patients presenting to a tertiary care hospital in Karachi, Pakistan. Crisis. 29(1):32–7.

LIVE LIFE

核心支柱：

情况分析

多部门合作

提高意识

能力建设

财政支持

监测、监控和评估

关键的有效循证干预措施：

L：限制自杀手段可及性

I：与媒体互动促其负责任地报道自杀

F：培养青少年生活技能

E：早期识别和支持受影响的人



北京回龙观医院

北京心理危机研究与干预中心

2022 年 9 月